BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

COURS



CHAPITRE

03

Éléments de psychologie sociale

Psychologie | Sociologie | Anthropologie de l'alimentation

DANS CE VOLUME

- ✓ Cours structuré
- ✓ Schémas en couleur
- ✓ Auto-tests corrigés
- ✓ Fil rouge des Tilleuls

Sommaire

3.1 Compétences mobilisées 4

3.2 Croisement référentiel × précisions × indications 4

3.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025 5

3.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED 5

3.3 Cours 6

3.3.1 Psychologie, sociologie, anthropologie : trois regards sur le mangeur 7

3.3.2 Identité individuelle et sociale ; socialisation 10

3.3.3 Représentations, normes, valeurs ; culture et interculturalité 14

3.3.4 La relation sociale et ses dynamiques 20

3.3.5 Les compétences psychosociales 28

3.3.6 Image corporelle, émotions, estime de soi 31

3.3.7 Connaître les publics et comprendre le changement de comportement 34

3.3.8 Communiquer et écouter : les bases de la relation éducative 42

3.3.9 L'esprit de l'entretien motivationnel appliqué au collectif 45

3.3.10 Animer un groupe : étapes, rôles et styles d'animation 49

3.3.11 La motivation et les biais de décision 54

3.3.12 Mesurer attitudes et représentations 57

3.3.13 Un modèle intégrateur : COM-B et la roue du changement de comportement 61

3.3.14 Adapter l'approche psychosociale aux publics 65

3.3.15 Concevoir une séance qui développe les compétences psychosociales en nutrition 67

3.3.16 Fil rouge : les représentations et les dynamiques du groupe des Tilleuls 68

3.3.17 Trois cas guidés pour s'entraîner à l'analyse psychosociale 68

3.4 Approfondissements 71

3.4.1 Néophobie alimentaire et exposition répétée 71

3.4.2 Les normes sociales comme levier 72

3.4.3 L'influence des réseaux sociaux 73

3.4.4 La pair-éducation et les personnes relais 74

3.4.5 La motivation des enfants et des adolescents 75

3.4.6 Les émotions dans l'apprentissage 76

3.4.7 Précarité alimentaire : honte, dignité et pouvoir d'agir 77

3.4.8 Le numérique dans l'accompagnement du changement 77

3.4.9 Les personnes âgées : vieillissement, isolement et plaisir de manger 78

3.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3 79

3.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles 80

Méthode 1 – Justifier un choix d'animation par un modèle, à l'oral 81

Méthode 2 – Analyser une situation de groupe en quatre questions 81

Méthode 3 – Quinze affirmations à corriger avant l'épreuve 81

3.7 L'essentiel à retenir 83

3.8 Entraînement 84

3.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses) 84

3.8.2 Exercices 85

3.8.3 Questions de réflexion 89

3.8.4 Étude de cas 89

3.8.5 Mises en situation express 90

3.8.6 Exercices complémentaires 92

3.9 Glossaire 94

3.10 Renvois bibliographiques par notion 95

3.12 Bibliographie numérotée..... 95

Objectifs du chapitre (référentiel)

À la fin de ce chapitre, vous devez être capable de :

- définir la psychologie, la sociologie et l'anthropologie et montrer ce que chacune apporte à la compréhension des comportements alimentaires ;
- définir l'identité individuelle et sociale, la socialisation primaire et secondaire, et les appliquer à l'alimentation ;
- définir les représentations sociales, les normes, les valeurs et les attitudes ;
- définir la culture, identifier des différences culturelles et expliquer l'interculturalité et l'acculturation (spontanée et planifiée) ;
- décrire les dynamiques d'une relation sociale et d'un groupe (influence, conformisme, engagement) ;
- définir les compétences psychosociales et proposer des activités pour les développer ;
- définir l'image corporelle, l'insatisfaction corporelle, les émotions, l'estime de soi et la confiance en soi, et en tenir compte dans une action ;
- connaître les spécificités des publics et les principaux modèles du changement de comportement ;
- relier ces savoirs à vos propres observations et interroger votre propre système de valeurs (objectif du guide 2025).

3.1 Compétences mobilisées

Compétence	Ce que le chapitre apporte	Indicateurs du référentiel travaillés
C3.1	Comprendre les publics et les ressorts du changement pour concevoir des actions adaptées et non stigmatisantes	Priorités et objectifs adaptés au contexte ; règles éthiques respectées
C3.2	Adapter un atelier culinaire aux cultures, aux âges et aux émotions liées à l'alimentation	Besoins, objectifs et spécificités du public identifiés ; méthodes d'animation appropriées
C3.5	Animer un groupe, mobiliser l'écoute active, gérer les dynamiques et les émotions	Techniques d'animation et posture adaptées ; capacités d'écoute active mobilisées

3.2 Croisement référentiel × précisions × indications

Notion (guide 2025)	Objectifs pour l'apprenant	Limites et attendus
Psychologie, sociologie, anthropologie	Définir et distinguer ; citer des apports à l'alimentation	Connaître quelques auteurs repères (Fischler, Poulain, Lewin)
Identité individuelle et sociale	Définir ; exemples alimentaires	Pas de théorie de la personnalité
Compétences psychosociales	Définir, classer (cognitives, émotionnelles, sociales), proposer des activités	Référentiel Santé publique France 2022
Représentations, normes, valeurs	Définir, recueillir et utiliser les représentations d'un public	Méthodes de recueil (photolangage, associations libres)
Culture, interculturalité, acculturation	Identifier les différences culturelles ; adopter une posture interculturelle	Modèle de Berry ; acculturation spontanée et planifiée
Relation sociale, socialisation	Décrire les dynamiques ; rôle de la famille, de l'école, des pairs	Expérience de Lewin, conformisme, engagement
Image corporelle, émotions, estime de soi	Définir ; repérer les risques (stigmatisation, restriction)	Orientation si troubles du comportement alimentaire (BC1)

Notion (guide 2025)	Objectifs pour l'apprenant	Limites et attendus
Connaissance des publics	Adapter l'action à l'âge, la culture, la précarité, le handicap	Modèles du changement : HBM, Prochaska, Ajzen, Bandura

3.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025

Le chapitre a été vérifié par rapport au référentiel du BTS (arrêté publié au *Journal officiel* du 17 décembre 2024 : bloc 3, savoirs « Éléments de psychologie sociale ») et au guide d'accompagnement pédagogique de 2025 (p. 60 et 61). Les dates et les valeurs ont été comparées à la dernière version des sources au 26 octobre 2026 ; les corrections sont signalées dans l'encadré « Attention » de la section 3.2.2.

Texte	Critère ou indication	Où dans ce cours
Guide 2025, p. 60-61	Définitions : psychologie, sociologie, anthropologie	3.3.1 (trois regards, fondateurs à connaître)
Guide 2025, p. 61	Identité individuelle et sociale ; socialisation primaire et secondaire	3.3.2 (dont identité collective, déviance)
Guide 2025, p. 61	Représentations, normes, valeurs ; culture, interculturalité, acculturation spontanée et planifiée	3.3.3
Guide 2025, p. 61	Relation sociale et ses dynamiques	3.3.4 (influence, attitudes, stéréotypes, communication, rumeurs) ; 3.3.10
Guide 2025, p. 61	Compétences psychosociales et leur développement	3.3.5 et 3.3.15 (référentiel de Santé publique France, 2022)
Guide 2025, p. 61	Image corporelle, émotions, estime de soi	3.3.6
Guide 2025, p. 61	Connaissance des publics et de leurs spécificités	3.3.7 (dont pauvreté et exclusion) ; 3.3.14 (dont développement et maladie)
Référentiel, C3.1, C3.2, C3.5	Publics, objectifs adaptés, animation, écoute active	3.3.7 à 3.3.16 ; 3.6

3.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED

Le chapitre a été vérifié par rapport au fascicule *Environnement professionnel – Synthèse du cours en bref*, 1re année (CNED 3-6123-AN-WT-00-21), module 5 « Éléments de psychologie et de sociologie » (p. 32 à 46). Les pratiques et comportements alimentaires (module 2) sont traités au chapitre 4.

Module CNED	Contenu CNED	Où dans ce cours
M5 S1 §1 et §2 (p. 32 et 33)	Sociologie et psychologie ; fondateurs : Marx, Durkheim, Weber, Freud, Winnicott, Piaget, Bowlby	3.3.1 (fondateurs à connaître)
M5 S1 §3 et §4 (p. 33)	Socialisation ; identités individuelle, collective et sociale	3.3.2
M5 S1 §5 et §6 (p. 34)	Déviance (Merton, Becker) et délinquance	3.3.2 (déviance et délinquance)
M5 S2 §1 (p. 35 et 36)	Représentations sociales (Moscovici, Jodelet, Abric) ; stéréotypes, TIP, préjugés, discriminations	3.3.3 ; 3.3.4 (stéréotypes, juger autrui)
M5 S2 §2 (p. 36 à 38)	Communication (modèle de Shannon, moi intime et moi public, non-verbal) ; attitudes, distances, analyse transactionnelle ; rumeurs	3.3.4 (communiquer) ; 3.3.8
M5 S2 §3 (p. 38 et 39)	Intégration, lien social, socialisation, pauvreté, exclusion ; disqualification (Paugam), désaffiliation (Castel) ; classes, stratification, Bourdieu	3.3.7 (vocabulaire de la sociologie)

Module CNED	Contenu CNED	Où dans ce cours
M5 S3 (p. 40 à 43)	Courants de la psychologie du développement ; stade du miroir ; stades de Piaget ; adolescence, adulte, personne âgée	3.3.14 (développement de la personne)
M5 S4 (p. 44 à 46)	Maladie, psychosomatique, stress, mort ; rôle du diététicien	3.3.14 (maladie, stress et fin de vie)

Attention – corrections apportées aux documents sources – Ce qui a changé ou était inexact

- **Durkheim** (p. 32) : le fascicule écrit qu'« il a mis en place la laïcité ». C'est faux : la laïcité de l'État vient de la **loi du 9 décembre 1905** (séparation des Églises et de l'État), votée par le Parlement. Durkheim est l'un des **fondateurs de la sociologie** (*Les Règles de la méthode sociologique*, 1895 ; *Le Suicide*, 1897) ; il a seulement défendu une morale laïque à l'école.
- **Définition de la psychologie** (p. 32) : la phrase « … agit sur son environnement social » définit la **psychologie sociale**. La psychologie étudie plus largement les processus mentaux et les comportements de la personne.
- **Pauvreté** (p. 39) : la pauvreté monétaire de l'Insee n'est pas « le seuil en deçà duquel il est impossible de survivre ». C'est une pauvreté **relative** (60 % du niveau de vie médian). Le seuil de **1 041 €** date de 2017 ; le dernier publié est de **1 337 € par mois en 2024** (Insee, 9 juillet 2026), avec un taux de pauvreté de **15,4 %** (9,8 millions de personnes).
- **« Définitions selon Durkheim »** (p. 38) : toutes ces notions ne sont pas de Durkheim. L'**exclusion sociale** a été popularisée par René Lenoir (1974), la **disqualification** par Serge Paugam (1991), la **désaffiliation** par Robert Castel (1995), et le seuil de pauvreté est une convention statistique.
- **Auteurs non nommés** : le fascicule ne cite pas les auteurs de la **proxémie** (Edward T. Hall, 1966), de l'**analyse transactionnelle** (Eric Berne), des mécanismes de la **rumeur** (Allport et Postman, 1947) ni des **trois phases du stress** (Hans Selye, 1936). Le cours les donne, car le jury attend des références.
- **Modèle de Shannon** (p. 37) : il s'agit du modèle de Shannon et Weaver (1949), conçu pour les télécommunications ; il oublie la rétroaction et le contexte, que complète le schéma de la section 3.3.8.

3.3 Cours

NIVEAU BTS – EXIGIBLE

État de la veille – État de la veille au 26 octobre 2026

- **Compétences psychosociales** : le référentiel de Santé publique France (2022) et la stratégie interministérielle de développement des compétences psychosociales des enfants et des jeunes (2022-2037) sont les textes de référence ; consultez les outils et retours d'expérience publiés depuis sur *santepubliquefrance.fr*.
- **Stigmatisation du poids** : le consensus international de 2020 (*Nature Medicine*) reste la référence ; vérifiez les recommandations françaises récentes sur la communication non stigmatisante (HAS, Santé publique France).
- **Pauvreté** : dernier seuil publié par l'Insee (9 juillet 2026) : 1 337 € par mois en 2024 ; taux de pauvreté 15,4 % (section 3.3.7).
- **PNNS 5 (2026-2030)** : lancé le 8 avril 2026, il compte 3 axes et 20 mesures ; son troisième axe vise à « faire des milieux de vie des espaces promoteurs de santé » (voir le chapitre 1).

3.3.1 Psychologie, sociologie, anthropologie : trois regards sur le mangeur

Module · Guide 2025 : p. 60-61 · CNED : Synthèse M5 S1 §1 et §2 (p. 32 et 33)

Discipline	Objet	Apport pour comprendre l'alimentation
Psychologie	Étude des processus mentaux et des comportements de l'individu (perceptions, émotions, motivations, apprentissages) ; la psychologie sociale étudie l'influence des autres sur l'individu	Préférences et aversions, néophobie, alimentation émotionnelle, motivation au changement, influence du groupe
Sociologie	Étude des groupes et des faits sociaux (classes sociales, institutions, normes)	Différences de pratiques selon le milieu social, le genre, l'âge ; repas comme fait social ; inégalités
Anthropologie	Étude de l'être humain dans ses dimensions culturelles (ethnologie) et biologiques, souvent par comparaison entre sociétés	Interdits, rites, symboliques des aliments, manières de table, cuisines du monde

Définition – Psychologie sociale

Discipline qui étudie la façon dont les pensées, les sentiments et les comportements des individus sont influencés par la présence réelle, imaginée ou implicite des autres (Gordon Allport, 1954). Elle se situe à l'interface de la psychologie (l'individu) et de la sociologie (le groupe).

Quelques repères en sociologie et anthropologie de l'alimentation

- **Claude Lévi-Strauss** (*Le cru et le cuit*, 1964) : la cuisine transforme la nature en culture ; le « triangle culinaire » (cru, cuit, pourri) montre que chaque société organise symboliquement ses aliments.
- **Claude Fischler** (*L'Homnivore*, 1990) : le **paradoxe de l'omnivore** : l'être humain a besoin de variété (**néophilie**), mais se méfie de l'inconnu (**néophobie**) ; le **principe d'incorporation** : « je deviens ce que je mange », d'où l'importance symbolique et l'anxiété autour des aliments. Il décrit aussi la **gastro-anomie** : l'affaiblissement des règles collectives du repas laisse le mangeur moderne seul face à des injonctions contradictoires.
- **Jean-Pierre Poulain** (*Sociologies de l'alimentation*, 2002) : l'**espace social alimentaire**, zone de liberté laissée au mangeur par les contraintes biologiques et environnementales, structurée en six dimensions.
- **Pierre Bourdieu** (*La Distinction*, 1979) : les goûts alimentaires sont socialement construits ; les milieux populaires valorisent le « nourrissant », les milieux favorisés la « légèreté » et la forme.

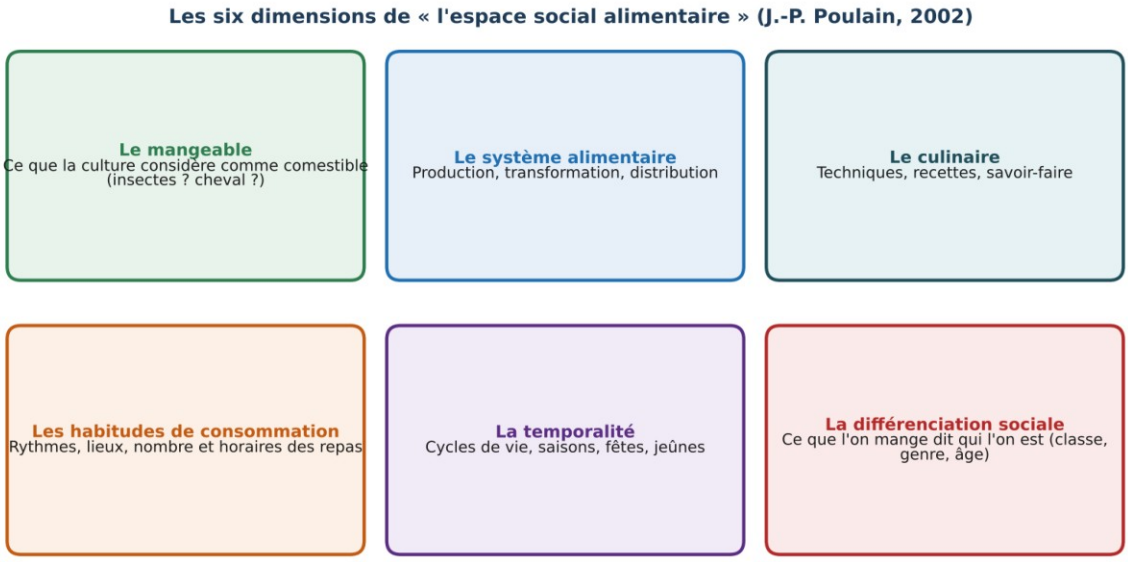


Figure 3.1 – Les six dimensions de l'espace social alimentaire (Poulain, 2002)

Comprendre le schéma – Figure 3.1

1. Le mangeable : chaque culture définit ce qui est comestible (le cheval, les insectes, le porc ne sont pas « mangeables » partout).

2. Le système alimentaire : chaîne de la production à la distribution, qui conditionne ce qui est disponible.

3. Le culinaire : techniques, recettes et savoir-faire qui transforment l'aliment.

4. Les habitudes de consommation : nombre de repas, horaires, lieux, prises hors repas.

5. La temporalité : âges de la vie, saisons, calendrier des fêtes et des jeûnes (Ramadan, Carême).

6. La différenciation sociale : l'alimentation marque l'appartenance à un groupe (classe, génération, genre, religion).

7. Lecture pour le diététicien : un conseil nutritionnel touche à **toutes** ces dimensions ; il est efficace s'il les respecte.

Les fondateurs à connaître (programme du CNED)

La **sociologie** donne des outils, un vocabulaire et des théories pour expliquer la vie sociale ; elle pose des questions et y répond par des hypothèses vérifiées sur le terrain. La **psychologie** étudie scientifiquement les processus mentaux et les comportements de la personne (perception, mémoire, émotions, jugement, action). Quand elle étudie l'influence des autres sur la personne, c'est la **psychologie sociale**.

Auteur	Discipline	Idée à retenir	Lien avec l'alimentation
Karl Marx (1818-1883)	Sociologie, économie	Classes sociales définies par la place dans la production ; domination et aliénation	Inégalités d'accès à une alimentation de qualité
Émile Durkheim (1858-1917)	Sociologie	Le fait social s'impose à l'individu ; intégration, lien social, solidarité mécanique (ressemblance) et organique (complémentarité)	Le repas partagé comme lien social ; l'isolement comme risque
Max Weber (1864-1920)	Sociologie	Comprendre le sens que les personnes donnent à leurs actions ; « type idéal » pour comparer ; stratification	Comprendre pourquoi une personne fait un choix alimentaire
Sigmund Freud (1856-1939)	Psychanalyse	Développement psycho-affectif ; place de l'inconscient et de l'enfance	Stade oral, valeur affective de la nourriture

Auteur	Discipline	Idée à retenir	Lien avec l'alimentation
Donald W. Winnicott (1896-1971)	Pédiatrie, psychanalyse	Lien entre le nourrisson et les soins maternels ; mère « suffisamment bonne »	Le nourrissage comme relation, pas seulement comme apport
Jean Piaget (1896-1980)	Psychologie du développement	L'intelligence se construit par adaptation, en quatre stades	Adapter les messages à l'âge des enfants
John Bowlby (1907-1990)	Pédopsychiatrie	Théorie de l'attachement : le lien au parent est un besoin premier	Climat affectif des repas de l'enfant

À vous de jouer – Exercice d'application 3.1

Associez chaque phrase à un auteur du tableau : a) « Le repas de famille entretient le sentiment d'appartenir au groupe. » b) « Un enfant de 5 ans ne comprend pas encore la notion abstraite de "nutriment". » c) « Pour comprendre ce choix, je cherche le sens que la personne lui donne. » d) « Un bébé a besoin de la présence stable d'une figure d'attachement pendant les repas. »

Corrigé

a) **Durkheim** (intégration, lien social). b) **Piaget** (stade préopératoire : pensée concrète, pas encore de raisonnement abstrait). c) **Weber** (sociologie compréhensive). d) **Bowlby** (attachement), et aussi Winnicott (soins maternels).

Les fonctions de l'alimentation : pourquoi mange-t-on ?

Manger ne sert pas seulement à couvrir des besoins en énergie et en nutriments. Les sciences humaines distinguent plusieurs **fonctions** de l'alimentation, toujours présentes en même temps. Un conseil qui n'en considère qu'une (la fonction nutritionnelle) a peu de chances d'être suivi.

Fonction	Ce qu'elle recouvre	Exemple	Conséquence pour l'action
Biologique (nutritionnelle)	Couvrir les besoins, apaiser la faim, se maintenir en santé	Manger des féculents avant un effort	Nécessaire mais rarement suffisante pour motiver
Hédonique (plaisir)	Goût, odeurs, textures, plaisir des sens	Le chocolat, le plat préféré	Garder le plaisir dans toute proposition
Psychologique et affective	Réconfort, régulation des émotions, souvenirs	Le gâteau de la grand-mère, manger quand on est triste	Comprendre l'alimentation émotionnelle sans juger
Sociale et relationnelle	Partager, recevoir, créer du lien, marquer les rythmes collectifs	Repas de famille, apéritif entre collègues	Proposer des repas partagés, agir avec le groupe
Identitaire	Dire qui l'on est et à quel groupe on appartient	Cuisine du pays d'origine, végétarisme, plats régionaux	Valoriser les cuisines d'origine, ne pas les dévaloriser
Symbolique et religieuse	Interdits, rites, fêtes, jeûnes	Ramadan, Carême, repas de Noël	Adapter le calendrier et le contenu des actions

Le modèle alimentaire français et la gastro-anomie

Le **modèle alimentaire français** (trois repas par jour à heures fixes, pris à table et à plusieurs) et son évolution sont présentés au chapitre 4. On retient ici une notion de sociologie utile pour comprendre le mangeur d'aujourd'hui.

Définition – Gastro-anomie (Fischler, 1979)

Situation du mangeur moderne qui, face à l'abondance de l'offre et à l'affaiblissement des règles collectives

(horaires, structure du repas, transmission familiale), doit faire seul ses choix au milieu de messages contradictoires (publicité, médecine, médias, réseaux sociaux). La gastro-anomie favorise l'anxiété alimentaire et la recherche de repères, parfois dans des régimes ou des modes peu fondés.

À vous de jouer – Exercice d'application 3.2

Lors d'un atelier avec des retraités, une participante dit : « Depuis que je suis veuve, je ne fais plus de vrais repas : un yaourt et une tranche de jambon devant la télévision. Cuisiner pour une personne, ça ne vaut pas la peine. » a) Identifiez les fonctions de l'alimentation qui ont disparu pour elle. b) Expliquez pourquoi un conseil purement nutritionnel (« il faut manger des protéines et des légumes ») a peu de chances de réussir. c) Proposez deux actions qui redonnent leurs fonctions aux repas.

Corrigé

a) Les fonctions **sociale et relationnelle** (elle mange seule, sans personne pour qui cuisiner), **hédonique** (repas sans plaisir) et **identitaire** (son rôle de « celle qui cuisine pour la famille » a disparu). La fonction biologique elle-même est menacée (risque de dénutrition). **b)** Le conseil ne répond pas à la cause du problème, qui est la perte du sens social du repas ; il risque même de culpabiliser. **c)** Un repas partagé hebdomadaire au club ou au foyer-restaurant, où elle peut aussi transmettre une recette (valorisation, lien social) ; des recettes « pour un » rapides et des idées de portions à congeler, présentées lors d'un atelier convivial ; la participation à une action de « repas solidaires » entre voisins.

3.3.2 Identité individuelle et sociale ; socialisation

Module · Guide 2025 : p. 61 · CNED : Synthèse M5 S1 §3 et §4 (p. 33) ; Synthèse M5 S1 §5 et §6 (p. 34)

Définition – Identité individuelle et identité sociale

- L'**identité individuelle** (ou personnelle) est l'ensemble des caractéristiques par lesquelles une personne se reconnaît comme unique (histoire, goûts, valeurs, image de soi).
- L'**identité sociale** est la partie de l'image de soi qui provient de l'**appartenance à des groupes** (famille, génération, origine, religion, profession, quartier) et de la valeur qu'on leur attribue (Tajfel et Turner, théorie de l'identité sociale, 1979).

L'alimentation est un puissant **marqueur d'identité** : « dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es » (Brillat-Savarin, 1825). Les plats familiaux, régionaux ou du pays d'origine, les interdits religieux (halal, casher, végétarisme hindou), les choix éthiques (végétarisme, véganisme) ou les styles de vie (« healthy ») expriment l'appartenance à un groupe. Toucher à l'alimentation, c'est toucher à l'identité : un conseil qui dévalorise un plat familial peut être vécu comme une attaque.

Définition – Socialisation

Processus par lequel une personne **intériorise** les normes, les valeurs et les pratiques de la société et des groupes auxquels elle appartient.

- **Socialisation primaire** : pendant l'enfance, principalement par la **famille** (goûts, horaires des repas, manières de table, aliments « de fête » et « de tous les jours »), puis l'école.
- **Socialisation secondaire** : à l'adolescence et à l'âge adulte, par l'école, les **pairs**, le travail, le couple, les médias et les réseaux sociaux ; elle peut renforcer ou transformer la socialisation primaire.

Exemple – La socialisation alimentaire en action

- Un enfant apprend à aimer les légumes s'il les goûte **à plusieurs reprises** (8 à 15 expositions sont souvent

nécessaires) dans un climat positif, en voyant ses parents en manger (modèle).
- À l'adolescence, les **pairs** et les réseaux sociaux prennent le relais : restauration rapide entre amis, boissons énergisantes, régimes vus sur les réseaux.
- À l'entrée dans la vie étudiante ou professionnelle, la cantine, les horaires et la vie en couple transforment les habitudes (socialisation secondaire).

Lien diététique – Ce que cela change pour l'animation

Pour un atelier avec des enfants, impliquer les **parents** (socialisation primaire) ; pour des adolescents, s'appuyer sur des **pairs** ou des ambassadeurs (socialisation secondaire) ; pour des adultes, partir des **plats familiaux** valorisés et proposer des adaptations plutôt que des ruptures.

Identité collective, déviance et délinquance

Le CNED distingue trois niveaux d'identité :

- l'**identité individuelle** : ce que la personne s'attribue (traits, rôles, valeurs) ;
- l'**identité collective** : la façon dont une personne se définit et est définie par les autres à partir de ses appartenances (profession, âge, genre, religion, territoire, famille) ;
- l'**identité sociale** : la combinaison des deux ; c'est ce qui permet aux autres de situer la personne, par la **catégorisation sociale**.

Définition – Déviance et délinquance

- La **déviance** est le fait de ne pas suivre une **norme sociale**, souvent implicite. Elle est relative : ce qui est déviant ici ou aujourd'hui peut être accepté ailleurs ou demain. Robert K. Merton (1938) l'explique par l'écart entre les buts valorisés et les moyens disponibles ; Howard Becker (*Outsiders*, 1963) montre qu'est déviant celui à qui le groupe **colle l'étiquette** de déviant.
- La **délinquance** est le non-respect d'une norme **écrite dans la loi** ; elle expose à une sanction pénale.

Lien diététique – Ne pas étiqueter les mangeurs

Manger seul, sauter un repas, refuser la viande ou suivre un jeûne religieux peuvent être vus comme « déviants » dans un groupe et normaux dans un autre. Le diététicien évite les étiquettes (« le mauvais élève », « l'obèse ») : selon Becker, l'étiquette elle-même peut enfermer la personne dans le comportement qu'on lui reproche.

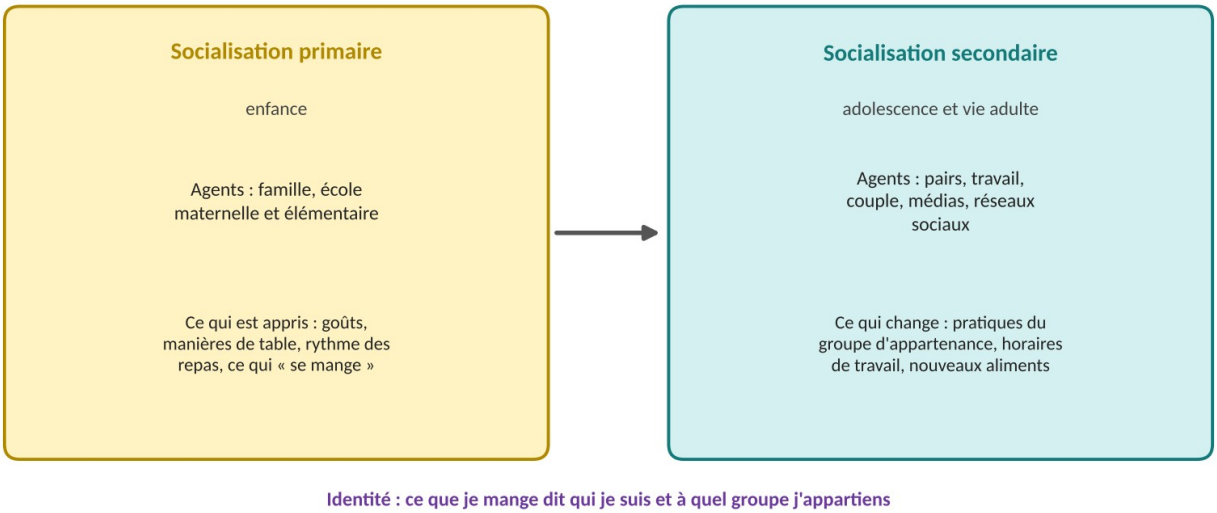


Figure 3.1 bis – Socialisation primaire et secondaire

Comprendre le schéma – Figure 3.1 bis

1. La **socialisation primaire** se fait dans l'enfance, surtout dans la famille et à l'école : l'enfant y apprend ses goûts, les manières de table, le rythme des repas et ce qui « se mange ».
2. La **socialisation secondaire** se poursuit toute la vie : pairs, travail, couple, médias et réseaux sociaux transforment ou renforcent les apprentissages de l'enfance.
3. La flèche montre une continuité : la socialisation secondaire ne remplace pas la primaire, elle s'y ajoute. Beaucoup d'adultes reviennent aux plats de leur enfance quand ils deviennent parents.
4. En bas, l'**identité** : ce que l'on mange dit qui l'on est et à quel groupe on appartient.

Identité sociale, groupes d'appartenance et de référence

Selon la théorie de l'identité sociale (Tajfel et Turner, 1979), chacun **catégorise** le monde en groupes, s'**identifie** à certains d'entre eux et se **compare** aux autres. On cherche une identité sociale positive : on valorise son groupe (**endogroupe**) par rapport aux autres (**exogroupes**). Le **groupe d'appartenance** est celui dont on fait partie ; le **groupe de référence** est celui auquel on se compare ou auquel on aimerait appartenir (un adolescent peut prendre pour référence un groupe de sportifs ou d'influenceurs).

Notion	Définition	Exemple alimentaire	Conséquence pour le diététicien
Catégorisation	Classer les personnes en groupes	« Les jeunes », « les bobos », « les gens du quartier »	Ne pas se présenter comme membre d'un groupe perçu comme « contre » le public
Favoritisme pour son groupe	Juger plus favorablement son propre groupe	« Chez nous, on mange bien, pas comme eux »	Valoriser les pratiques du groupe plutôt que celles d'un autre
Menace identitaire	Sentiment que l'identité de son groupe est dévalorisée	Un conseil qui critique un plat traditionnel	Partir des plats du groupe et proposer des adaptations
Groupe de référence	Groupe auquel on veut ressembler	Sportifs, influenceurs, collègues expérimentés	Faire porter le message par des modèles issus de ce groupe

Genre, normes et alimentation

Les pratiques alimentaires sont aussi marquées par les **normes de genre** apprises pendant la socialisation. Dans beaucoup de milieux, la viande rouge, les portions copieuses et la force sont associées au masculin, tandis que les légumes, les produits « légers » et le souci de la ligne sont associés au féminin. Ces normes expliquent en partie pourquoi, en moyenne, les hommes mangent plus de viande et moins de fruits et légumes que les femmes, et pourquoi les femmes sont davantage exposées aux régimes amaigrissants et à l'insatisfaction corporelle. Elles varient selon les milieux sociaux, les générations et les cultures, et elles évoluent.

Lien diététique – Utiliser l'identité plutôt que la combattre

- Avec un public masculin attaché à la « force », parler d'énergie, de récupération et de performance plutôt que de « régime ».
- Avec des personnes migrantes, partir des plats d'origine, souvent riches en légumineuses et en légumes, et les valoriser devant le groupe.
- Avec des adolescents, faire porter les messages par des pairs ou des modèles du groupe de référence.

À vous de jouer – Exercice d'application 3.3

Dans un foyer de jeunes travailleurs, un résident de 19 ans dit : « Les légumes, c'est pour les filles. Moi je fais de la muscu, il me faut de la viande et des pâtes. » a) Identifiez la norme sociale et le groupe de référence en jeu. b) Expliquez pourquoi un message sur les « 5 fruits et légumes » risque d'être rejeté. c) Reformulez un message qui respecte son identité.

Corrigé

a) Une norme de genre qui associe les légumes au féminin et la viande à la force masculine ; le groupe de référence est celui des pratiquants de musculation. **b)** Le message entre en conflit avec son identité (menace identitaire) et avec les normes de son groupe de référence ; il sera perçu comme venant d'un exogroupe (« les diététiciens »). **c)** Exemple : « Les sportifs de haut niveau mettent des légumes dans chaque repas : ils apportent les vitamines et les minéraux qui aident les muscles à récupérer. Tu veux qu'on regarde ce que mange un athlète en préparation ? »

Point d'étape – Je teste mes acquis – 3.3.1 et 3.3.2 – Regards sur le mangeur, identité et socialisation

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Distinguez l'objet de la psychologie, de la sociologie et de l'anthropologie.
2. Énoncez le paradoxe de l'omnivore et donnez son auteur et son année.
3. Citez trois fonctions de l'alimentation, en plus de la fonction biologique.
4. Distinguez socialisation primaire et socialisation secondaire, avec un agent de chacune.
5. Qu'est-ce qu'un groupe de référence ? Donnez un exemple chez un adolescent.
6. Vrai ou faux : « La gastro-anomie désigne un trouble du comportement alimentaire. » Justifiez.

Corrigé – Point d'étape 3.3.1 et 3.3.2

1. La psychologie étudie l'individu (perceptions, émotions, motivations) ; la sociologie, les groupes et les faits sociaux (classes, genre, âge) ; l'anthropologie, les cultures (symboles, rites, interdits).
2. L'être humain a besoin de variété (néophilie) mais se méfie de l'inconnu (néophobie) ; Claude Fischler, *L'Homnivore*, 1990.
3. Par exemple : fonction sociale (partager, créer du lien), identitaire (dire qui l'on est), hédonique (plaisir), symbolique ou religieuse, éducative.
4. Primaire : pendant l'enfance, par la famille puis l'école. Secondaire : tout au long de la vie, par les pairs, le

travail, le couple, les médias.

5. Le groupe auquel on se compare ou auquel on aimerait appartenir, sans en faire forcément partie : des sportifs, des influenceurs.

6. Faux : c'est la perte de repères sur ce qu'il faut manger, quand les normes se multiplient et se contredisent (Fischler, 1979) ; ce n'est pas une maladie.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la suite.
3 ou 4 sur 6	Je relis les encadrés « À retenir » et les définitions de la section, puis je refais les questions manquées.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la section et je refais les exercices d'application.

3.3.3 Représentations, normes, valeurs ; culture et interculturalité

Module · Guide 2025 : p. 61 · CNED : Synthèse M5 S2 §1 (p. 35 et 36)

Représentations sociales

Définition – Représentation sociale (Serge Moscovici, 1961)

Forme de connaissance **socialement élaborée et partagée**, qui permet aux membres d'un groupe d'interpréter la réalité et d'orienter leurs comportements (« sens commun »). Selon Jean-Claude Abric (1994), une représentation est organisée autour d'un **noyau central** stable (les éléments essentiels, difficiles à changer) et d'**éléments périphériques** plus flexibles.

Exemple – Représentations alimentaires fréquentes

« Un repas sans viande n'est pas un vrai repas » ; « manger équilibré coûte cher » ; « le pain fait grossir » ; « un enfant gros est un enfant en bonne santé » ; « bio = sans calories » ; « les féculents le soir font grossir ». Ces représentations ne sont pas des « erreurs » à corriger brutalement : elles ont une **cohérence** pour ceux qui les portent (expérience, culture, publicité). L'éducateur les **recueille** d'abord, puis les fait évoluer en s'appuyant sur les éléments périphériques (« un repas sans viande peut être complet s'il associe légumineuses et céréales »).

Méthode pas à pas – Recueillir les représentations d'un groupe

1. Associations libres : « Quand je dis "manger équilibré", à quoi pensez-vous ? » ; noter tous les mots au tableau, puis les regrouper.

2. Photolangage : choisir parmi 30 à 40 photos celle qui représente « bien manger pour moi » et expliquer son choix.

3. Abaque de Régnier : réagir à des affirmations avec des cartes de couleur (d'accord / pas d'accord) puis en débattre.

4. Classement de cartes : classer des aliments selon le prix, le plaisir, la santé, puis comparer.

5. Synthèse : repérer ce qui est partagé (noyau), ce qui varie, ce qui peut évoluer ; adapter les messages.

Comment se forme et à quoi sert une représentation sociale

Serge Moscovici (*La psychanalyse, son image et son public*, 1961) décrit deux processus qui transforment une notion nouvelle ou abstraite en savoir de sens commun.

- L'**objectivation** rend concret ce qui est abstrait : on sélectionne quelques éléments, on les simplifie et on en fait une image. « Manger équilibré » devient « manger de la salade et du poisson » ; « le cholestérol » devient « le gras qui bouche les artères ».
- L'**ancrage** rattache la nouveauté à des catégories déjà connues, ce qui la rend familière : « les produits ultra-transformés, c'est comme les plats tout prêts de la télé » ; « le bio, c'est comme les légumes du jardin de mon grand-père ».

Jean-Claude Abric (*Pratiques sociales et représentations*, 1994) attribue aux représentations **quatre fonctions**.

Fonction	Rôle	Exemple
De savoir	Comprendre et expliquer la réalité avec des mots communs	« Le sucre donne le diabète »
Identitaire	Situer la personne et son groupe, protéger leur image	« Nous, les ouvriers, on mange solide »
D'orientation	Guider les comportements, définir ce qui est attendu	« Un vrai repas, c'est un plat chaud » : on refuse la salade du soir
Justificatrice	Justifier après coup les choix et les comportements	« Je ne mange pas de légumes parce que c'est trop cher »

Noyau central et périphérie

	Noyau central	Éléments périphériques
Rôle	Donne le sens de la représentation, l'organise	Adaptent la représentation aux situations concrètes
Caractère	Stable, consensuel, lié à l'histoire et aux valeurs du groupe	Souples, variables selon les personnes
Face au changement	Résiste ; s'il change, la représentation change entièrement	Évoluent facilement ; ils protègent le noyau
Comment l'identifier	Fréquent et cité tôt dans l'évocation ; massivement refusé quand on le met en cause	Moins fréquent ou cité tard ; on accepte de s'en passer

Méthode pas à pas – Vérifier qu'un élément est central : le questionnaire de mise en cause (Moliner, 1988)

1. Partir des éléments situés dans la zone du noyau après une évocation hiérarchisée.

2. Pour chacun, poser la question : « Peut-on encore parler de [objet] si [élément] est absent ? » (par exemple : « Un repas peut-il être un vrai repas s'il n'y a pas de plat chaud ? »).

3. Calculer la part de réponses « non » : un élément refusé par une très large majorité (souvent au moins 75 %) est central ; un élément que beaucoup acceptent de retirer est périphérique.

4. En déduire les leviers : on agit d'abord sur la périphérie, en s'appuyant sur le noyau, sans le heurter.

À vous de jouer – Exercice d'application 3.4

Dans un quartier, 100 parents répondent à un questionnaire de mise en cause sur « le petit-déjeuner ». « Peut-on parler de petit-déjeuner sans boisson chaude ? » : 82 répondent non. « … sans pain ni céréales ? » : 64 répondent non. « … s'il est pris debout ? » : 21 répondent non. a) Calculez les pourcentages et appliquez la règle des 75 %. b) Que proposez-vous aux familles qui manquent de temps le matin ?

Corrigé

a) Boisson chaude : 82 / 100 = **82 %** de « non » : élément central. Pain ou céréales : **64 %** : sous le seuil, élément plutôt périphérique mais important. Pris assis : **21 %** de « non » seulement : élément périphérique

(on accepte un petit-déjeuner pris debout). **b)** Ne pas toucher au noyau (garder une boisson chaude, par exemple un lait chaud ou un chocolat) et agir sur la périphérie : un petit-déjeuner rapide, éventuellement pris debout ou emporté, avec un produit céréalier simple (tartine préparée, pain) et un fruit facile à manger.

Normes, valeurs, attitudes

- Une **valeur** est un idéal collectif qui oriente les jugements (santé, plaisir, convivialité, partage, respect de l'animal, économie).
- Une **norme sociale** est une règle de conduite, explicite ou implicite, attendue dans un groupe : manger à heures fixes, finir son assiette, ne pas manger seul devant la télévision… On distingue les normes **descriptives** (« ce que les gens font ») et **injonctives** (« ce qu'il faut faire »). Montrer que « la majorité des familles de l'école donnent de l'eau au goûter » (norme descriptive) est souvent plus efficace qu'une injonction.
- Une **attitude** est une disposition favorable ou défavorable envers un objet (« j'aime / je n'aime pas les légumes secs »), composée d'éléments cognitifs (croyances), affectifs (émotions) et conatifs (intentions d'agir).

Culture, différences culturelles, interculturalité, acculturation

Définition – Culture

Ensemble des manières de penser, de sentir et d'agir, **apprises et partagées** par les membres d'un groupe, et transmises de génération en génération (langue, croyances, valeurs, techniques, cuisine, rites). La culture alimentaire comprend ce qui est mangé, comment, quand, avec qui, et ce que cela signifie.

Les **différences culturelles** portent par exemple sur : la structure du repas (plat unique ou succession d'entrée-plat-dessert), les horaires, l'usage des mains ou des couverts, les aliments interdits ou valorisés, la place des enfants à table, la valeur de la corpulence (signe de santé et de prospérité dans certaines cultures), le rapport au temps du repas, les fêtes et jeûnes.

Définition – Interculturalité

Ensemble des **relations et échanges** entre personnes de cultures différentes, fondés sur la reconnaissance mutuelle et la réciprocité. La **posture interculturelle** du professionnel consiste à prendre conscience de son propre cadre culturel (décentration), à découvrir celui de l'autre sans jugement, et à négocier des solutions acceptables pour les deux (Margalit Cohen-Emerique, 2011).

Définition – Acculturation

Ensemble des changements qui se produisent lorsque des groupes de cultures différentes sont en **contact continu et direct** (Redfield, Linton et Herskovits, 1936). Roger Bastide distingue l'acculturation **spontanée** (non dirigée, par le simple contact : adoption progressive de produits du pays d'accueil) et l'acculturation **planifiée** (organisée volontairement par une institution, par exemple un programme d'éducation alimentaire ou la cantine scolaire). Le **syncrétisme culinaire** désigne la combinaison d'éléments de cultures différentes dans une même pratique (couscous aux légumes de saison français, « burger » maison avec épices du pays d'origine).

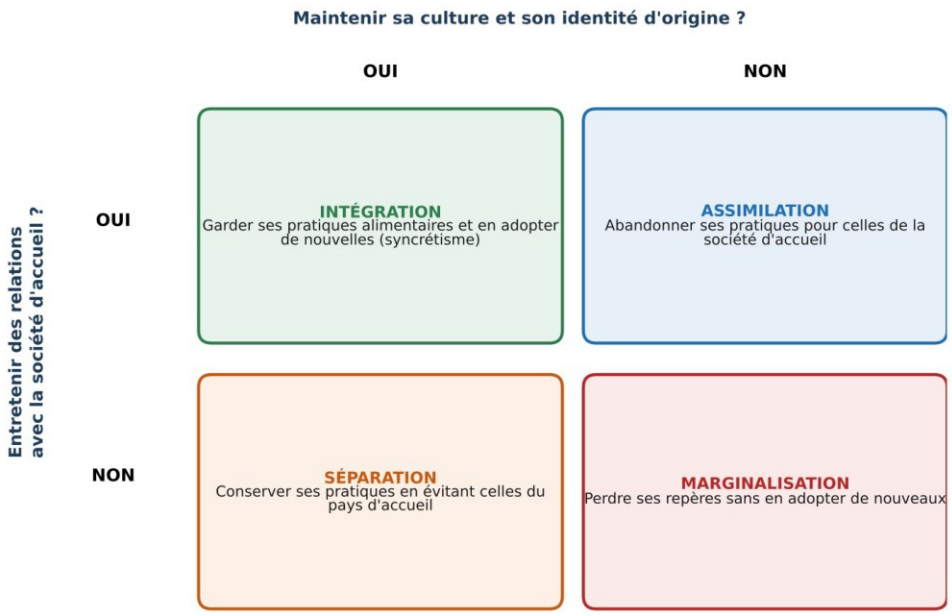


Figure 3.2 – Les stratégies d'acculturation selon John Berry (1997), appliquées à l'alimentation

Comprendre le schéma – Figure 3.2

1. Le modèle croise deux questions : la personne **maintient-elle** sa culture d'origine ? **Entretient-elle** des relations avec la société d'accueil ?

2. Intégration (oui / oui) : on garde ses plats et on en adopte de nouveaux ; c'est la stratégie généralement la plus favorable au bien-être et à la santé.

3. Assimilation (non / oui) : abandon des pratiques d'origine ; en alimentation, elle s'accompagne souvent de l'adoption de produits transformés, de sodas et de restauration rapide, avec un risque de dégradation de la qualité nutritionnelle (« transition nutritionnelle »).

4. Séparation (oui / non) : maintien des pratiques d'origine sans contact avec celles du pays d'accueil ; difficultés possibles d'accès aux produits.

5. Marginalisation (non / non) : perte des repères sans en adopter de nouveaux ; situation de grande vulnérabilité, y compris alimentaire.

6. Pour le diététicien : favoriser l'**intégration** en valorisant les pratiques d'origine favorables (légumineuses, légumes, cuisine maison) et en aidant à utiliser les produits disponibles.

Attention – Respecter sans enfermer

Ne pas réduire une personne à sa culture supposée (« les Africains mangent… ») : il existe une grande diversité à l'intérieur de chaque groupe. On **demande** à la personne ce qu'elle mange et ce qui compte pour elle, plutôt que de le présumer.

À vous de jouer – Exercice d'application 3.5

Lors d'un atelier, Mme A., arrivée du Mali il y a deux ans, explique qu'elle cuisine le tiep (riz au poisson et aux légumes) le week-end, mais que ses enfants réclament des nuggets et des sodas « comme à la cantine et chez les copains ». a) Identifiez les mécanismes de socialisation en jeu. b) Situez la famille dans le modèle de Berry. c) Proposez une attitude et une action.

Corrigé

a) Socialisation **primaire** (transmission du tiep par la mère) et socialisation **secondaire** des enfants par l'école, la cantine et les **pairs**, qui introduit de nouvelles normes et de nouveaux produits (acculturation **spontanée**). **b)** La famille est en situation d'**intégration** (la mère maintient ses plats et s'ouvre aux produits français), avec un risque d'**assimilation** des enfants vers des produits transformés peu favorables. **c)** Attitude : valoriser le tiep (plat complet riche en légumes et en poisson), sans dévaloriser les demandes des enfants. Action : atelier « recettes du monde » où la mère présente le tiep au groupe (valorisation identitaire) et atelier « nuggets maison au four » pour répondre aux envies des enfants avec une version plus favorable (syncrétisme).

Ethnocentrisme, relativisme et démarche interculturelle

- L'**ethnocentrisme** est la tendance à juger les autres cultures à partir des normes de la sienne, considérées comme les seules « normales » (« en France, on mange de tout, les enfants doivent s'adapter »).
- Le **relativisme culturel** considère que chaque pratique a un sens dans sa culture et doit être comprise avant d'être jugée. Poussé à l'extrême, il pourrait conduire à tout accepter, y compris ce qui nuit à la santé : le professionnel garde ses repères (sécurité sanitaire, droits des personnes) tout en cherchant à comprendre.
- Le **choc culturel** est la réaction (incompréhension, malaise, irritation) que provoque la rencontre d'une pratique très différente. Margalit Cohen-Emerique a montré qu'il touche des **zones sensibles** : le corps et sa présentation, le rapport au temps, la place de la famille et des femmes, la religion, la façon de soigner et de nourrir les enfants.

Méthode pas à pas – La démarche interculturelle en trois étapes (Cohen-Emerique, 2011)

1. Décentration : prendre conscience de son propre cadre de référence (valeurs, normes, préjugés) et de ses réactions face à la situation. « Pourquoi cette pratique me choque-t-elle ? »

2. Découverte du cadre de référence de l'autre : chercher à comprendre le sens de la pratique pour la personne, en l'interrogeant sans supposer. « Que représente pour vous ce repas, ce jeûne, cet aliment ? »

3. Négociation et médiation : chercher ensemble une solution acceptable pour les deux parties, qui respecte l'identité de la personne et les impératifs professionnels (santé, sécurité, règlement).

Exemple – Le jeûne du ramadan chez une personne diabétique

M. K., diabétique de type 2 traité par comprimés, annonce à la diététicienne qu'il fera le ramadan. **Décentration** : la diététicienne repère sa première réaction (« c'est dangereux, il ne doit pas jeûner »), liée à son cadre médical. **Découverte** : elle apprend que le jeûne a pour lui une grande valeur spirituelle et familiale, et qu'il l'a toujours fait. **Négociation** : elle l'oriente vers son médecin pour adapter le traitement et la surveillance de la glycémie, et travaille avec lui la composition des repas de rupture du jeûne et du repas avant l'aube (féculents complets, légumineuses, eau en quantité suffisante, dattes en quantité raisonnable). Le jeûne n'est ni interdit ni ignoré : il est accompagné.

À vous de jouer – Exercice d'application 3.6

Dans une crèche, une mère d'origine sénégalaise donne à son fils de 18 mois un biberon de bouillie très sucrée le soir. L'auxiliaire de puériculture dit : « Ce n'est pas comme ça qu'on fait ici. » a) Identifiez l'attitude de l'auxiliaire. b) Appliquez les trois étapes de la démarche interculturelle. c) Proposez une solution négociée.

Corrigé

a) Une attitude **ethnocentrique** : la pratique est jugée à partir des normes de l'auxiliaire et de l'institution, sans chercher à la comprendre. **b)** Décentration : l'auxiliaire repère que, pour elle, la « bonne » alimentation d'un enfant de 18 mois passe par des repas à la cuillère et peu de sucre. Découverte : elle interroge la mère, qui explique que la bouillie du soir aide l'enfant à dormir et qu'elle a été élevée ainsi ; elle craint qu'il ait faim

la nuit. Négociation : on part de l'objectif commun (un enfant qui dort bien et qui n'a pas faim). **c)** Garder le repas du soir rassasiant, mais remplacer peu à peu la bouillie sucrée par une bouillie de céréales non sucrée ou peu sucrée, avec du lait ou un fruit écrasé, donnée à la cuillère quand c'est possible, et parler du brossage des dents. La mère choisit le rythme du changement.

Pratiques alimentaires religieuses : connaître pour adapter

Dans un atelier, le respect des pratiques religieuses et culturelles conditionne la participation. Le diététicien ne suppose rien à partir de l'origine ou du nom d'une personne : il **demande**, car les pratiques varient beaucoup d'une personne à l'autre au sein d'une même religion.

Les règles des grandes traditions religieuses (islam, judaïsme, christianisme, hindouisme, bouddhisme, sikhisme, jaïnisme) et la question de la laïcité en restauration collective sont présentées au chapitre 4 (section 4.3.15). On retient ici la posture : ces règles sont aussi des **marqueurs d'identité** (section 3.3.2) ; les respecter évite la **menace identitaire** et favorise la stratégie d'**intégration** de Berry. En restauration scolaire, les menus de substitution ne sont ni obligatoires ni interdits ; le Conseil d'État (11 décembre 2020) a jugé qu'une commune qui décide de les supprimer doit tenir compte de l'intérêt des enfants.

Méthode pas à pas – Préparer un atelier interculturel respectueux

1. À l'inscription, demander simplement : « Y a-t-il des aliments que vous ne mangez pas, pour des raisons de santé, de religion ou de goût ? »
2. Construire la recette de base avec des ingrédients acceptables par tous (légumes, légumineuses, céréales, épices).
3. Prévoir les éventuelles variantes à part (viande halal, fromage) plutôt que de les mélanger.
4. Vérifier les ingrédients cachés : gélatine, bouillon, vin, saindoux, présure.
5. Tenir compte du calendrier (ramadan, carême, fêtes) pour fixer les dates et les horaires.
6. Valoriser les plats et les savoir-faire des participants (stratégie d'**intégration** de Berry).

À vous de jouer – Exercice d'application 3.7

Un centre social prévoit un atelier « gratin de fin d'été » (pommes de terre, lardons, crème, emmental) un vendredi soir de mars. Parmi les 10 inscrits, 4 personnes ne mangent pas de porc, une famille est orthodoxe et une personne ne consomme aucun produit d'origine animale. a) Repérez les difficultés. b) Proposez une recette et une organisation adaptées. c) Quelle phrase utilisez-vous à l'inscription pour éviter ces difficultés ?

Corrigé

a) Les **lardons** excluent les personnes qui ne mangent pas de porc ; un vendredi de mars peut tomber en période de **carême** (jeûne orthodoxe sans produits animaux, abstinence de viande pour certains catholiques) ; la crème et l'emmental excluent la personne végétalienne ; le « gratin de fin d'été » est hors saison en mars. **b)** Un **gratin de légumes de saison et de pois chiches** à base de lait végétal et de chapelure, avec une petite portion gratinée au fromage préparée à part pour ceux qui le souhaitent ; aucun produit carné. **c)** « Y a-t-il des aliments que vous ne mangez pas, pour des raisons de santé, de religion ou de goût ? », posée à tous, sans demander de justification.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 3.3.3 – Représentations, normes, culture

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Définissez une représentation sociale et citez son auteur fondateur.
2. Nommez les deux processus de formation d'une représentation.

3. Distinguez noyau central et éléments périphériques.
4. Distinguez norme descriptive et norme injonctive, avec un exemple alimentaire.
5. Citez les quatre stratégies d'acculturation de Berry.
6. Qu'est-ce que l'ethnocentrisme ? Pourquoi est-il un risque pour le diététicien ?

Corrigé – Point d'étape 3.3.3

1. Une connaissance de sens commun, partagée par un groupe, socialement construite, qui guide les conduites (Serge Moscovici, 1961).
2. L'objectivation (rendre concret un concept abstrait) et l'ancrage (l'intégrer dans des catégories déjà connues).
3. Le noyau central est stable, consensuel, résistant et donne son sens à la représentation ; les éléments périphériques sont plus souples, liés au contexte, et changent en premier.
4. Descriptive : ce que font la plupart des gens (« 7 familles sur 10 servent des légumes le soir »). Injonctive : ce qu'il faut faire, ce qui est approuvé (« il faut manger des légumes »).
5. Intégration, assimilation, séparation, marginalisation.
6. Juger les pratiques des autres cultures à partir des normes de sa propre culture ; il conduit à des conseils inadaptés et à la perte de confiance du public.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la suite.
3 ou 4 sur 6	Je relis les encadrés « À retenir » et les définitions de la section, puis je refais les questions manquées.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la section et je refais les exercices d'application.

3.3.4 La relation sociale et ses dynamiques

Module · Guide 2025 : p. 61 · CNED : Synthèse M5 S2 §1 (p. 35 et 36) ; Synthèse M5 S2 §2 (p. 36 à 38)

Le groupe et l'influence sociale

Définition – Groupe

Ensemble de personnes en **interaction**, qui partagent des objectifs, des normes et un sentiment d'appartenance, et dont les membres s'influencent mutuellement. Kurt Lewin (années 1940) a fondé l'étude de la **dynamique des groupes** : le groupe est un tout dont les propriétés dépassent la somme des individus.

Exemple – L'expérience fondatrice de Kurt Lewin (1943)

Pendant la Seconde Guerre mondiale, les autorités américaines voulaient que les ménagères cuisinent des **abats** (moins chers, disponibles) à la place des morceaux nobles de viande. Lewin a comparé deux méthodes : des **conférences** persuasives données par un expert, et des **discussions de groupe** où les participantes échangeaient puis décidaient collectivement. Résultat : environ **3 %** des femmes ayant assisté aux conférences ont ensuite cuisiné des abats, contre environ **32 %** de celles qui avaient participé aux discussions de groupe et pris une décision publique. **Leçons pour le diététicien** : la **participation** et la **décision prise en groupe** (engagement) changent davantage les comportements que l'information descendante ; c'est le fondement de l'approche participative en éducation pour la santé (chapitre 1).

Phénomène	Définition	Application en atelier
Conformisme (Asch, 1951)	Tendance à aligner son jugement ou son comportement sur celui du groupe, même s'il paraît erroné	Un participant n'ose pas goûter si les autres refusent : faire goûter l'animateur et un « leader » positif en premier
Soumission à l'autorité (Milgram, 1963)	Tendance à obéir à une figure d'autorité	La blouse ou le statut de professionnel donnent du poids aux paroles : éviter l'injonction, privilégier l'échange
Influence minoritaire (Moscovici, 1969)	Une minorité cohérente et constante peut faire évoluer la majorité	Quelques parents convaincus peuvent faire évoluer les goûters de toute une classe
Facilitation sociale	On mange en moyenne davantage à plusieurs que seul	Repas partagés pour stimuler l'appétit des personnes âgées dénutries
Normes du groupe	Règles implicites partagées	Définir avec le groupe ses règles (bienveillance, droit de ne pas aimer, confidentialité)

Comment naît une norme de groupe : quatre expériences classiques

Le tableau précédent résume les grands phénomènes d'influence. Il est utile de connaître les expériences qui les ont mis en évidence, car le jury attend des références précises et datées.

Expérience	Ce qui a été fait	Résultat principal	Leçon pour l'atelier
Effet autocinétique (Muzafer Sherif, 1935)	Dans une pièce noire, un point lumineux fixe paraît bouger. Chacun estime d'abord seul le déplacement, puis en groupe.	Les estimations individuelles, très différentes au départ, convergent vers une **norme commune** qui persiste ensuite quand la personne est de nouveau seule.	Face à une situation nouvelle (un aliment inconnu), le groupe fabrique sa propre norme : les premiers avis exprimés comptent beaucoup.
Lignes de Solomon Asch (1951)	Un participant naïf doit dire quelle ligne a la même longueur qu'une ligne modèle, après plusieurs complices qui donnent une réponse fausse.	Environ un tiers des réponses suivent la majorité erronée, et environ trois participants sur quatre se conforment au moins une fois. Il suffit d'**un seul allié** qui donne la bonne réponse pour que le conformisme chute fortement.	Un seul participant qui ose dire « j'aime bien » ou « je goûte » libère les autres.
Facilitation sociale (Norman Triplett, 1898 ; Robert Zajonc, 1965)	Comparaison de performances réalisées seul ou en présence d'autres personnes.	La présence d'autrui améliore les tâches **simples et maîtrisées** et gêne les tâches **complexes ou nouvelles**.	Un geste culinaire nouveau s'apprend mieux en petit binôme que devant tout le groupe.
Apprentissage par observation (Albert Bandura, 1961 ; théorie de l'apprentissage social, 1977)	Des enfants observent un adulte qui frappe ou non une poupée, puis sont laissés seuls avec elle.	Les enfants reproduisent le comportement observé, surtout si le modèle leur ressemble ou est valorisé.	Le **modèle** (animateur, pair, parent) qui goûte et cuisine est un puissant levier.

Exemple – Manger à plusieurs : la facilitation sociale de la prise alimentaire

Le psychologue John de Castro a fait tenir des carnets alimentaires détaillés à des adultes pendant sept jours. Les repas pris avec d'autres personnes étaient en moyenne **44 % plus importants** que les repas pris seul (de Castro et Brewer, 1992), et la quantité augmentait avec le nombre de convives. Ce résultat a deux usages opposés :

- en **gériatrie** ou en EHPAD, le repas partagé est un outil contre la **dénutrition** (chapitre 4) : mieux vaut une table conviviale qu'un plateau en chambre quand c'est possible ;
- dans un atelier destiné à des adultes qui veulent mieux réguler leurs apports, on parle des repas de fête et des buffets sans culpabiliser, en travaillant les signaux de faim et de rassasiement.

Définition – Influence informationnelle et influence normative (Deutsch et Gerard, 1955)

- L'**influence informationnelle** : on suit le groupe parce qu'on pense qu'il a raison (« s'ils trouvent cela bon, c'est sûrement bon »). Elle est forte quand la situation est **ambiguë** ou nouvelle (expérience de Sherif). Elle produit un changement durable, même en privé.
- L'**influence normative** : on suit le groupe pour être accepté et éviter le rejet (expérience d'Asch). Elle produit surtout un changement **public**, qui peut disparaître quand la personne est seule.

Conséquence : une dégustation « parce que tout le monde goûte » (normative) change peu les habitudes à la maison ; une dégustation suivie d'un échange sur le goût et la recette (informationnelle) a plus de chances de durer.

À vous de jouer – Exercice d'application 3.8

Lors d'un atelier en foyer de jeunes travailleurs, l'animatrice propose un houmous de pois chiches. Le premier jeune à qui elle tend la cuillère dit « Beurk, ça a l'air bizarre ». Les cinq suivants refusent aussi. a) Quel phénomène observe-t-on ? Citez l'expérience correspondante. b) Quel type d'influence domine ici ? c) Proposez deux façons d'organiser la dégustation pour limiter cet effet.

Corrigé

a) C'est un **conformisme** : les jeunes alignent leur comportement sur le premier avis exprimé (Asch, 1951 ; la première réponse fixe aussi une norme, comme chez Sherif, 1935). **b)** Surtout une **influence normative** : on refuse pour ne pas se démarquer devant les autres, plus que parce qu'on est convaincu que le houmous est mauvais. **c)** Faire goûter d'abord l'animatrice et un jeune volontaire connu pour être curieux (un **allié** suffit à réduire le conformisme) ; faire goûter **en même temps** et en silence, puis noter son avis sur une fiche avant d'en parler ; présenter le plat avec des repères familiers (pain pita, crudités à tremper).

Attitudes, dissonance cognitive et engagement

Définition – Dissonance cognitive (Leon Festinger, 1957)

État d'inconfort ressenti lorsqu'une personne a des cognitions (pensées, croyances, comportements) **contradictoires** (« je fume / fumer tue »). Pour réduire cet inconfort, elle modifie l'une des cognitions : changer son comportement… ou, plus souvent, **rationaliser** (« mon grand-père a fumé et a vécu vieux »). Les messages culpabilisants augmentent la dissonance et provoquent souvent le rejet du message.

Définition – Engagement (Kiesler, 1971 ; Joule et Beauvois, 1987)

Lien qui unit une personne à ses actes. Un acte réalisé **librement**, **publiquement**, de façon **répétée** et **coûteuse** engage davantage la personne et favorise le maintien du comportement. La technique du **pied-dans-la-porte** consiste à obtenir d'abord un petit acte (goûter une cuillère de lentilles) avant une demande plus importante (cuisiner une recette à la maison).

Lien diététique – Appliquer l'engagement en atelier

- Faire **choisir librement** une recette à refaire à la maison (« vous êtes libre de… » augmente l'engagement).
- Faire énoncer un petit **objectif personnel** devant le groupe (« je vais essayer les lentilles une fois cette semaine »).
- Revenir sur cet engagement à la séance suivante, en valorisant chaque essai.
- Rester **éthique** : ces techniques servent l'intérêt de la personne et ne doivent jamais manipuler ni

contraindre (chapitre 6).

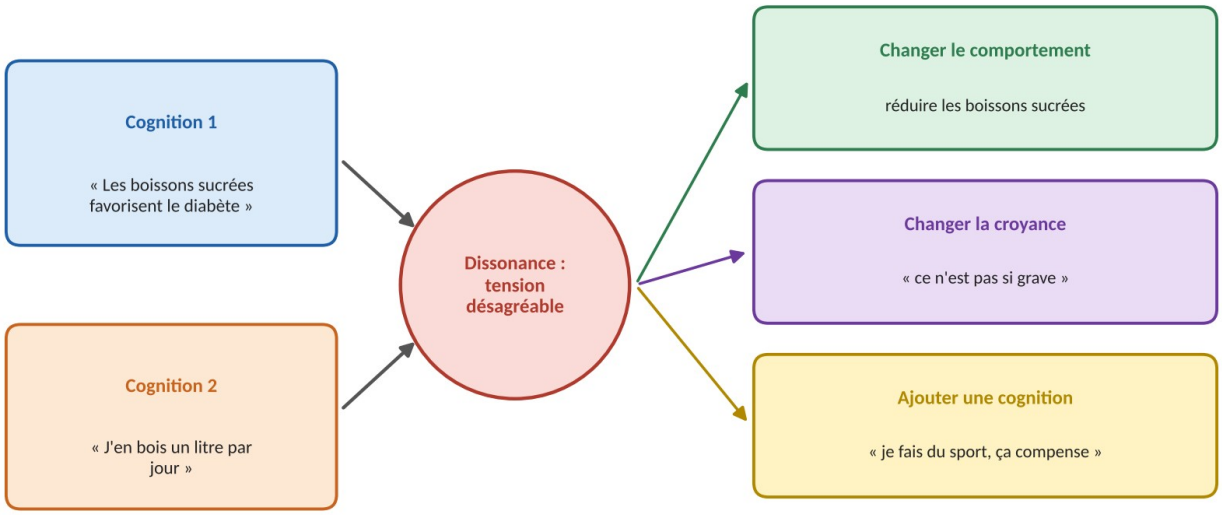


Figure 3.2 bis – La dissonance cognitive et ses trois issues

Comprendre le schéma – Figure 3.2 bis

1. À gauche, deux **cognitions** qui se contredisent : une connaissance (« les boissons sucrées favorisent le diabète ») et un comportement (« j'en bois un litre par jour »).
2. Au centre, la **dissonance** : un état d'inconfort désagréable que la personne cherche à réduire.
3. À droite, trois issues possibles : **changer le comportement** (réduire les boissons sucrées : la seule issue qui intéresse la santé publique), **changer la croyance** (« ce n'est pas si grave ») ou **ajouter une cognition** qui justifie (« je fais du sport, ça compense »).
4. Les deux dernières issues sont les plus faciles, donc les plus fréquentes : un message qui augmente fortement la dissonance sans donner de moyen d'agir pousse vers le déni plutôt que vers le changement.

Deux expériences fondatrices sur la dissonance et l'engagement

Exemple – L'expérience de Festinger et Carlsmith (1959)

Des étudiants réalisent pendant une heure une tâche très ennuyeuse (tourner des chevilles sur une planche). On leur demande ensuite de dire à l'étudiant suivant que la tâche était intéressante. Certains reçoivent **1 dollar** pour ce mensonge, d'autres **20 dollars**. Interrogés ensuite, ceux qui ont reçu 1 dollar jugent la tâche **plus agréable** que ceux qui ont reçu 20 dollars et que les étudiants d'un groupe témoin.

Explication : avec 20 dollars, le mensonge est justifié par l'argent ; avec 1 dollar, il ne l'est pas, et la seule façon de réduire la dissonance est de changer d'avis sur la tâche. **Leçon** : une petite incitation, ou aucune, engage davantage qu'une grosse récompense ; c'est un argument de plus contre les récompenses en éducation nutritionnelle (section 3.3.11).

Exemple – Le pied-dans-la-porte (Freedman et Fraser, 1966)

Des chercheurs demandent à des propriétaires californiens d'installer dans leur jardin un grand panneau peu esthétique « Conduisez prudemment ». Sans préparation, **16,7 %** acceptent (groupe témoin). Dans un autre groupe, on avait demandé deux semaines plus tôt de coller un petit autocollant sur le même thème, ce que presque tous avaient accepté. Dans ce groupe, **76 %** acceptent ensuite le grand panneau.

Leçon : obtenir d'abord un petit acte, librement consenti, rend plus probable un acte plus important. En

atelier, on demande d'abord de goûter une cuillère, puis de choisir une recette à refaire.

Technique d'engagement	Principe	Exemple éthique en nutrition
Pied-dans-la-porte	Un petit acte préalable facilite une demande plus coûteuse.	Goûter une cuillère de soupe de légumes, puis noter la recette pour la refaire.
Porte-au-nez (Cialdini et collaborateurs, 1975)	Après le refus d'une demande excessive, une demande modérée est plus souvent acceptée (dans l'expérience originale, 50 % contre 16,7 % sans demande préalable).	« Vous pourriez cuisiner tous les soirs ? Non ? Alors une fois cette semaine ? » À utiliser avec prudence : la première demande ne doit pas être culpabilisante.
Déclaration de liberté (« vous êtes libre de… »)	Rappeler la liberté de refuser augmente l'acceptation et l'engagement.	« Vous êtes libre de goûter ou non. »
Engagement public	Un engagement annoncé devant d'autres est mieux tenu qu'un engagement privé.	Chacun dit au groupe le petit changement qu'il essaiera.
Communication engageante (Joule, Girandola et Bernard, 2007)	Associer un message de prévention à un **acte** préparatoire (signer, choisir, essayer) plutôt qu'au message seul.	Après l'exposé sur l'eau, chaque élève remplit sa gourde et la décore.

Définition – Amorçage

L'**amorçage** est l'effet d'un premier stimulus, souvent non remarqué, sur une réaction qui suit. Une affiche colorée de légumes à l'entrée du self, l'odeur du pain chaud ou la place d'un produit au début de la ligne de service peuvent orienter les choix sans que la personne s'en rende compte. C'est la base de nombreux **nudges** (section 3.3.11 et chapitre 6). Les effets d'amorçage sont souvent plus faibles et moins reproductibles qu'on ne l'a cru : on les évalue toujours sur le terrain.

Attention – Engager sans manipuler

Les techniques d'engagement sont puissantes. Elles sont éthiques si elles servent l'**intérêt de la personne**, si l'objectif est **transparent** (la personne pourrait l'accepter si on le lui expliquait) et si la personne garde sa **liberté** de refuser. Elles deviennent de la manipulation quand elles servent un intérêt commercial ou institutionnel caché, ou quand on exploite la honte et la peur (chapitre 6).

À vous de jouer – Exercice d'application 3.9

Un collège veut que les élèves boivent davantage d'eau. Le principal propose de distribuer un bon d'achat de 10 € aux élèves qui viennent avec une gourde pendant un mois. a) Que prévoit la théorie de la dissonance sur l'effet à long terme de cette récompense ? b) Proposez une action fondée sur l'engagement à la place. c) À quelles conditions cette action reste-t-elle éthique ?

Corrigé

a) La récompense importante fournit une **justification externe** (« je prends ma gourde pour le bon d'achat ») : comme dans l'expérience de Festinger et Carlsmith, l'attitude envers l'eau change peu, et le comportement risque de s'arrêter avec la récompense. **b)** Un **pied-dans-la-porte** : chaque élève choisit et décore librement sa gourde en classe (petit acte, libre, public), puis le groupe décide d'un défi « une gourde pleine par jour » avec un suivi collectif ; on rappelle la liberté de participer. **c)** L'objectif est connu des élèves

> et de leurs familles, la participation est libre, aucun élève n'est montré du doigt, et l'action sert leur santé (pas une marque d'eau).

Stéréotypes, préjugés, discrimination, stigmatisation

- **Stéréotype** : croyance généralisée sur les caractéristiques d'un groupe (« les personnes obèses manquent de volonté »).
- **Préjugé** : attitude (souvent négative) envers les membres d'un groupe.
- **Discrimination** : comportement défavorable envers une personne en raison de son appartenance réelle ou supposée à un groupe (interdite par la loi pour plus de 25 critères, dont l'apparence physique).
- **Stigmatisation** (Erving Goffman, 1963) : processus par lequel une caractéristique (le poids, la pauvreté, l'origine) disqualifie la personne et la réduit à cet attribut. La **stigmatisation du poids** augmente le stress, l'évitement des soins, les comportements alimentaires désordonnés et la prise de poids.

Juger autrui : théories implicites, fonctions des stéréotypes et des préjugés

- Les **théories implicites de la personnalité** (TIP), décrites par Jerome Bruner et Renato Tagiuri (1954), sont les croyances « naïves » qui nous font déduire la personnalité d'une personne à partir de quelques indices (« il est gros, donc il manque de volonté »). Elles ne sont pas vérifiées scientifiquement.
- Les **stéréotypes** ont trois fonctions : **expliquer** un événement (en désignant un groupe responsable), **justifier** un comportement envers ce groupe, **anticiper** ce que l'autre va faire.
- Les **préjugés** ont trois fonctions : **différencier** son groupe des autres, **économiser** l'effort de réflexion, **rationaliser** en servant de norme au groupe.
- La **discrimination** est le comportement qui en découle (Myers et Lamarche) : traiter différemment une personne à cause de son groupe. En droit français, elle est interdite pour plus de vingt critères, dont l'apparence physique et l'état de santé (article 225-1 du Code pénal).

Communiquer : modèle, distances, états du moi et rumeurs

- **Modèle de Shannon et Weaver (1949)** : un émetteur code un message, qui passe par un canal jusqu'à un récepteur qui le décode ; des **bruits** peuvent le déformer. Le schéma de la communication de la section 3.3.8 le complète par la rétroaction.
- **Trois images** guident notre façon d'entrer en relation : le **moi intime** (ce que je pense être), le **moi public** (ce que je veux montrer) et la **représentation d'autrui** (l'image que j'ai de l'autre).
- **Proxémie** (Edward T. Hall, 1966) : chacun règle la distance selon la relation. Repères : distance **intime** (moins de 45 cm), **personnelle** (45 cm à 1,2 m), **sociale** (1,2 à 3,6 m), **publique** (au-delà de 3,6 m). La **place** occupée compte aussi : face à face (confrontation), côte à côte (coopération).
- **Analyse transactionnelle** (Eric Berne, années 1960) : chaque personne passe par trois **états du moi**, **Parent** (règles, protection), **Adulte** (faits, raisonnement), **Enfant** (émotions, spontanéité). Un conseil donné sur le ton du Parent (« vous devez ») appelle souvent une réponse de l'Enfant (révolte ou soumission) ; l'entretien éducatif vise un échange Adulte-Adulte.
- **Rumeurs** : Gordon Allport et Leo Postman (1947) ont montré qu'un récit transmis de bouche à oreille perd la plupart de ses détails après cinq ou six personnes. Trois mécanismes le déforment : la **réduction** (on oublie), l'**accentuation** (on grossit certains détails) et l'**assimilation** (on adapte le récit à ses attentes et à ses stéréotypes). Une rumeur réussit quand l'information est frappante, la source jugée crédible et le démenti difficile.

> **À vous de jouer – Exercice d'application 3.10**
>
> Dans un collège, une rumeur circule : « La viande de la cantine est périmée ; un élève a été malade. » La fréquentation baisse de 412 à 338 repas par jour. a) Calculez la baisse en nombre et en pourcentage. b) Nommez deux mécanismes de déformation probables. c) Proposez une réponse de la diététicienne.

Corrigé

a) 412 − 338 = **74 repas** ; 74 / 412 × 100 = **18,0 %** de baisse. b) **Accentuation** (un malaise isolé devient « la viande périmée ») et **assimilation** (le récit confirme le stéréotype « la cantine, c'est mauvais »). c) Ne pas nier en bloc, ce qui renforcerait la rumeur ; donner des **faits vérifiables** (traçabilité, dates limites, résultats du dernier contrôle), inviter des parents et des délégués à visiter la cuisine, faire goûter, et s'appuyer sur des **élèves relais** crédibles pour leurs pairs.

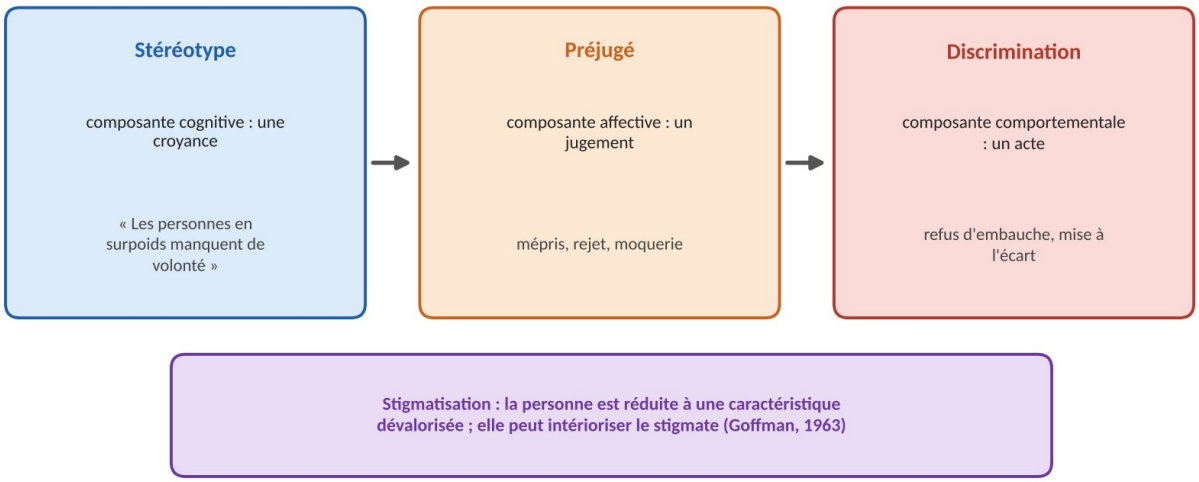


Figure 3.2 ter – Du stéréotype à la discrimination

Comprendre le schéma – Figure 3.2 ter

1. Le **stéréotype** est une **croyance** : il relève de la pensée (« les personnes en surpoids ne font pas d'efforts »).
2. Le **préjugé** est une **attitude**, chargée d'émotion : il relève du jugement (« elles m'agacent », mépris, gêne).
3. La **discrimination** est un **comportement** : traiter moins bien une personne à cause de son appartenance réelle ou supposée à un groupe (ne pas l'embaucher, lui parler avec condescendance, ne pas l'examiner).
4. En bas, la **stigmatisation** englobe tout le processus : la personne est réduite à une caractéristique dévalorisée, et elle peut finir par **intérioriser le stigmate** (Goffman, 1963), c'est-à-dire se dévaloriser elle-même. Le stigmate s'installe aussi dans les institutions (mobilier inadapté, messages de campagne humiliants).
5. Les flèches ne sont pas automatiques : on peut connaître un stéréotype sans y adhérer, et le cadre professionnel (déontologie, formation) peut empêcher le passage au comportement.

La menace du stéréotype

Exemple – Steele et Aronson (1995)

Des étudiants afro-américains et blancs de l'université Stanford passent un test difficile de compréhension verbale. Quand le test est présenté comme une mesure des **capacités intellectuelles**, les étudiants afro-américains réussissent moins bien que les étudiants blancs de même niveau. Quand le **même test** est présenté comme un simple exercice de laboratoire, l'écart disparaît.

Explication : la peur de confirmer un stéréotype négatif sur son groupe crée une anxiété qui diminue la performance. Le même effet a été observé chez des femmes dans des tests de mathématiques (Spencer, Steele et Quinn, 1999).

En nutrition : une personne en surpoids, à qui l'on rappelle sans cesse qu'elle « manque de volonté », peut se sentir incapable dans un atelier culinaire ou une activité physique, et éviter d'y revenir. Un cadre qui ne

renvoie pas au poids protège la participation.

À retenir – Les effets de la stigmatisation du poids

Les revues de la littérature (Puhl et Heuer, 2009 et 2010) montrent que la stigmatisation du poids est répandue, y compris chez les professionnels de santé. Elle ne motive pas à perdre du poids : elle est associée à plus de stress, à une alimentation émotionnelle et à des épisodes d'hyperphagie, à moins d'activité physique, à un **évitement des soins** (rendez-vous annulés, dépistages repoussés) et à une moins bonne estime de soi. Une déclaration internationale de consensus, publiée en 2020 dans *Nature Medicine* (Rubino et collaborateurs), appelle les professionnels et les médias à y mettre fin.

Les biais implicites : les professionnels aussi

Définition – Attitude implicite et test d'association implicite

Une **attitude implicite** est une évaluation automatique, souvent inconsciente, qui peut différer de ce que la personne déclare penser. Le **test d'association implicite** (Greenwald, McGhee et Schwartz, 1998) la mesure à partir des temps de réaction : on associe plus vite deux notions qui sont déjà liées dans la mémoire (par exemple « mince » et « bon »). Une étude menée auprès de près de 400 professionnels spécialistes de l'obésité (Schwartz et collaborateurs, 2003) a montré qu'eux aussi associaient plus facilement les personnes obèses à des adjectifs comme « paresseux » ou « sans valeur ».

Lien diététique – Que faire de ses propres biais ?

Avoir des biais ne fait pas de quelqu'un un mauvais professionnel : ils viennent de la socialisation et des images diffusées par la société. Ce qui compte, c'est de les **connaître** et d'empêcher qu'ils guident les pratiques : utiliser une grille d'entretien identique pour tous, vérifier son langage et ses supports (méthode ci-dessous), s'interroger après une séance difficile (« aurais-je réagi de la même façon avec une autre personne ? »), en parler en analyse de pratiques.

Méthode pas à pas – Vérifier qu'une action ne stigmatise pas

1. **Langage** : dire « une personne vivant avec une obésité » plutôt qu'« un obèse » ; éviter « combat », « lutte contre les kilos », « mauvais aliments ».
2. **Images** : refuser les photos de corps sans tête, de ventres ou de personnes en train de manger seules de la malbouffe ; préférer des personnes de toutes corpulences en activité.
3. **Cible du message** : parler de comportements favorables (cuisiner, bouger, partager un repas) et de leurs bénéfices immédiats, pas du poids.
4. **Environnement** : prévoir des chaises sans accoudoirs et solides, un tablier de grande taille, ne pas peser en public.
5. **Recrutement** : proposer l'action à tous plutôt qu'aux seules « personnes en surpoids » (universalisme proportionné, chapitre 2).
6. **Relecture** : faire relire le support par des personnes concernées avant de le diffuser.

À vous de jouer – Exercice d'application 3.11

Une mairie prépare une affiche pour un cycle d'ateliers : la photo montre le ventre d'un homme en surpoids qui tient un hamburger, avec le titre « Stop à la malbouffe : reprenez le contrôle de votre poids ! ». a) Relevez trois éléments stigmatisants. b) Expliquez, avec la notion de menace du stéréotype, pourquoi cette affiche risque d'éloigner le public visé. c) Proposez un nouveau titre et une nouvelle image.

Corrigé

a) Un corps **sans tête** réduit la personne à son ventre ; l'association surpoids et « malbouffe » renforce le **stéréotype** de la personne qui mange mal par manque de volonté ; le titre culpabilise (« reprenez le contrôle ») et centre sur le **poids**. **b)** Les personnes concernées se sentent visées et jugées ; la peur de confirmer le stéréotype devant le groupe crée une anxiété qui les dissuade de s'inscrire, ou de revenir après une première séance. **c)** Par exemple « Cuisiner simple, bon et pas cher : venez essayer ! » avec une photo d'un groupe varié (âges, corpulences, origines) en train de cuisiner ensemble.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 3.3.4 – Influence sociale, engagement, stigmatisation

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quel a été le résultat principal de l'expérience de Lewin (1943) ?
2. Qu'a montré Asch (1951) ? Quel facteur fait chuter le conformisme ?
3. Distinguez influence informationnelle et influence normative.
4. Expliquez le résultat de Festinger et Carlsmith (1959).
5. Décrivez la technique du pied-dans-la-porte avec les chiffres de Freedman et Fraser (1966).
6. Distinguez stéréotype, préjugé et discrimination.

Corrigé – Point d'étape 3.3.4

1. Environ 3 % des femmes ayant assisté aux conférences ont cuisiné des abats, contre environ 32 % après une discussion et une décision de groupe.
2. Environ un tiers des réponses suivent une majorité qui se trompe ; la présence d'un seul allié qui donne la bonne réponse fait fortement chuter le conformisme.
3. Informationnelle : on suit le groupe parce qu'on pense qu'il a raison ; changement durable. Normative : on le suit pour être accepté ; changement surtout public.
4. Les étudiants payés 1 dollar pour mentir ont jugé la tâche plus agréable que ceux payés 20 dollars : sans justification externe, ils ont réduit la dissonance en changeant d'avis.
5. Obtenir d'abord un petit acte (un autocollant) rend plus probable un acte plus coûteux : 76 % ont accepté le grand panneau, contre 16,7 % sans demande préalable.
6. Stéréotype : une croyance sur un groupe ; préjugé : une attitude, un jugement affectif ; discrimination : un comportement défavorable.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la suite.
3 ou 4 sur 6	Je relis les encadrés « À retenir » et les définitions de la section, puis je refais les questions manquées.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la section et je refais les exercices d'application.

3.3.5 Les compétences psychosociales

Module · Guide 2025 : p. 61 · CNED : pas de passage correspondant (voir 3.2.2)

Définition – Compétences psychosociales (CPS)

Selon Santé publique France (2022), les CPS sont « un ensemble cohérent et interrelié de capacités psychologiques (cognitives, émotionnelles et sociales), impliquant des connaissances, des processus intrapsychiques et des comportements spécifiques, qui permettent d'augmenter l'autonomisation et le

pouvoir d'agir, de maintenir un état de bien-être psychique, de favoriser un fonctionnement individuel optimal et de développer des interactions constructives ». L'OMS les avait définies en 1993 comme la capacité d'une personne à répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne, et en avait proposé une liste de 10 (en 5 couples).

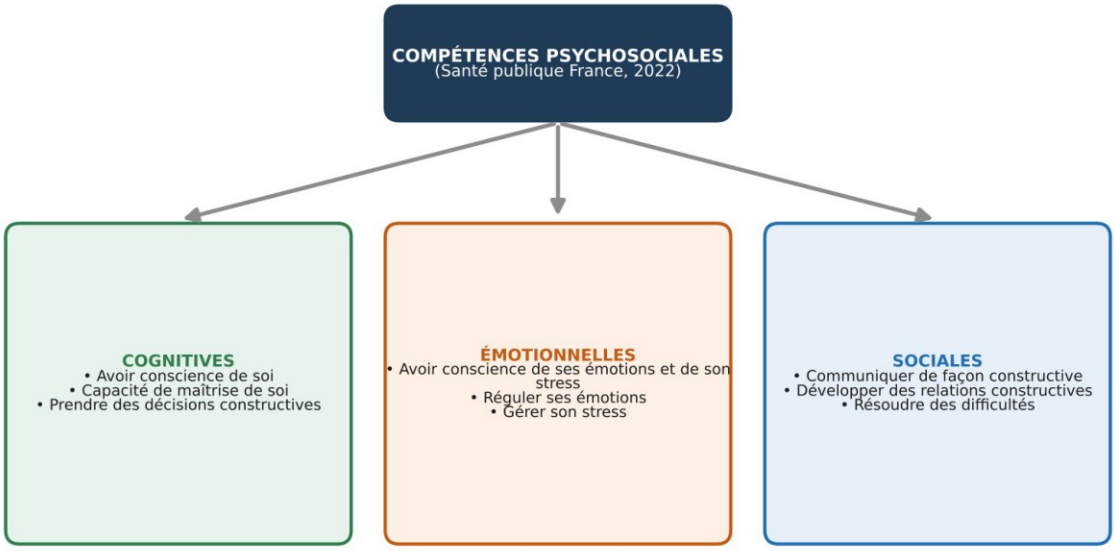


Figure 3.3 – Les 9 compétences psychosociales générales (Santé publique France, 2022)

Comprendre le schéma – Figure 3.3

1. Le référentiel de Santé publique France organise les CPS en **trois catégories**, chacune comportant **trois CPS générales**, elles-mêmes déclinées en CPS spécifiques (une vingtaine au total).
2. **Cognitives** : avoir conscience de soi (connaissance de soi, pensée critique), capacité de maîtrise de soi, prendre des décisions constructives.
3. **Émotionnelles** : avoir conscience de ses émotions et de son stress, réguler ses émotions, gérer son stress.
4. **Sociales** : communiquer de façon constructive (écoute empathique, communication efficace), développer des relations constructives, résoudre des difficultés (demander de l'aide, résoudre des conflits).
5. Les CPS sont un **déterminant majeur** de la santé et du bien-être ; leur développement chez les enfants et les jeunes est une priorité nationale (stratégie interministérielle 2022-2037). Les programmes efficaces sont **structurés**, **interactifs**, **répétés** et animés par des professionnels formés.

CPS	Exemple d'activité en lien avec l'alimentation
Pensée critique	Analyser une publicité pour un produit sucré destiné aux enfants : que cherche-t-elle à me faire croire ?
Prise de décision	Composer un menu à 10 € pour 4 personnes en arbitrant goût, prix et équilibre
Conscience et régulation des émotions	Repérer la différence entre faim physique et envie de manger liée à l'ennui ou au stress ; échelle de la faim
Gestion du stress	Proposer d'autres réponses que la nourriture au stress (respiration, marche, parler à quelqu'un)
Communication constructive	Jeu de rôle : dire non poliment à une seconde portion ou à un soda proposé par un ami
Relations constructives	Cuisiner en binôme, répartir les tâches, s'entraider

CPS	Exemple d'activité en lien avec l'alimentation
Estime de soi (conscience de soi)	Valoriser chaque réussite culinaire ; photographier et exposer les plats réalisés (avec accord)

De la liste de l'OMS (1993) au référentiel de Santé publique France (2022)

La première liste de compétences psychosociales a été publiée par l'OMS en 1993, dans un document destiné aux écoles (*Life skills education in schools*). Elle comptait **10 compétences regroupées en 5 couples**. Elle est encore très citée dans les projets et dans les sujets d'examen : il faut savoir la relier au référentiel actuel.

Couple de CPS (OMS, 1993)	Correspondance dans le référentiel de Santé publique France (2022)
Savoir résoudre des problèmes / savoir prendre des décisions	Compétences cognitives : prendre des décisions constructives ; compétences sociales : résoudre des difficultés
Avoir une pensée créative / avoir une pensée critique	Compétences cognitives : avoir conscience de soi (pensée critique)
Savoir communiquer efficacement / être habile dans les relations interpersonnelles	Compétences sociales : communiquer de façon constructive, développer des relations constructives
Avoir conscience de soi / avoir de l'empathie pour les autres	Compétences cognitives : avoir conscience de soi ; compétences sociales : écoute empathique
Savoir gérer son stress / savoir gérer ses émotions	Compétences émotionnelles : avoir conscience de ses émotions et de son stress, réguler ses émotions, gérer son stress

À retenir – Pourquoi un nouveau référentiel en 2022 ?

Santé publique France a actualisé la liste de l'OMS à partir des connaissances scientifiques récentes. Le référentiel de 2022 distingue trois **catégories** (cognitives, émotionnelles, sociales), **9 CPS générales** et des CPS **spécifiques**. Il insiste sur le fait que les CPS se renforcent entre elles et qu'elles s'apprennent tout au long de la vie. Une **instruction interministérielle du 19 août 2022** fixe l'objectif que toute une génération d'enfants bénéficie d'interventions de développement des CPS d'ici 2037.

Ce qui rend un programme CPS efficace

Une méta-analyse de 213 programmes scolaires de développement des compétences sociales et émotionnelles (Durlak et collaborateurs, 2011), portant sur plus de 270 000 élèves, a montré une amélioration des compétences, des comportements et même des résultats scolaires. Les programmes efficaces respectaient quatre critères, résumés par l'acronyme anglais **SAFE**.

Critère SAFE	Signification	Traduction pour une action nutrition
Sequenced (séquencé)	Des activités organisées en progression, de séance en séance	Un cycle de 8 à 10 séances, chacune s'appuyant sur la précédente, plutôt qu'une intervention isolée
Active (actif)	Des méthodes où l'on pratique	Jeux de rôle, cuisine, analyse de publicités, plutôt qu'un exposé
Focused (centré)	Un temps suffisant consacré à chaque compétence	Une ou deux CPS ciblées par séance, explicitement travaillées
Explicit (explicite)	Des objectifs de compétence clairs et annoncés	« Aujourd'hui, nous apprenons à dire non à une proposition sans vexer la personne. »

Des programmes validés utilisés en France

Programme	Public	Principe
PSFP (Programme de soutien aux familles et à la parentalité)	Familles avec enfants de 3 à 11 ans	Adaptation française d'un programme américain (*Strengthening Families Program*) : 14 séances réunissant parents et enfants, d'abord séparément puis ensemble
GBG (*Good Behavior Game*, jeu du comportement favorable)	Élèves d'école élémentaire	Jeu d'équipe en classe qui renforce les comportements favorables et l'autorégulation
Unplugged	Collégiens de 12 à 14 ans	12 séances interactives de prévention des conduites addictives, centrées sur les CPS et la correction des fausses croyances sur les normes (« tout le monde boit »)
Tina et Toni	Enfants de 4 à 6 ans	Programme d'origine suisse fondé sur des histoires et des jeux autour des émotions et des relations

Lien diététique – Place du diététicien

Ces programmes ne sont pas centrés sur l'alimentation, mais ils montrent ce qui marche : durée, interactivité, formation des intervenants. Le diététicien peut s'associer à un programme CPS existant dans une école ou un centre social, en y apportant des séances sur le goût, le marketing alimentaire ou le repas familial, plutôt que de créer une intervention isolée.

À vous de jouer – Exercice d'application 3.12

Une infirmière scolaire propose au diététicien une intervention unique d'une heure en classe de 5e, sous forme d'exposé sur « les dangers du sucre », pour « développer les compétences psychosociales ». a) Montrez, à l'aide des critères SAFE, que ce projet n'est pas une action CPS. b) Proposez une version améliorée en trois séances, en indiquant pour chacune la CPS visée et une activité.

Corrigé

a) Une séance unique n'est pas **séquencée** ; un exposé n'est pas **actif** ; aucune compétence n'est ciblée (**F**) ni annoncée (**E**) : c'est une action d'information. **b)** Séance 1, **pensée critique** : analyser en groupe trois publicités pour des boissons sucrées (cible, promesse, ce qui est caché). Séance 2, **prise de décision** : composer un goûter avec un budget de 1,50 € et justifier le choix devant la classe. Séance 3, **communication constructive** : jeux de rôle « refuser une boisson énergisante proposée par un ami » et retour sur les ressentis. Chaque séance commence par l'annonce de la compétence travaillée et se termine par un temps de retour.

3.3.6 Image corporelle, émotions, estime de soi

Module · Guide 2025 : p. 61 · CNED : pas de passage correspondant (voir 3.2.2)

Définition – Image corporelle

Représentation mentale que l'on se fait de son propre corps : perception (taille, forme), pensées et croyances, émotions qu'il suscite, et comportements qui en découlent. L'**insatisfaction corporelle** est l'écart entre le corps perçu et le corps idéal ; elle est fréquente dès l'enfance, influencée par les normes de minceur ou de muscularité diffusées par les médias et les réseaux sociaux, et constitue un **facteur de risque** de restrictions alimentaires, de régimes répétés et de troubles du comportement alimentaire (TCA).

Définition – Émotions

Réactions brèves et intenses à une situation, associant des manifestations physiologiques, des expressions et des tendances à l'action. Paul Ekman décrit six émotions de base universelles : joie, tristesse, colère, peur, dégoût, surprise. Le **dégoût** joue un rôle central dans les refus alimentaires ; la **peur** de la nouveauté dans la néophobie. L'**alimentation émotionnelle** désigne le fait de manger en réponse à des émotions plutôt qu'à la faim.

Définition – Estime de soi et confiance en soi

- L'**estime de soi** est la valeur qu'une personne s'attribue (Rosenberg, 1965) ; elle conditionne la capacité à prendre soin de soi.
- La **confiance en soi** porte sur la capacité perçue à agir ; elle est proche du **sentiment d'efficacité personnelle** de Bandura (« je suis capable de cuisiner ce plat »).

Attention – Prévenir sans nuire

- Ne jamais **peser** ni commenter le corps des participants en public.
- Éviter les messages centrés sur le **poids** et l'apparence ; centrer sur la santé, le plaisir, l'énergie, la convivialité.
- Ne pas présenter d'aliments comme « interdits » ou « mauvais » : cela renforce la culpabilité et les restrictions.
- Repérer les signes d'alerte de TCA (restriction importante, préoccupation excessive pour le poids, vomissements, hyperphagie) et **orienter** vers le médecin ou une structure spécialisée (BC1), sans poser de diagnostic.

Évaluer l'image du corps et l'estime de soi : deux outils

Dans un diagnostic ou une évaluation, on peut mesurer l'image du corps et l'estime de soi avec des outils validés. Le diététicien ne pose aucun diagnostic psychologique : il utilise ces outils pour **décrire un groupe** et adapter l'action, avec l'accord des personnes et de façon anonyme.

Définition – L'échelle des silhouettes (Stunkard, Sørensen et Schulsinger, 1983)

Neuf dessins de silhouettes, de la plus mince (1) à la plus corpulente (9). La personne indique la silhouette qui lui ressemble le plus (silhouette **perçue**) et celle qu'elle aimerait avoir (silhouette **idéale**). L'écart **perçue moins idéale** mesure l'insatisfaction : un écart positif signale un désir de minceur, un écart négatif un désir d'être plus fort ou plus musclé (fréquent chez les garçons), un écart nul l'absence d'insatisfaction.

Calcul détaillé – L'insatisfaction corporelle dans une classe de 3e (données fictives, 24 élèves)

Écart perçue − idéale	Filles (n = 12)	Garçons (n = 12)
−2	0	2
−1	1	4
0	3	4
+1	5	2
+2	3	0

- Filles insatisfaites (écart différent de 0) : 12 − 3 = 9, soit 9 / 12 = **75,0 %** ; dont désir de minceur : 5 + 3 = 8,

soit **66,7 %**.

- Garçons insatisfaits : 12 − 4 = 8, soit **66,7 %** ; dont désir d'être plus fort : 2 + 4 = 6, soit **50,0 %**.
- Écart moyen des filles : (−1 × 1 + 0 × 3 + 1 × 5 + 2 × 3) / 12 = (−1 + 0 + 5 + 6) / 12 = 10 / 12 = **+0,83**.
- Écart moyen des garçons : (−2 × 2 − 1 × 4 + 0 × 4 + 1 × 2) / 12 = (−4 − 4 + 0 + 2) / 12 = −6 / 12 = **−0,50**.

Lecture : l'insatisfaction concerne les deux sexes, mais dans des directions opposées. Une moyenne proche de zéro peut cacher des insatisfactions fortes dans les deux sens : il faut toujours regarder la **répartition**. Les actions porteront sur la diversité des corps et la critique des images des réseaux sociaux, pour les filles comme pour les garçons, sans parler de poids.

Définition – L'échelle d'estime de soi de Rosenberg (1965)

Dix affirmations, cotées de 1 (« tout à fait en désaccord ») à 4 (« tout à fait en accord »). Cinq affirmations sont positives (« Je pense que je possède un certain nombre de belles qualités ») et cinq négatives (« J'aimerais avoir plus de respect pour moi-même »). Les affirmations négatives sont **inversées** (score inversé = 5 − réponse). Le score total va de **10 à 40** : plus il est élevé, plus l'estime de soi est forte. L'échelle existe en version française validée (Vallières et Vallerand, 1990).

Calcul détaillé – Le score d'estime de soi de Lina, 15 ans

Réponses aux 5 items positifs : 3, 2, 3, 2, 3 ; total = **13**.

Réponses aux 5 items négatifs : 3, 4, 2, 3, 3 ; scores inversés : 5 − 3 = 2 ; 5 − 4 = 1 ; 5 − 2 = 3 ; 5 − 3 = 2 ; 5 − 3 = 2 ; total = **10**.

Score total : 13 + 10 = **23 sur 40**, soit, ramené sur 100 : (23 − 10) / (40 − 10) × 100 = 13 / 30 × 100 = **43 / 100**.

Lecture : estime de soi plutôt basse. Le score ne sert pas à « étiqueter » Lina : il aide l'équipe à prévoir des activités valorisantes. Un score très bas associé à d'autres signes (isolement, restriction alimentaire) justifie d'en parler à l'infirmière ou au psychologue scolaire.

Repérer les signaux d'alerte de troubles du comportement alimentaire

Méthode pas à pas – Le questionnaire SCOFF-F

Le questionnaire SCOFF (Morgan et collaborateurs, 1999), validé en français sous le nom de SCOFF-F, est cité par la HAS (recommandation sur l'anorexie mentale, 2010) comme outil de **repérage**. Il comporte cinq questions fermées :

1. Vous faites-vous vomir parce que vous vous sentez mal d'avoir trop mangé ?
2. Vous inquiétez-vous d'avoir perdu le contrôle de ce que vous mangez ?
3. Avez-vous récemment perdu plus de 6 kg en 3 mois ?
4. Pensez-vous que vous êtes gros(se) alors que d'autres vous trouvent trop mince ?
5. Diriez-vous que la nourriture domine votre vie ?

Deux réponses positives ou plus font suspecter un TCA. Le repérage est suivi d'une **orientation** vers le médecin traitant ou une structure spécialisée ; il ne s'agit jamais d'un diagnostic.

Attention – En action collective

On ne fait pas remplir de questionnaire de repérage des TCA dans un atelier collectif sans cadre médical, sans information des personnes et sans circuit d'orientation prévu. En action collective, le diététicien observe, écoute et oriente individuellement et discrètement si une personne l'inquiète.

À vous de jouer – Exercice d'application 3.13

Dans un groupe de 10 lycéennes, les écarts silhouette perçue moins silhouette idéale sont : +2, +1, 0, +3, +1, +2, 0, +1, +2, +1. a) Calculez le pourcentage de jeunes filles qui souhaitent être plus minces et l'écart moyen. b) Une élève (écart +3) dit qu'elle saute le dîner depuis deux mois. Que faites-vous ? c) Proposez un thème d'atelier adapté au groupe.

Corrigé

a) Écarts positifs : 8 sur 10, soit **80 %**. Écart moyen : (2 + 1 + 0 + 3 + 1 + 2 + 0 + 1 + 2 + 1) / 10 = 13 / 10 = **+1,3**. **b)** Écouter sans juger, ne pas commenter son poids, lui dire que l'on s'inquiète pour elle et l'**orienter** vers l'infirmière scolaire ou le médecin, en respectant la confidentialité ; prévenir l'infirmière selon les règles de l'établissement. **c)** Un atelier sur les images retouchées et les réseaux sociaux (pensée critique), suivi d'un atelier « petit-déjeuner et énergie » centré sur le plaisir et la performance scolaire, sans aucune référence au poids.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 3.3.5 et 3.3.6 – Compétences psychosociales, image du corps, estime de soi

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez les trois catégories de CPS du référentiel de Santé publique France (2022) et le nombre de CPS générales.
2. Que signifie l'acronyme SAFE ?
3. Comment calcule-t-on l'insatisfaction corporelle avec l'échelle de Stunkard ?
4. Quelle est l'étendue du score de l'échelle de Rosenberg ? Comment traite-t-on les items négatifs ?
5. Combien de réponses positives au SCOFF-F font suspecter un TCA ? Que fait-on ensuite ?
6. Citez deux règles pour « prévenir sans nuire » en atelier.

Corrigé – Point d'étape 3.3.5 et 3.3.6

1. Cognitives, émotionnelles, sociales ; 9 CPS générales (3 par catégorie).
2. Séquencé, actif, centré, explicite (*Sequenced*, *Active*, *Focused*, *Explicit*) : critères des programmes efficaces (Durlak, 2011).
3. Silhouette perçue moins silhouette idéale : un écart positif traduit un désir de minceur, un écart négatif un désir d'être plus fort.
4. De 10 à 40 ; les items négatifs sont inversés (5 − réponse) avant l'addition.
5. Deux ou plus ; on oriente vers le médecin ou une structure spécialisée, sans poser de diagnostic.
6. Ne jamais peser ni commenter le corps en public ; centrer sur la santé, le plaisir et la convivialité ; ne pas parler d'aliments interdits ; repérer et orienter.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la suite.
3 ou 4 sur 6	Je relis les encadrés « À retenir » et les définitions de la section, puis je refais les questions manquées.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la section et je refais les exercices d'application.

3.3.7 Connaître les publics et comprendre le changement de comportement

Module · Référentiel : C3.1, C3.2, C3.5 · Guide 2025 : p. 61 · CNED : Synthèse M5 S2 §3 (p. 38 et 39)

Les spécificités des publics

Public	Caractéristiques	Adaptations de l'action
Jeunes enfants (2-6 ans)	Néophobie alimentaire maximale ; apprentissage par l'imitation et l'exposition répétée ; pensée concrète	Jeux sensoriels, manipulations, expositions répétées sans forcer, implication des parents
Enfants (6-11 ans)	Curiosité, goût du défi, influence de l'école et des pairs, sensibilité à la publicité	Ateliers pratiques, quiz, défis, classes du goût, projets de classe
Adolescents	Construction de l'identité, influence des pairs et des réseaux, autonomie, préoccupations corporelles	Pairs ambassadeurs, débats, réseaux sociaux, respect de l'autonomie, prévention de la stigmatisation
Adultes	Contraintes (temps, budget, travail), habitudes installées, rôle de « nourricier » pour la famille	Solutions concrètes et rapides, partage d'expériences, valorisation des savoir-faire
Personnes âgées	Baisse de l'appétit et du goût, isolement, troubles de la mastication, habitudes anciennes, peur de la maladie	Convivialité, repas partagés, textures adaptées, réminiscence, rythme lent, gros caractères
Personnes en précarité	Contraintes budgétaires, stress, parfois honte, défiance envers les institutions	Gratuité, non-jugement, valorisation des compétences, recettes à petit prix
Personnes allophones ou migrantes	Langue, codes culturels, produits inconnus, parcours parfois traumatique	Interprétariat, supports visuels, recettes du pays, posture interculturelle
Personnes en situation de handicap	Besoins variables (moteurs, sensoriels, cognitifs, psychiques)	FALC, matériel adapté, pictogrammes, rythme individualisé, accessibilité des locaux

Les modèles du changement de comportement

Définition – Modèle des croyances relatives à la santé (Health Belief Model, Rosenstock, Becker, années 1950-1970)

Une personne adopte un comportement de santé si elle se perçoit **vulnérable** au problème, si elle le juge **grave**, si elle perçoit des **bénéfices** supérieurs aux **obstacles**, en présence d'un **déclencheur** (incitation à l'action) et avec un sentiment d'**efficacité personnelle**.

Composante du modèle des croyances relatives à la santé	Question que se pose la personne	Exemple : dépistage du diabète chez des adultes de 50 ans	Levier pour l'action
Vulnérabilité perçue	« Est-ce que cela peut m'arriver ? »	« Le diabète, c'est pour les gros, pas pour moi. »	Présenter les facteurs de risque concrets (âge, antécédents familiaux, sédentarité)
Gravité perçue	« Est-ce grave si cela m'arrive ? »	« Un peu de sucre dans le sang, ce n'est rien. »	Témoignage d'un pair sur les complications évitées grâce à un repérage précoce
Bénéfices perçus	« Qu'est-ce que j'y gagne ? »	« Savoir tôt permet d'agir par l'alimentation. »	Montrer ce qui change concrètement après un dépistage
Obstacles perçus	« Qu'est-ce que cela me coûte ? »	Peur de la piqûre, temps, déplacement	Test capillaire gratuit sur le marché, sans rendez-vous
Incitation à l'action	« Qu'est-ce qui me décide maintenant ? »	Courrier, conseil du médecin, stand en pharmacie	Rappel par SMS, présence d'un stand lors d'un événement
Efficacité personnelle (ajoutée en 1988)	« Suis-je capable de le faire ? »	« Je ne saurai pas changer mon alimentation. »	Atelier culinaire, petits objectifs réalisables

Attention – Les limites du modèle

Le modèle des croyances relatives à la santé décrit une personne **rationnelle** qui pèse le pour et le contre. Il prédit mal les comportements **habituels** et automatiques (grignoter, boire un soda), et il donne peu de place aux **normes sociales** et aux émotions. Il est surtout utile pour des comportements ponctuels et délibérés : se faire dépister, se faire vacciner, consulter.

À vous de jouer – Exercice d'application 3.14

Un centre de santé constate que peu de femmes enceintes du quartier participent à l'atelier gratuit « bien manger pendant la grossesse ». Voici ce qu'elles disent : « J'ai déjà eu deux enfants, je sais faire » ; « Le diabète de grossesse, ma cousine l'a eu, ce n'était pas grave » ; « L'atelier est à 9 h, je dépose les enfants à l'école » ; « Si la sage-femme me le conseillait, j'irais ». a) Associez chaque phrase à une composante du modèle. b) Proposez une action pour chacune.

Corrigé

a) « Je sais faire » : **vulnérabilité perçue** faible (« cela ne me concerne pas ») et confiance élevée ; « ce n'était pas grave » : **gravité perçue** faible ; « l'atelier est à 9 h » : **obstacle perçu** ; « si la sage-femme me le conseillait » : **incitation à l'action**. **b)** Valoriser l'expérience des mères (elles peuvent témoigner et aider les autres) tout en présentant ce qui est nouveau à chaque grossesse ; inviter une mère ou une sage-femme à expliquer simplement les conséquences du diabète gestationnel pour la mère et le bébé, sans dramatiser ; déplacer l'atelier à 10 h ou proposer une garde d'enfants ; demander aux sages-femmes de remettre une invitation personnalisée en consultation.

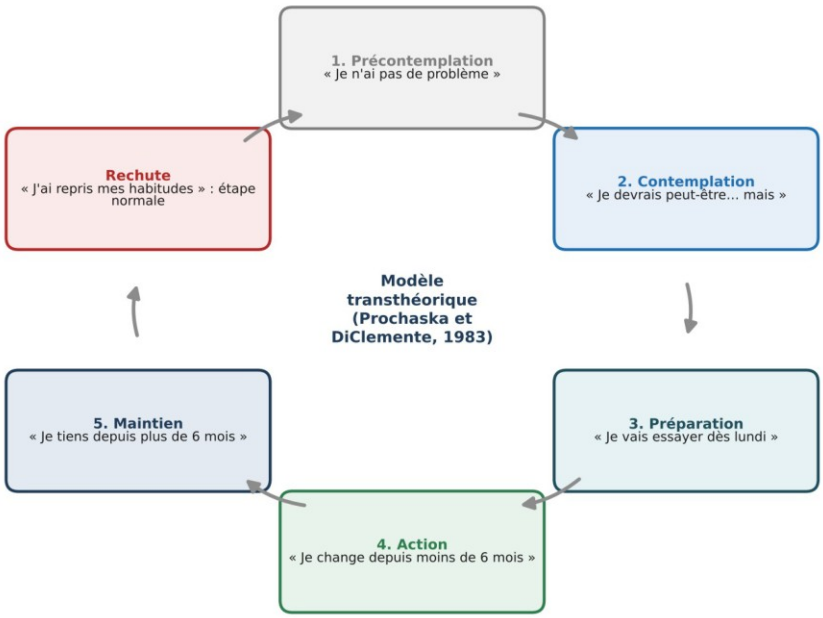


Figure 3.4 – Les étapes du changement selon Prochaska et DiClemente (1983)

Comprendre le schéma – Figure 3.4

1. Précontemplation : la personne n'envisage pas de changer (« je n'ai pas de problème ») ; objectif : informer sans braquer, susciter la réflexion.

2. Contemplation : elle envisage le changement mais reste ambivalente (« je devrais, mais… ») ; objectif : explorer les avantages et les inconvénients (balance décisionnelle).

3. Préparation : elle prévoit d'agir à court terme ; objectif : aider à fixer un objectif concret et réaliste.

4. Action : elle a changé depuis moins de 6 mois ; objectif : soutenir, valoriser, aider à surmonter les obstacles.

5. Maintien : le changement dure depuis plus de 6 mois ; objectif : prévenir la rechute.

6. Rechute : retour aux anciennes habitudes, considéré comme une étape **normale** du processus, qui permet d'apprendre ; on repart dans le cycle.

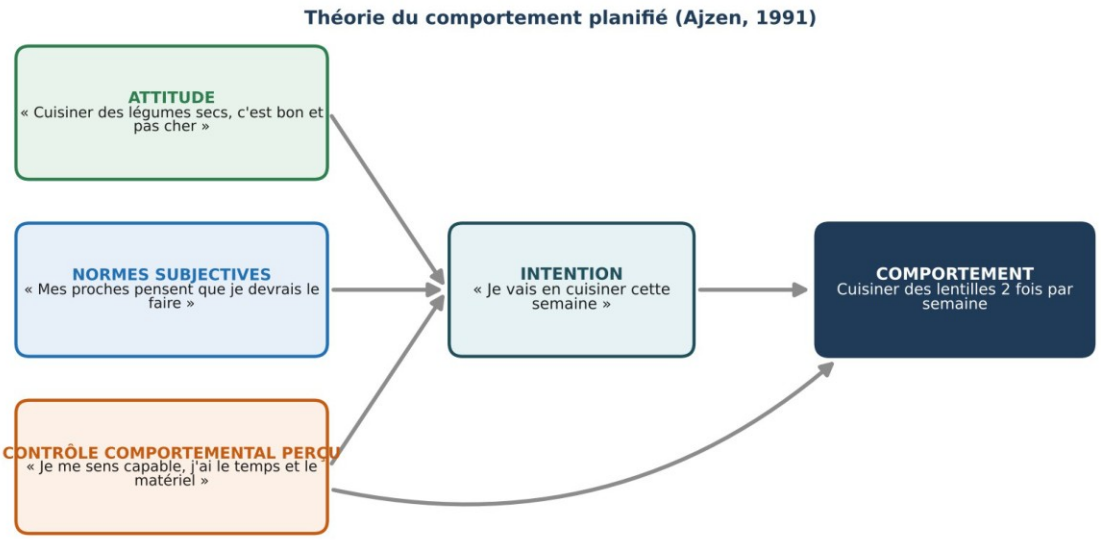


Figure 3.5 – La théorie du comportement planifié (Ajzen, 1991), appliquée aux légumes secs

Comprendre le schéma – Figure 3.5

1. L'**attitude** : ce que la personne pense du comportement (positif ou négatif).
2. Les **normes subjectives** : ce qu'elle pense que ses proches attendent d'elle.
3. Le **contrôle comportemental perçu** : sa capacité perçue à réaliser le comportement (temps, argent, compétences).
4. Ces trois éléments déterminent l'**intention**, qui précède le **comportement**.
5. Le contrôle perçu agit aussi **directement** sur le comportement (flèche courbe) : même avec une bonne intention, sans compétences ni moyens, le comportement n'a pas lieu. D'où l'intérêt de faire **cuisiner** en atelier.

Définition – Sentiment d'efficacité personnelle (Albert Bandura, 1977)

Croyance d'une personne en sa capacité à réaliser une action précise. Il se développe par quatre sources : les **expériences de réussite** personnelles (la plus puissante), l'**observation** de pairs qui réussissent (apprentissage vicariant), la **persuasion** verbale (encouragements), et l'état **physiologique et émotionnel** (se sentir détendu).

Lien diététique – L'entretien motivationnel (lien BC1)

Développé par William Miller et Stephen Rollnick (1983, 2013), l'entretien motivationnel est une méthode de communication centrée sur la personne qui vise à **renforcer sa motivation propre** au changement en explorant son **ambivalence**. Ses outils (questions ouvertes, valorisation, reflets, résumés) sont utiles aussi en animation de groupe. Il est approfondi dans le BC1.

À vous de jouer – Exercice d'application 3.15

Identifiez l'étape du changement et proposez une réponse adaptée : a) « Les légumes, chez nous, personne n'aime, et on n'a jamais été malades. » b) « J'aimerais bien cuisiner plus, mais je n'ai jamais le temps. » c) « Depuis l'atelier, je fais des lentilles tous les lundis, ça fait deux mois. » d) « J'avais arrêté les sodas, mais avec les vacances j'ai repris. »

Corrigé

a) Précontemplation : ne pas argumenter de front ; poser une question ouverte (« qu'est-ce que vous aimez cuisiner ? »), proposer de goûter sans engagement. **b) Contemplation** : explorer l'ambivalence (« qu'est-ce qui vous donnerait envie ? qu'est-ce qui bloque ? ») ; proposer des recettes en 15 minutes. **c) Action** (moins de 6 mois) : valoriser, féliciter, aider à varier pour maintenir la motivation. **d) Rechute** : la dédramatiser (étape normale), analyser la situation déclenchante, aider à reprendre un objectif réaliste.

Intégration, pauvreté, exclusion : le vocabulaire de la sociologie

Notion	Définition simple	Auteur repère
Intégration	Façon dont les personnes sont reliées entre elles et à la société	Durkheim (*De la division du travail social*, 1893)
Lien social	Ensemble des liens familiaux, sociaux, culturels et économiques qui assurent la cohésion de la société ; il découle de la socialisation	Durkheim ; Serge Paugam
Exclusion sociale	Cumul de difficultés (chômage durable, rupture familiale, perte du logement) qui éloigne la personne de la vie sociale	René Lenoir (*Les Exclus*, 1974)
Disqualification sociale	Affaiblissement puis rupture des liens, avec perte de protection et de reconnaissance ; trois phases : fragilité, dépendance aux aides, rupture	Serge Paugam (1991)
Désaffiliation	Suite de décrochages (travail, famille, entourage) ; trois zones : intégration, vulnérabilité, désaffiliation	Robert Castel (1995)
Classes sociales	Groupes définis par leur place dans la production ; conscience de classe et conflit	Karl Marx
Stratification	Hiérarchie de positions (richesse, prestige, pouvoir) sans frontière nette entre les strates	Max Weber
Capitaux	Capital **économique** (revenus, patrimoine), **culturel** (diplômes, savoirs), **social** (relations), qui expliquent les goûts et les pratiques	Pierre Bourdieu (1979)

Définition – Pauvreté monétaire (Insee)

Une personne est **pauvre** au sens monétaire quand son **niveau de vie** est inférieur à **60 % du niveau de vie médian**. C'est une pauvreté **relative** : elle mesure l'écart avec le reste de la population, et non l'impossibilité de survivre. Le niveau de vie est le revenu disponible du ménage divisé par le nombre d'**unités de consommation** (UC) : 1 UC pour le premier adulte, 0,5 pour chaque autre personne de 14 ans ou plus, 0,3 pour chaque enfant de moins de 14 ans.

À retenir – Les chiffres en vigueur (Insee, publication du 9 juillet 2026)

En **2024**, le seuil de pauvreté à 60 % est de **1 337 € par mois** pour une personne seule. Le taux de pauvreté atteint **15,4 %** de la population (France métropolitaine), soit **9,8 millions** de personnes.

À vous de jouer – Exercice d'application 3.16

Un couple avec deux enfants de 6 et 10 ans dispose d'un revenu disponible de 2 600 € par mois. a) Calculez le nombre d'UC et le niveau de vie mensuel. b) Ce ménage est-il sous le seuil de pauvreté de 2024 ? c) Quel revenu lui faudrait-il pour atteindre ce seuil ?

Corrigé

a) UC = 1 + 0,5 + 0,3 + 0,3 = **2,1** ; niveau de vie = 2 600 / 2,1 = **1 238 €** par mois. b) Oui : 1 238 € < 1 337 €. c) 1 337 × 2,1 = **2 808 €** par mois (2 807,70 €), soit 208 € de plus. Pour l'atelier, cela oriente vers des menus à petit budget, l'aide alimentaire et l'épicerie solidaire, sans stigmatiser la famille.

Entre l'intention et le comportement : un écart

Les modèles d'Ajzen et de Prochaska accordent une place centrale à l'**intention**. Or vouloir ne suffit pas. Une synthèse de méta-analyses (Sheeran, 2002) estime que l'intention n'explique qu'environ **28 %** des différences de comportement entre les personnes. Une autre méta-analyse d'études expérimentales (Webb et Sheeran, 2006) montre qu'un changement important de l'intention ne produit qu'un changement **petit à moyen** du comportement. C'est l'**écart intention-comportement** : beaucoup de personnes qui veulent manger plus de légumes n'y arrivent pas.

Cause de l'écart	Exemple	Ce qui aide
Oublier d'agir au bon moment	« J'avais prévu de prendre des fruits, mais j'ai oublié en faisant les courses. »	Une liste de courses, un rappel, une intention de mise en œuvre
Ne pas savoir par où commencer	« Je veux cuisiner plus, mais quoi ? »	Un objectif précis et une recette simple
Se laisser détourner par une tentation	Le distributeur de la salle de pause	Modifier l'environnement, prévoir une collation
Retomber dans une habitude	Le soda pris automatiquement en rentrant	Remplacer l'habitude par une autre, déclenchée par le même signal

Définition – Les intentions de mise en œuvre (Gollwitzer, 1999)

Une **intention de mise en œuvre** est un plan de la forme **« Si (situation), alors (action) »** : « Si je fais les courses le samedi, alors je prends un sachet de lentilles corail » ; « Si j'ai envie de grignoter devant la télévision, alors je me sers un verre d'eau et une pomme ». Elle relie un signal précis à une action, ce qui rend l'action plus automatique. Une méta-analyse de 94 études (Gollwitzer et Sheeran, 2006) a montré un effet **moyen à fort** de cette technique sur l'atteinte des objectifs.

Définition – Habitude

Une **habitude** est un comportement déclenché **automatiquement** par un signal du contexte (un lieu, une heure, une personne, une émotion), sans réflexion, parce qu'il a été répété souvent dans ce contexte. Une grande partie de l'alimentation quotidienne est faite d'habitudes : elles relèvent de la **motivation automatique** du modèle COM-B (section 3.3.13).

Exemple – Combien de temps faut-il pour créer une habitude ? (Lally et collaborateurs, 2010)

Quatre-vingt-seize volontaires londoniens ont choisi un nouveau comportement de santé à réaliser chaque jour dans le même contexte (par exemple manger un fruit au déjeuner). Ils ont noté chaque jour à quel point l'action leur paraissait automatique. Le temps pour atteindre 95 % du plateau d'automaticité était de **66 jours**

en valeur médiane, avec une très grande variation selon les personnes et les comportements (de **18 à 254 jours**). Oublier une journée n'empêchait pas l'habitude de se former.

Leçons : l'idée répandue qu'« il faut 21 jours pour créer une habitude » n'a pas de base solide ; il faut plutôt compter **plusieurs semaines à plusieurs mois** ; un écart ponctuel n'est pas un échec. Un cycle d'ateliers doit donc prévoir un suivi après la dernière séance.

Méthode pas à pas – Aider un groupe à passer de l'intention à l'action

1. Faire choisir à chacun **un seul** objectif précis et réaliste (« deux fois par semaine, un plat avec des légumes secs »).
2. Faire écrire une intention de mise en œuvre : « Si..., alors... ».
3. Repérer à l'avance un **obstacle** probable et sa solution (« Si je rentre trop tard, alors je réchauffe les lentilles cuisinées la veille »).
4. Attacher le nouveau comportement à une habitude existante (après le café du matin, au retour des courses).
5. Prévoir un **suivi** : retour à la séance suivante, message de rappel, carnet de suivi.
6. Dédramatiser les écarts : l'habitude se construit sur la répétition, pas sur la perfection.

À vous de jouer – Exercice d'application 3.17

À la fin d'un atelier, M. K., chauffeur routier, déclare : « Il faut vraiment que je mange mieux. » Il prend souvent un sandwich et un soda à la station-service. a) Pourquoi cette intention risque-t-elle de ne pas se traduire en comportement ? b) Aidez-le à formuler deux intentions de mise en œuvre. c) Combien de temps faut-il prévoir avant que le nouveau comportement devienne automatique ?

Corrigé

a) L'intention est **vague** (que signifie « mieux » ?), aucun moment ni action précise n'est prévu, et le comportement actuel est une **habitude** déclenchée par un contexte fort (la pause à la station). **b)** « Si je m'arrête à la station-service, alors je prends une bouteille d'eau à la place du soda » ; « Si je pars le matin, alors je mets dans ma glacière une boîte de taboulé préparée la veille et un fruit ». **c)** Plusieurs semaines à plusieurs mois : 66 jours en valeur médiane dans l'étude de Lally (2010), avec de fortes différences d'une personne à l'autre. Un oubli ponctuel n'est pas grave.

Renforcer le sentiment d'efficacité personnelle en atelier

Le sentiment d'efficacité personnelle (Bandura, 1977) est l'une des variables les plus liées au changement durable. Il ne se décrète pas : il se construit à partir de ses **quatre sources**.

Source (de la plus forte à la plus faible)	Mécanisme	Application concrète en atelier culinaire
Expériences de réussite	« Je l'ai fait, donc je peux le refaire. »	Chaque participant réalise lui-même une étape ; recette simple au début, difficulté progressive ; on repart avec son plat
Expériences vicariantes (observation)	« Quelqu'un comme moi y arrive, donc moi aussi. »	Démonstration par un pair plutôt que par un chef ; témoignage d'un participant des cycles précédents
Persuasion verbale	« On me dit que j'en suis capable. »	Encouragements précis et sincères (« votre découpe est régulière ») plutôt que des compliments vagues

Source (de la plus forte à la plus faible)	Mécanisme	Application concrète en atelier culinaire
États physiologiques et émotionnels	« Je me sens détendu, donc capable. »	Accueil chaleureux, pas de chronomètre, droit à l'erreur, ambiance détendue

Définition – Mesurer l'efficacité personnelle

Le sentiment d'efficacité personnelle se mesure soit de façon **spécifique** à un comportement (« Je me sens capable de cuisiner un plat de légumes secs en moins de 30 minutes », de 1 à 5), ce qui est le plus pertinent pour évaluer un atelier, soit de façon **générale**. L'échelle d'auto-efficacité générale de Schwarzer et Jerusalem (1995), traduite en français, comporte **10 items** notés de 1 (« pas du tout vrai ») à 4 (« totalement vrai ») ; le score va de **10 à 40**.

Calcul détaillé – Le score de Mme A. à l'échelle générale

Réponses aux 10 items : 2, 3, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 2.

- Score total : 2 + 3 + 2 + 2 + 3 + 1 + 2 + 3 + 2 + 2 = **22 sur 40**.
- Position sur l'étendue : (22 − 10) / (40 − 10) × 100 = 12 / 30 × 100 = **40 / 100**.

Lecture : sentiment d'efficacité générale plutôt bas. Pour évaluer l'effet d'un atelier, on préfère une question **spécifique** au comportement travaillé, posée avant et après, car l'efficacité générale évolue lentement.

À vous de jouer – Exercice d'application 3.18

M. D., 68 ans, veuf depuis un an, dit : « C'est ma femme qui faisait la cuisine, moi je ne sais rien faire, je mange des plats tout prêts. » a) Quelle variable psychosociale est en jeu ? b) Proposez une action pour chacune des quatre sources. c) Rédigez une question pour mesurer l'effet de l'atelier sur cette variable.

Corrigé

a) Un faible **sentiment d'efficacité personnelle** pour cuisiner (« je ne sais rien faire »), dans un contexte de deuil et de rupture des rôles. **b) Réussite** : lui faire préparer seul une omelette aux légumes, puis une soupe, en augmentant progressivement la difficulté. **Observation** : le faire cuisiner aux côtés d'un autre homme âgé qui a appris récemment. **Persuasion** : encouragements précis (« vos légumes sont bien coupés, la cuisson est parfaite »). **État émotionnel** : petit groupe, ambiance conviviale, aucune pression de temps ; prendre en compte le deuil (écoute, orientation si besoin). **c)** « Je me sens capable de préparer un repas simple et complet pour moi le soir », de 1 (« pas du tout ») à 5 (« tout à fait »), posée au premier et au dernier atelier.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 3.3.7 – Connaître les publics et comprendre le changement

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez les composantes du modèle des croyances relatives à la santé.
2. Pour quel type de comportement ce modèle est-il le plus utile ? Pourquoi ?
3. Nommez les six étapes de Prochaska et DiClemente et donnez la durée qui sépare action et maintien.
4. Quels sont les trois déterminants de l'intention selon Ajzen ? Lequel agit aussi directement sur le comportement ?
5. Qu'est-ce qu'une intention de mise en œuvre ? Donnez un exemple.
6. Combien de temps faut-il pour qu'une habitude devienne automatique selon Lally (2010) ?

Corrigé – Point d'étape 3.3.7

1. Vulnérabilité perçue, gravité perçue, bénéfices perçus, obstacles perçus, incitation à l'action, efficacité personnelle.
2. Les comportements ponctuels et délibérés (dépistage, vaccination), car il décrit une décision rationnelle et prend peu en compte les habitudes et les normes.
3. Précontemplation, contemplation, préparation, action, maintien, rechute ; 6 mois.
4. L'attitude, la norme subjective et le contrôle comportemental perçu ; c'est le contrôle perçu qui agit aussi directement.
5. Un plan « si (situation), alors (action) » : « Si je fais les courses le samedi, alors je prends des lentilles » (Gollwitzer, 1999).
6. 66 jours en valeur médiane, avec une grande variation (de 18 à 254 jours).

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la suite.
3 ou 4 sur 6	Je relis les encadrés « À retenir » et les définitions de la section, puis je refais les questions manquées.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la section et je refais les exercices d'application.

3.3.8 Communiquer et écouter : les bases de la relation éducative

Module · Référentiel : C3.1, C3.2, C3.5 · CNED : Synthèse M5 S2 §2 (p. 36 à 38)

La communication interpersonnelle

Communiquer, ce n'est pas seulement transmettre une information : c'est établir une **relation**. L'école de **Palo Alto** (Watzlawick, Beavin et Jackson, *Une logique de la communication*, 1967) a formulé plusieurs principes devenus classiques, dont deux sont essentiels en éducation pour la santé : « **on ne peut pas ne pas communiquer** » (un silence, un regard, une posture disent quelque chose) et « toute communication comporte un **contenu** et une **relation** » (la même phrase peut être reçue comme un conseil ou comme un jugement selon le ton et la relation).

Composante	Exemples en atelier
Verbale	Choix des mots (« légumes secs » plutôt que « légumineuses »), clarté, phrases courtes (chapitre 5)
Paraverbale	Ton, débit, volume, silences ; un ton enjoué et posé rassure
Non verbale	Regard, sourire, posture ouverte, gestes, distance ; se placer à hauteur des personnes assises ; éviter les bras croisés
Contexte	Lieu, disposition de la salle (cercle plutôt que rangées), horaires, présence d'enfants

Attention – La « règle des 7 %, 38 %, 55 % » : un mythe

On lit souvent que 93 % de la communication serait non verbale. Ces chiffres viennent d'expériences d'Albert Mehrabian (1967) portant sur des mots isolés exprimant des **sentiments**, quand le ton et le visage contredisaient le mot ; ils ne s'appliquent pas à la communication en général. Retenez seulement que le non-verbal **renforce ou contredit** le message verbal, et qu'en cas de contradiction, c'est souvent lui que l'on croit.

L'écoute active

Définition – Écoute active (Carl Rogers)

Attitude d'écoute centrée sur la personne, fondée sur trois conditions décrites par le psychologue Carl **Rogers**

(années 1950-1960) : l'**empathie** (comprendre le point de vue de l'autre de l'intérieur, sans le partager forcément), l'**acceptation inconditionnelle** (accueillir la personne sans la juger) et la **congruence** (être authentique, en accord entre ce que l'on ressent et ce que l'on exprime). Elle s'appuie sur des techniques : questions ouvertes, reformulation, silences, synthèse.

Technique	Définition	Exemple
Question ouverte	Question qui ne se répond pas par oui ou non	« Comment se passent les repas à la maison ? »
Reformulation simple	Redire avec d'autres mots ce que la personne a dit	« Si je comprends bien, le soir vous manquez de temps. »
Reformulation reflet	Exprimer le sentiment perçu	« Ça a l'air de vous inquiéter que votre fils ne mange pas de légumes. »
Silence	Laisser un temps après une question ou une confidence	(attendre 3 à 5 secondes)
Valorisation	Reconnaître un effort, une compétence	« Vous avez déjà trouvé une astuce avec la soupe, c'est intéressant. »
Synthèse	Résumer les points importants	« Nous avons parlé du budget, du temps et des goûts des enfants. »

Attention – Les attitudes spontanées qui bloquent l'échange (Porter, 1950)

Le psychologue Elias Porter a décrit six attitudes : **évaluation** (juger : « Ce n'est pas bien de donner des sodas »), **interprétation** (« Vous dites ça parce que vous êtes fatiguée »), **soutien** (consoler, minimiser : « Ce n'est pas grave »), **enquête** (questions en rafale), **solution** (donner tout de suite un conseil) et **compréhension** (reformuler). Seule la **compréhension** favorise l'expression ; les autres sont parfois utiles, mais, utilisées d'emblée, elles ferment le dialogue. Le diététicien a souvent le réflexe de la « solution » : il gagne à écouter et reformuler d'abord.

À vous de jouer – Exercice d'application 3.19

Une mère dit en atelier : « De toute façon, mes enfants ne mangent que des pâtes, j'ai tout essayé. » Proposez une réponse pour chaque attitude de Porter et indiquez laquelle choisir.

Corrigé

Évaluation : « Il faut quand même varier. » Interprétation : « Vous avez peut-être abandonné trop vite. » Soutien : « Ne vous inquiétez pas, c'est normal. » Enquête : « Depuis quand ? Quels légumes ? Combien de fois ? » Solution : « Mettez des légumes dans les pâtes. » **Compréhension** : « Vous avez l'impression d'avoir tout essayé et c'est décourageant. » C'est la compréhension qu'on choisit d'abord ; une fois que la personne se sent entendue, on peut explorer (« Qu'est-ce qui a marché, même un peu ? ») puis proposer des pistes avec elle.

Le schéma de la communication et ses obstacles

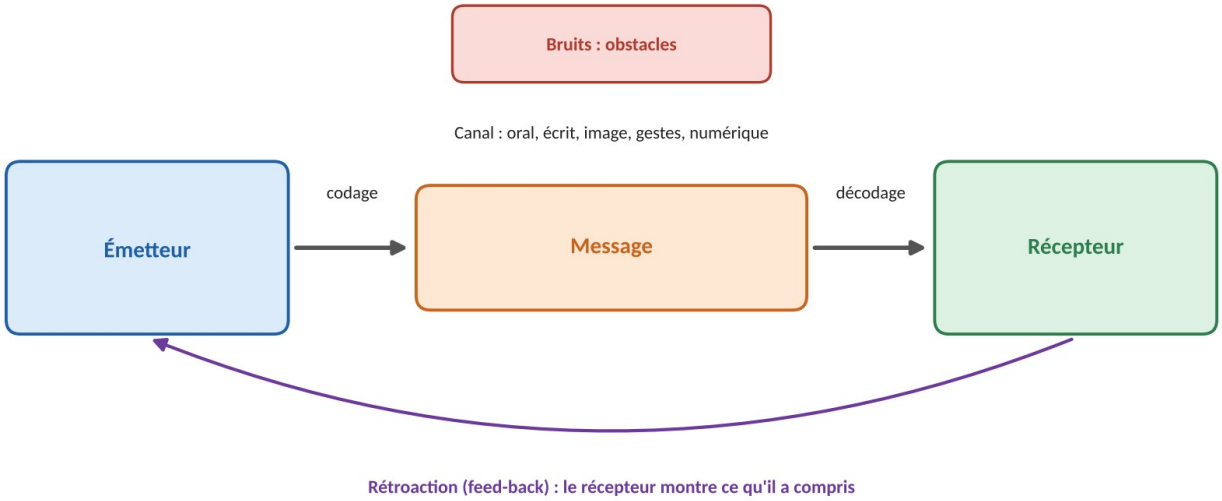


Figure 3.5 bis – Le schéma de la communication interpersonnelle

Comprendre le schéma – Figure 3.5 bis

1. L'**émetteur** a une idée qu'il **code** en mots, en images ou en gestes ; ce code forme le **message**.
2. Le message passe par un **canal** : la voix, un écrit, une image, un geste, un écran.
3. Le **récepteur décode** le message avec ses propres connaissances, sa langue, sa culture et ses émotions : ce qu'il comprend n'est jamais exactement ce que l'émetteur voulait dire.
4. Des **bruits** gênent la transmission à chaque étape.
5. La **rétroaction** (le *feed-back*) permet de vérifier ce qui a été compris et de corriger. Ce schéma vient du modèle technique de Shannon et Weaver (1949), complété par les apports de la psychologie : sans rétroaction, on informe, on ne communique pas.

Type de bruit	Exemples en atelier ou en consultation collective	Comment le réduire
Physique	Bruit de la hotte, salle mal éclairée, masque qui cache la bouche	Couper les appareils pendant les consignes, se placer face au groupe, parler plus lentement
Linguistique	Mots techniques (« glucides complexes », « densité énergétique »), langue étrangère	Mots simples, images, aliments réels, interprète professionnel (chapitre 5)
Culturel	Le geste « pouce levé » ou le contact visuel n'ont pas le même sens partout ; « léger » ne veut pas dire la même chose pour tous	Demander, observer, ne pas supposer
Psychologique	Fatigue, inquiétude pour un enfant, sentiment d'être jugé, préjugés envers le professionnel	Accueil chaleureux, non-jugement, pause
Sensoriel ou cognitif	Baisse d'audition, de vision, troubles de la mémoire	Gros caractères, supports visuels, répétition, phrases courtes

Vérifier la compréhension : la méthode « dites-le-moi avec vos mots »

Définition – Teach-back (« dites-le-moi avec vos mots »)

Méthode qui consiste à demander à la personne de **réexpliquer avec ses propres mots** ce qu'elle a compris, puis à reformuler et compléter si besoin. Elle est recommandée pour les personnes ayant une faible littératie en santé (chapitre 5), mais elle est utile avec tous les publics. La responsabilité de la compréhension est

portée par le professionnel : on ne demande pas « Avez-vous compris ? » (presque tout le monde répond oui), mais « Pour être sûr d'avoir été clair, pouvez-vous me dire comment vous allez préparer les lentilles ce soir ? ».

Méthode pas à pas – Utiliser le teach-back en groupe

1. Donner **deux ou trois messages** au maximum, avec un support concret (l'aliment, l'emballage, une photo).
2. Demander à un volontaire, ou à un binôme, de réexpliquer à un autre participant : « Comment expliqueriez-vous à votre voisine de palier comment faire tremper les pois chiches ? »
3. Écouter sans corriger tout de suite ; repérer ce qui manque ou ce qui est faux.
4. Réexpliquer autrement le point mal compris (autre mot, autre image, démonstration).
5. Vérifier de nouveau.
6. Remercier : la personne a aidé le groupe, et vous a aidé à mieux expliquer.

À vous de jouer – Exercice d'application 3.20

Dans un atelier en EHPAD, une diététicienne présente l'enrichissement des purées pendant que l'aide-cuisinière utilise un mixeur. À la fin, elle demande « Tout le monde a compris ? » et plusieurs résidents hochent la tête. Le lendemain, aucun n'a demandé de fromage râpé sur sa purée. a) Repérez trois bruits dans cette situation. b) Pourquoi la question finale ne permettait-elle pas de vérifier la compréhension ? c) Réécrivez la fin de l'atelier.

Corrigé

a) Bruit **physique** (le mixeur couvre la voix) ; bruit **sensoriel** probable (baisse d'audition fréquente chez les résidents) ; bruit **linguistique** possible (« enrichissement » est un mot technique) ; on peut aussi penser à un bruit **psychologique** (gêne de demander un supplément). **b)** C'est une question fermée qui appelle un « oui » de politesse ; elle ne donne aucune **rétroaction** sur ce qui a été compris. **c)** Couper le mixeur, montrer un bol de purée et le fromage râpé, puis demander : « Imaginons que vous êtes au repas de midi : qu'allez-vous demander au serveur pour votre purée ? » ; reformuler la réponse, répéter le message en une phrase simple et laisser une petite carte illustrée sur la table.

3.3.9 L'esprit de l'entretien motivationnel appliqué au collectif

Module · Référentiel : C3.1, C3.2, C3.5 · CNED : pas de passage correspondant (voir 3.2.2)

L'**entretien motivationnel** (Miller et Rollnick, 1983, puis 2013 pour la 3e édition) est un style de conversation collaboratif qui vise à renforcer la **motivation propre** d'une personne au changement, en explorant et en résolvant son **ambivalence**. Développé pour les addictions, il est très utilisé en nutrition (BC1). Ses principes inspirent aussi l'animation de groupes en santé publique.

Principe	Traduction
Esprit	Partenariat (pas d'expert qui sait tout), acceptation (respect de l'autonomie), compassion (agir pour le bien de la personne), évocation (faire émerger les raisons de la personne plutôt que d'imposer les siennes)
Ambivalence	La personne veut et ne veut pas changer en même temps (« Je voudrais cuisiner plus, mais je n'ai pas le temps ») : c'est normal, on l'explore sans la combattre
Réflexe correcteur	Tendance du professionnel à argumenter pour le changement ; elle provoque souvent la résistance (« Oui, mais… ») : il faut la freiner

Principe	Traduction
Discours-changement	Phrases où la personne exprime son désir, sa capacité, ses raisons, son besoin, puis son engagement à changer ; le professionnel les repère et les renforce

Méthode pas à pas – Les quatre savoir-faire de base (OuVER)

- **Questions Ouvertes** : « Qu'est-ce qui serait le plus facile à changer pour vous ? »
- **Valorisation** : souligner les forces et les efforts.
- **Écoute réflective** (reflets) : reformuler, refléter les sentiments et le discours-changement.
- **Résumés** : rassembler les éléments, en particulier les raisons de changer.

En anglais, l'acronyme est **OARS** (*Open questions*, *Affirmations*, *Reflections*, *Summaries*).

La balance décisionnelle

Exemple – Calcul détaillé : une balance décisionnelle pondérée

Un participant hésite à préparer lui-même ses déjeuners au travail. On lui demande de lister avantages et inconvénients du changement et de noter leur importance de 1 (faible) à 5 (forte).

Élément	Note	Côté
Économiser de l'argent (environ 5 € par jour)	5	Pour
Manger plus de légumes	3	Pour
Mieux digérer l'après-midi	2	Pour
Temps de préparation le soir	4	Contre
Moqueries possibles des collègues	2	Contre
Pas de micro-ondes au travail	3	Contre

- Total « pour » : 5 + 3 + 2 = **10** ; total « contre » : 4 + 2 + 3 = **9**.
- Écart : 10 − 9 = **1** : la balance est presque équilibrée, signe d'**ambivalence** ; ce n'est pas le moment de « pousser », mais d'explorer.
- **Piste** : agir sur les inconvénients modifiables (« contre ») : préparation en 10 minutes en cuisinant le double au dîner (temps : 4 → 2), boîte isotherme et plat froid (micro-ondes : 3 → 0). Nouveau total « contre » : 2 + 2 + 0 = **4** ; écart : 10 − 4 = **6** en faveur du changement.

Leçon : la balance aide la personne à **voir** ses raisons ; le professionnel n'ajoute pas ses propres arguments dans la colonne « pour » et ne juge pas les « contre » : il aide à trouver des solutions pour les réduire.

Attention – Entretien motivationnel et santé publique

En groupe, on ne mène pas un entretien motivationnel individuel, mais on en garde l'**esprit** : laisser les participants exprimer leurs raisons, éviter les leçons, valoriser, proposer des choix (« Lequel de ces trois petits changements vous semble faisable cette semaine ? »). Le diététicien formé à l'entretien motivationnel l'utilise en consultation (BC1).

Les quatre processus de l'entretien motivationnel

Dans la troisième édition de leur ouvrage (2013), Miller et Rollnick décrivent l'entretien motivationnel comme une suite de **quatre processus**. Ils se suivent et s'emboîtent : on ne planifie pas avec quelqu'un avec qui l'on n'a pas créé de relation.

Processus	Question centrale	En séance collective
Engager	Pouvons-nous travailler ensemble ?	Accueil, présentation de chacun, règles du groupe, questions ouvertes sur les habitudes
Focaliser	Sur quoi travaillons-nous ?	Choix avec le groupe d'un thème parmi plusieurs (petit-déjeuner, goûters, courses)
Évoquer	Quelles sont les raisons de la personne de changer ?	Faire exprimer ce que chacun aurait à y gagner ; repérer et renforcer le discours-changement
Planifier	Comment va-t-on s'y prendre ?	Chacun choisit un petit objectif et un plan « si…, alors… » (section 3.3.7)

Repérer le discours-changement

Le **discours-changement** regroupe les phrases où la personne parle en faveur du changement. Miller et Rollnick distinguent le discours **préparatoire** (désir, capacité, raisons, besoin) et le discours de **mobilisation** (engagement, activation, premiers pas). Le **discours-maintien** regroupe les phrases en faveur du statu quo (« De toute façon, chez nous on a toujours mangé comme ça »). Le professionnel ne le combat pas : il le reflète et revient au discours-changement.

Catégorie	Exemple entendu en atelier
Désir	« J'aimerais que mes enfants mangent plus de légumes. »
Capacité	« La soupe, je saurais la faire. »
Raisons	« Ça me ferait faire des économies. »
Besoin	« Il faut que je fasse quelque chose, le médecin m'a parlé de mon cholestérol. »
Engagement	« Je vais faire le gratin de lentilles dimanche. »
Activation	« Je suis prête à essayer. »
Premiers pas	« J'ai déjà acheté des pois chiches cette semaine. »

Donner une information sans réflexe correcteur

Méthode pas à pas – Demander, informer, demander (ou explorer, partager, explorer)

1. **Demander** la permission et ce que la personne sait déjà : « Voulez-vous que je vous donne quelques idées sur les goûters ? Qu'est-ce que vous en savez déjà ? »
2. **Informer** brièvement, de façon neutre, en offrant des choix : « Certains parents mettent un fruit et du pain avec un carré de chocolat ; d'autres préparent un laitage… »
3. **Demander** ce que la personne en pense : « Qu'est-ce qui vous paraît faisable chez vous ? »

On évite ainsi la leçon. La personne garde le contrôle et retient mieux ce qu'elle a choisi.

Évaluer sa pratique : quelques repères chiffrés

L'outil d'évaluation de la qualité de la pratique de l'entretien motivationnel, le **MITI** (*Motivational Interviewing Treatment Integrity*, version 4, Moyers et collaborateurs, 2016), compte les questions et les reflets du professionnel sur un enregistrement. Deux repères sont simples à utiliser pour s'auto-évaluer en formation :

- le **rapport reflets / questions** : au moins **1** reflet par question pour une pratique correcte, **2** pour une bonne pratique ;
- la **part de reflets complexes** (qui ajoutent un sens ou un sentiment) parmi tous les reflets : au moins **40 %** pour une pratique correcte, **50 %** pour une bonne pratique.

Calcul détaillé – L'auto-évaluation de Clara, étudiante en BTS

Clara enregistre (avec l'accord des participants) dix minutes d'un échange collectif. Elle compte : **18 questions** (dont 11 ouvertes), **12 reflets simples** et **8 reflets complexes**.

- Nombre total de reflets : 12 + 8 = **20**.
- Rapport reflets / questions : 20 / 18 = **1,11** : pratique correcte, mais pas encore bonne (objectif 2).
- Part de reflets complexes : 8 / 20 = **40 %** : seuil d'une pratique correcte tout juste atteint.
- Part de questions ouvertes : 11 / 18 = **61,1 %**.

Objectif d'amélioration : poser moins de questions et refléter davantage. Pour atteindre un rapport de 2 avec 18 questions, il faudrait 36 reflets ; plus réaliste : passer à 12 questions et 24 reflets, dont au moins la moitié de reflets complexes.

À vous de jouer – Exercice d'application 3.21

Classez chaque phrase dans une catégorie du discours-changement ou dans le discours-maintien, puis proposez un reflet pour la phrase f. a) « Je pourrais remplacer le soda par de l'eau pétillante. » b) « Je veux pouvoir jouer au foot avec mon fils sans être essoufflé. » c) « J'ai acheté une gourde hier. » d) « Le soda, c'est mon seul plaisir de la journée. » e) « Je vais essayer dès lundi. » f) « Je sais qu'il faudrait, mais avec mon travail de nuit, c'est compliqué. »

Corrigé

a) Capacité. **b)** Raison (ou désir). **c)** Premiers pas. **d)** Discours-maintien. **e)** Engagement. **f)** Ambivalence : besoin (« il faudrait ») et discours-maintien (« c'est compliqué »). Reflet complexe possible : « Vous sentez que ce serait important pour vous, et en même temps vos horaires de nuit rendent les choses difficiles. » Le reflet reprend les deux côtés, en terminant par celui du changement si possible : « Vos horaires compliquent les choses, et pourtant vous sentez que ce serait important pour vous. »

Point d'étape – Je teste mes acquis – 3.3.8 et 3.3.9 – Communiquer, écouter, esprit de l'entretien motivationnel

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez deux principes de l'école de Palo Alto.
2. Pourquoi la « règle des 7 %, 38 %, 55 % » est-elle un mythe ?
3. Quelles sont les trois conditions de l'écoute selon Rogers ?
4. Citez les six attitudes de Porter. Laquelle favorise le plus l'expression ?
5. Nommez les quatre processus de l'entretien motivationnel (2013).
6. Quels sont les deux repères du MITI 4 pour une bonne pratique ?

Corrigé – Point d'étape 3.3.8 et 3.3.9

1. « On ne peut pas ne pas communiquer » ; « toute communication a un contenu et une relation ».
2. Les chiffres de Mehrabian (1967) portent sur des mots isolés exprimant des sentiments, quand le ton et le visage contredisaient le mot.
3. L'empathie, l'acceptation inconditionnelle, la congruence.
4. Évaluation, interprétation, soutien, enquête, solution, compréhension ; c'est la compréhension.
5. Engager, focaliser, évoquer, planifier.
6. Au moins 2 reflets par question et au moins 50 % de reflets complexes.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la suite.
3 ou 4 sur 6	Je relis les encadrés « À retenir » et les définitions de la section, puis je refais les questions manquées.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la section et je refais les exercices d'application.

3.3.10 Animer un groupe : étapes, rôles et styles d'animation

Module · Référentiel : C3.1, C3.2, C3.5 · Guide 2025 : p. 61 · CNED : pas de passage correspondant (voir 3.2.2)

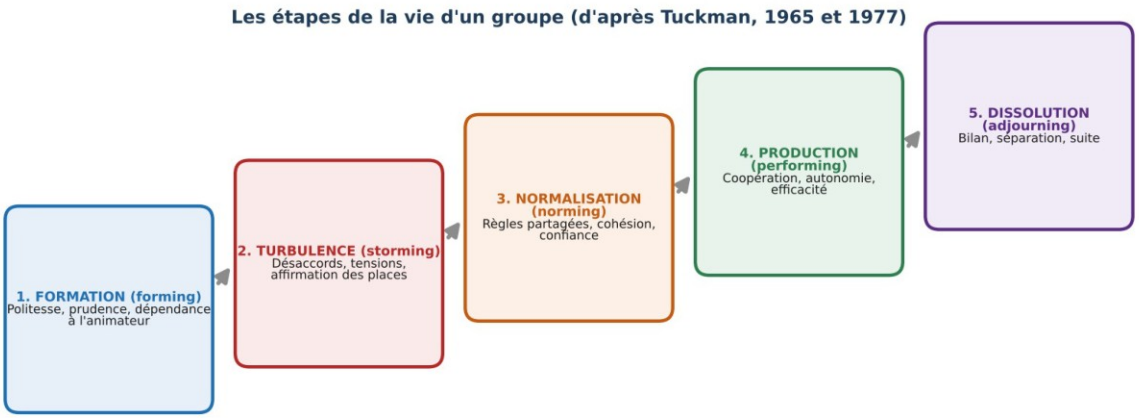


Figure 3.6 – Les étapes de la vie d'un groupe

Comprendre le schéma – Figure 3.6

1. Formation : au début, les participants sont polis et prudents ; ils attendent beaucoup de l'animateur ; c'est le moment de présenter le cadre (règles, confidentialité), de faire se connaître les personnes (brise-glace).

2. Turbulence : des désaccords apparaissent (sur les recettes, les horaires, les façons de faire) ; ils sont **normaux** et signent l'implication ; l'animateur les accueille et aide à les dépasser.

3. Normalisation : le groupe se dote de règles et d'habitudes (« chacun apporte une boîte pour les restes ») ; la cohésion augmente.

4. Production : le groupe coopère, prend des initiatives, l'animateur peut s'effacer (les participants animent une partie de la séance).

5. Dissolution : en fin de cycle, il faut préparer la séparation : bilan, restitution, suite possible (nouveau groupe, autonomie).

6. Dans un cycle de 6 ateliers, ces étapes se succèdent souvent rapidement ; les connaître aide à ne pas s'inquiéter d'une séance tendue (étape 2) et à prévoir la fin (étape 5).

Les rôles dans un groupe

Benne et Sheats (1948) ont distingué trois familles de rôles : les rôles **centrés sur la tâche** (proposer, informer, résumer, organiser), les rôles **centrés sur l'entretien du groupe** (encourager, concilier, faciliter la parole des autres, détendre) et les rôles **individualistes** (monopoliser la parole, bloquer, chercher la reconnaissance, se retirer). L'animateur s'appuie sur les premiers, encourage les seconds et régule les troisièmes.

Situation	Conduite à tenir
Une personne monopolise la parole	Remercier, reformuler brièvement, puis donner la parole aux autres (« J'aimerais entendre ceux qui ne se sont pas encore exprimés ») ; tour de table ; bâton de parole

Situation	Conduite à tenir
Une personne ne parle pas	Ne pas la forcer ; travail en binôme ; supports non verbaux (cartes, gommettes) ; valoriser sa participation pratique
Une personne conteste tout	Accueillir l'objection, la reformuler, la renvoyer au groupe (« Qu'en pensent les autres ? »), s'appuyer sur des données, rappeler l'objectif
Conflit entre deux participants	Rappeler les règles, recentrer sur l'activité, si besoin en parler à part après la séance
Retards répétés	Rappeler les horaires, comprendre les contraintes, adapter l'organisation (accueil café de 15 minutes)
Confidence personnelle difficile	Écouter, remercier, protéger la personne (ne pas laisser le groupe commenter), proposer un échange en privé et une orientation

Les styles d'animation

> **Exemple – L'expérience de Lewin, Lippitt et White (1939)**
>
> Des groupes d'enfants animés selon trois styles ont été comparés. Avec un style **autoritaire** (l'adulte décide de tout), la production était élevée en sa présence, mais l'hostilité et la dépendance aussi, et l'activité s'arrêtait en son absence. Avec un style **démocratique** (décisions discutées, adulte qui guide), la production était bonne, la motivation et la cohésion plus fortes, et le travail continuait sans l'adulte. Avec le style « **laisser-faire** » (adulte passif), la production et la satisfaction étaient les plus faibles. En éducation pour la santé, on privilégie un style **participatif** (démocratique), tout en restant **directif sur le cadre** (sécurité, hygiène, horaires).

Choisir une technique d'animation selon l'objectif

Le style d'animation dit **comment** l'animateur se situe ; la technique dit **ce que** le groupe fait. Le choix dépend de l'objectif de la séquence et de l'étape de vie du groupe. Les techniques sont détaillées au chapitre 14 ; ce tableau en donne la logique psychosociale.

Objectif de la séquence	Technique	Principe	Intérêt psychosocial
Faire connaissance (étape de formation)	Brise-glace, jeu des prénoms, « ce que j'aime manger »	Chacun se présente de façon ludique	Diminue l'anxiété, crée l'appartenance
Recueillir les représentations	Photolangage	Chacun choisit une photo qui évoque pour lui un thème (« bien manger ») et explique son choix	Permet de parler de soi à travers une image, sans être jugé
Produire beaucoup d'idées	Remue-méninges (*brainstorming*, Osborn, 1953)	Toutes les idées sont notées sans critique, puis triées	Limite l'autocensure et l'influence des « experts »
Faire participer un grand groupe	Phillips 6-6	Sous-groupes de 6 personnes, 6 minutes, puis mise en commun	Chacun parle ; on évite la monopolisation
Faire émerger les désaccords	Débat mouvant, abaque de Régnier	Les participants se placent physiquement ou votent par couleur selon leur accord avec une affirmation	Rend visibles les positions ; chacun argumente
Faire décider le groupe	Vote pondéré, consensus	Chacun répartit des gommettes entre plusieurs choix	Engagement collectif (effet Lewin)
S'exercer à une compétence sociale	Jeu de rôle	On joue une situation, puis on en parle	Expérience sans risque, apprentissage par observation

Objectif de la séquence	Technique	Principe	Intérêt psychosocial
Faire le bilan	Cible, « météo », tour de table « un mot »	Chacun s'exprime brièvement sur la séance	Rétroaction, sentiment d'avoir été entendu

Méthode pas à pas – Mener un photolangage

1. Préparer 30 à 50 photos variées (plats, scènes de repas, marchés, publicités), sans texte, en nombre largement supérieur au nombre de participants.
2. Poser une question ouverte : « Choisissez une photo qui représente pour vous "bien manger". »
3. Laisser un temps de choix en silence (5 minutes).
4. Faire un tour de parole : chacun montre sa photo et dit pourquoi il l'a choisie ; les autres écoutent sans commenter.
5. Reformuler et noter les idées qui reviennent (éléments partagés) et celles qui sont isolées.
6. Faire une synthèse avec le groupe, qui servira de point de départ au cycle d'ateliers.

Définition – Le jeu de rôle et le débriefing

Le **jeu de rôle** fait vivre une situation proche de la réalité (dire non à une invitation au fast-food, demander un conseil au boucher). Il comporte trois temps : la **consigne** (situation, rôles, durée), le **jeu** (quelques minutes), le **débriefing**. Le débriefing est la partie la plus importante : on demande d'abord à l'acteur ce qu'il a ressenti, puis aux observateurs ce qu'ils ont vu de positif, puis ce qu'on pourrait essayer autrement. On ne juge jamais la personne, seulement la stratégie utilisée. Un participant qui ne veut pas jouer peut observer.

À vous de jouer – Exercice d'application 3.22

Vous animez la première séance d'un cycle de six ateliers avec 14 adultes d'une association d'insertion. Vos objectifs sont : faire connaissance, recueillir leurs représentations de l'alimentation à petit budget, et choisir avec eux les thèmes des cinq séances suivantes. a) Choisissez une technique pour chaque objectif et justifiez. b) À quelle étape de la vie du groupe êtes-vous ? Quelle attitude adoptez-vous ?

Corrigé

a) Faire connaissance : un **brise-glace** (« mon prénom et un plat qui me rappelle mon enfance ») : rapide, ludique, il crée du lien et valorise l'identité de chacun. Représentations : un **photolangage** sur « manger bien avec peu d'argent » : l'image facilite la parole, sans mise en échec. Choix des thèmes : un **vote par gommettes** parmi 8 thèmes proposés (dont certains issus du photolangage) : la décision collective engage le groupe. **b)** Étape de **formation** : les participants sont prudents et attendent des repères ; l'animateur est plutôt directif sur le cadre (horaires, règles, confidentialité), chaleureux et rassurant, et laisse progressivement la place aux décisions du groupe.

Quatre phénomènes de groupe à connaître

Le travail en groupe n'a pas que des avantages. La psychologie sociale a décrit des phénomènes qui expliquent pourquoi un groupe peut produire moins, ou décider moins bien, que la somme de ses membres.

Phénomène	Ce qui se passe	Origine	Prévention en atelier ou en réunion de projet
Cohésion	Force des liens qui retiennent les membres dans le groupe ; elle favorise la participation et la persévérance	Festinger, Schachter et Back (1950)	Rituels d'accueil, tâches en commun, règles décidées ensemble, repas partagé à la fin

Phénomène	Ce qui se passe	Origine	Prévention en atelier ou en réunion de projet
Paresse sociale	Chacun fournit moins d'effort quand la contribution individuelle n'est pas visible	Ringelmann (fin du XIXe siècle, traction d'une corde) ; Latané, Williams et Harkins (1979)	Donner à chacun un rôle identifiable (éplucher, peser, dresser) ; petits sous-groupes
Pensée de groupe	Un groupe très soudé cherche l'unanimité et écarte les avis contraires, au risque d'une mauvaise décision	Irving Janis (1972)	Demander des avis contraires, désigner un « avocat du diable », consulter des personnes extérieures
Polarisation de groupe	Après discussion, la position du groupe devient plus extrême que la moyenne des positions individuelles	Moscovici et Zavalloni (1969)	Apporter des données, faire voter individuellement avant la discussion

Exemple – La pensée de groupe dans un comité de pilotage

Le comité de pilotage d'un projet de quartier réunit depuis trois ans les mêmes cinq professionnels, très liés. Il décide de reconduire à l'identique les ateliers « équilibre alimentaire », malgré une fréquentation en baisse (de 14 à 5 participants). Personne n'ose dire que les ateliers ne répondent plus aux attentes ; les quelques remarques des habitants sont jugées « marginales ». On retrouve les signes décrits par Janis : **illusion d'unanimité**, **autocensure**, mise à l'écart des informations dérangeantes. **Remède** : présenter les données de fréquentation, inviter deux habitants au comité, faire un tour de table où chacun dit une critique avant la décision.

Définition – Le leadership dans un groupe

Le **leader** est la personne qui influence le plus le groupe à un moment donné. Ce n'est pas forcément l'animateur. On distingue un leadership **orienté vers la tâche** (organiser, décider, faire avancer) et un leadership **orienté vers les relations** (rassurer, encourager, apaiser). Dans un atelier, un participant leader peut être un allié précieux (il goûte en premier, il entraîne les autres) ou un frein (il se moque, il décourage). L'animateur s'appuie sur les leaders positifs, en leur confiant un rôle, et régule les autres sans les mettre en échec devant le groupe.

À vous de jouer – Exercice d'application 3.23

Dans un atelier culinaire de 12 adultes, l'animatrice répartit les participants en deux équipes de 6 pour préparer un couscous de légumes. Elle remarque que, dans chaque équipe, deux personnes font tout pendant que les autres discutent. a) Quel phénomène observe-t-elle ? Citez son origine. b) Proposez deux changements d'organisation. c) Comment la cohésion du groupe peut-elle aussi être renforcée à cette occasion ?

Corrigé

a) La **paresse sociale** : dans un grand sous-groupe, la contribution de chacun est peu visible, donc l'effort individuel baisse (Ringelmann ; Latané, Williams et Harkins, 1979). **b)** Former des **binômes** ou des trinômes avec une tâche précise chacun (légumes, semoule, bouillon, épices, dressage) ; afficher le **plan de travail** avec le prénom de chacun en face de sa tâche. **c)** Terminer par un **repas partagé** où chaque binôme présente sa partie, remercier chacun pour sa contribution, et faire choisir au groupe la recette de la séance suivante.

Gérer un désaccord ou un conflit : deux méthodes

Les désaccords sont normaux dans un groupe (étape de turbulence). Ils deviennent un problème quand ils se transforment en attaques personnelles. Deux méthodes simples aident l'animateur à exprimer une difficulté sans agresser et à aider les participants à le faire.

Méthode pas à pas – La méthode DESC (Bower et Bower, 1976)

D – Décrire les faits, sans jugement : « Depuis le début de la séance, le téléphone a sonné quatre fois. »

E – Exprimer ce que l'on ressent ou les conséquences : « J'ai du mal à garder l'attention du groupe, et les autres n'entendent pas les consignes de sécurité. »

S – Suggérer une solution précise : « Je vous propose de le mettre en silencieux et de sortir si vous devez répondre. »

C – Conclure sur les conséquences positives : « Comme ça, tout le monde pourra profiter de l'atelier, et vous ne manquerez pas d'appel important. »

Définition – La communication non violente (Marshall Rosenberg, 1999)

Démarche de communication en quatre étapes, proche de la méthode DESC : **observation** des faits sans évaluation, expression du **sentiment**, expression du **besoin** à l'origine du sentiment, formulation d'une **demande** concrète, réalisable et négociable. Elle aide à transformer un reproche (« Vous ne respectez rien ») en une demande que l'autre peut entendre (« Quand vous arrivez après le début de la recette [observation], je suis inquiète [sentiment] car j'ai besoin que chacun entende les consignes d'hygiène [besoin]. Pourriez-vous arriver à 14 h la prochaine fois, ou me prévenir ? [demande] »).

Erreur fréquente	Pourquoi elle aggrave le conflit	Formulation alternative
Généraliser (« Vous êtes toujours en retard »)	La personne se défend contre l'étiquette, pas sur les faits	« Vous êtes arrivé après le début les deux dernières fois. »
Parler à la place de l'autre (« Vous vous en fichez »)	Interprétation, attitude de Porter qui ferme le dialogue	« Je me demande si l'horaire vous convient. »
Recadrer devant tout le groupe	Menace pour l'image de la personne, risque d'humiliation	Un mot bref en séance, puis un échange à part
Laisser faire	Le groupe perçoit que les règles ne comptent pas	Rappeler calmement la règle décidée ensemble

À vous de jouer – Exercice d'application 3.24

Pendant un atelier, deux participantes se disputent : l'une reproche à l'autre de « tout faire à sa façon » et de ne pas la laisser cuisiner. Le ton monte. a) Que faites-vous immédiatement ? b) Rédigez, selon la méthode DESC, ce que vous direz à la participante qui accapare la tâche, en aparté. c) Quelle règle proposer au groupe pour la suite ?

Corrigé

a) Interrompre calmement, rappeler les règles du groupe (bienveillance, chacun participe), **recentrer** sur la tâche en répartissant les rôles (« Mme X, vous vous occupez de la sauce ; Mme Y, des légumes »), et proposer d'en reparler après la séance. **b)** « Tout à l'heure, vous avez pris en charge la découpe et la cuisson pendant que Mme Y attendait (D). Je vois que vous savez bien cuisiner, mais Mme Y n'a pas pu pratiquer, et elle est venue pour apprendre (E). La prochaine fois, je vous propose de lui montrer un geste puis de la laisser faire (S) : votre savoir-faire servira à tout le groupe et l'ambiance sera meilleure (C). » **c)** Une règle de **rotation des tâches** décidée avec le groupe et affichée : chacun réalise au moins une étape de la recette.

3.3.11 La motivation et les biais de décision

Module · Référentiel : C3.1, C3.2, C3.5 · CNED : pas de passage correspondant (voir 3.2.2)

La théorie de l'autodétermination

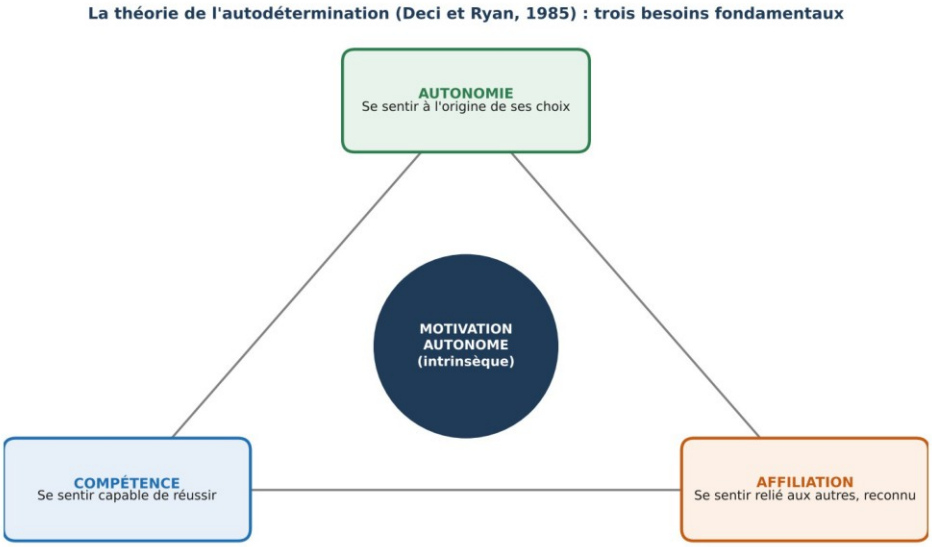


Figure 3.7 – Les trois besoins psychologiques fondamentaux

Comprendre le schéma – Figure 3.7

1. Deci et Ryan (1985) distinguent la motivation **intrinsèque** (agir pour le plaisir ou l'intérêt de l'activité), la motivation **extrinsèque** (agir pour une récompense, éviter une sanction, faire plaisir à quelqu'un) et l'**amotivation**.
2. Les motivations les plus durables sont **autonomes** : intrinsèques ou extrinsèques mais **intériorisées** (« Je cuisine parce que c'est important pour moi d'élever mes enfants en bonne santé »).
3. Elles sont favorisées par la satisfaction de trois besoins : **autonomie** (choisir), **compétence** (réussir), **affiliation** (se sentir relié aux autres).
4. Conséquences pour l'animation : laisser choisir (recettes, défis), proposer des tâches réalisables et valoriser les réussites, créer de la convivialité ; éviter les récompenses et les menaces qui affaiblissent la motivation intrinsèque (« Si tu finis tes légumes, tu auras un dessert » apprend à l'enfant que le légume est une corvée et le dessert une récompense).

Les biais cognitifs et les choix alimentaires

Le psychologue Daniel **Kahneman** (prix Nobel d'économie 2002) distingue un **système 1**, rapide, automatique et émotionnel, et un **système 2**, lent, réfléchi et coûteux en effort (*Système 1 / Système 2 : les deux vitesses de la pensée*, 2011). Une grande partie des choix alimentaires quotidiens, rapides et répétés, relève du système 1 : d'où les **biais**, utilisés par le marketing et, à l'inverse, par les **nudges** (chapitre 6).

Biais	Exemple alimentaire et usage en prévention
Préférence pour le présent	Le plaisir immédiat (dessert) l'emporte sur un bénéfice futur (santé dans 20 ans) : valoriser les bénéfices immédiats (énergie, goût, économies)
Effet de cadrage	« 95 % sans matière grasse » paraît plus sain que « 5 % de matière grasse » ; présenter les messages de façon positive

Biais	Exemple alimentaire et usage en prévention
Effet de halo	Un produit étiqueté « bio » ou « naturel » paraît moins calorique ; apprendre à lire l'étiquette entière
Biais de statu quo / option par défaut	On garde l'option proposée d'office : servir les légumes par défaut, l'eau en carafe
Ancrage	Le premier prix vu sert de référence ; une grande portion servie devient la norme (chapitre 4)
Biais d'optimisme	« Les maladies, ça arrive aux autres » : limite des messages fondés sur la peur
Preuve sociale	On imite ce que font les autres : normes descriptives positives (« 7 familles sur 10 ont goûté… »)

Le continuum de l'autodétermination

Deci et Ryan ne se contentent pas d'opposer motivation intrinsèque et extrinsèque. Ils décrivent un **continuum** : la motivation extrinsèque peut être plus ou moins **intériorisée**, c'est-à-dire faire plus ou moins partie des valeurs de la personne.

Type de motivation	Régulation	Ce que dit la personne	Durabilité
Amotivation	Aucune	« Je ne vois pas à quoi ça sert. »	Nulle
Extrinsèque	Externe	« Je mange des légumes pour que le médecin arrête de me sermonner. »	Faible : s'arrête avec la pression
Extrinsèque	Introjectée	« Je me sentirais coupable de ne pas en manger. »	Faible à moyenne : liée à la culpabilité
Extrinsèque	Identifiée	« C'est important pour ma santé, j'en vois l'intérêt. »	Bonne
Extrinsèque	Intégrée	« Cuisiner frais fait partie de qui je suis, comme parent. »	Très bonne
Intrinsèque	Intrinsèque	« J'adore cuisiner les légumes, c'est un plaisir. »	Très bonne

Exemple – L'effet de surjustification (Lepper, Greene et Nisbett, 1973)

Dans une école maternelle, des enfants qui aimaient spontanément dessiner avec des feutres ont été répartis en trois groupes. Le premier savait qu'il recevrait un diplôme s'il dessinait ; le deuxième l'a reçu par surprise ; le troisième n'a rien reçu. Une à deux semaines plus tard, pendant le temps libre, les enfants du premier groupe ont passé environ **deux fois moins de temps** à dessiner que ceux des deux autres groupes (environ 9 % du temps libre contre 17 à 18 %).

Explication : la récompense **attendue** a transformé une activité plaisante en « travail » fait pour obtenir quelque chose. **Leçon** : récompenser un enfant parce qu'il a goûté un légume risque de diminuer son envie d'en manger quand il n'y a plus de récompense. La reconnaissance **verbale**, sincère et inattendue, ne produit pas cet effet.

Les nudges et leurs limites éthiques

Définition – Nudge (Thaler et Sunstein, 2008)

Un **nudge** (« coup de pouce ») est une modification de l'**architecture du choix** qui oriente le comportement de façon prévisible, **sans interdire** aucune option et **sans changer** significativement les incitations financières. Mettre les fruits à hauteur des yeux est un nudge ; interdire les sodas n'en est pas un.

Exemple – Plus d'options végétariennes, plus de repas végétariens (Garnett et collaborateurs, 2019)

Dans les cafétérias de l'université de Cambridge, des chercheurs ont fait varier la part des plats végétariens proposés. En passant d'une option végétarienne sur quatre à **deux sur quatre**, les ventes de plats végétariens ont augmenté de **40 à 80 %** selon les cafétérias, sans baisse des ventes totales. Les clients qui mangeaient le moins souvent végétarien étaient les plus sensibles au changement (étude publiée dans *PNAS*). C'est un levier de l'**opportunité physique** (modèle COM-B), cohérent avec l'obligation d'un menu végétarien hebdomadaire en restauration scolaire posée par la loi EGalim (2018) et pérennisée par la loi Climat et résilience (2021).

Critère éthique	Question à se poser	Exemple
Transparence	La personne pourrait-elle repérer le nudge et le comprendre si on le lui expliquait ?	Une affiche « Ce mois-ci, le plat du jour est végétarien » est transparente
Liberté de choix	Toutes les options restent-elles accessibles sans effort excessif ?	Les desserts restent proposés, mais en fin de ligne
Intérêt de la personne	Le nudge sert-il la santé de la personne plutôt qu'un intérêt commercial ?	Mettre en avant l'eau plutôt que le soda à forte marge
Équité	Le nudge bénéficie-t-il aussi, et même surtout, aux plus défavorisés ?	Une option par défaut équilibrée profite à tous, sans effort ni coût
Respect	Le nudge évite-t-il la honte et la stigmatisation ?	Pas de messages culpabilisants sur les plateaux

Attention – Un nudge ne remplace pas une politique

Les nudges ont souvent des effets **modestes** et variables d'un lieu à l'autre. Ils ne corrigent pas les inégalités de revenus, de temps ou d'accès aux commerces. Ils complètent l'éducation pour la santé et les mesures structurelles (réglementation, prix, offre) ; ils ne s'y substituent pas (chapitres 1 et 6).

À vous de jouer – Exercice d'application 3.25

Un restaurant d'entreprise envisage trois mesures : A) placer les crudités en début de ligne et les frites en fin de ligne ; B) supprimer les desserts ; C) offrir un dessert gratuit pour chaque plateau « équilibré » validé par une application. a) Laquelle est un nudge au sens strict ? Justifiez pour chacune. b) Que prévoit la théorie de l'autodétermination pour la mesure C ? c) Vérifiez l'éthique de la mesure A avec deux critères.

Corrigé

a) A est un nudge : on modifie l'ordre de présentation, toutes les options restent accessibles, les prix ne changent pas. **B** n'est pas un nudge : c'est une **restriction** (une option est supprimée). **C** n'est pas un nudge : c'est une **incitation financière** (un avantage matériel). **b)** La récompense attendue risque de déplacer la motivation vers une **régulation externe** : les salariés composent un plateau « équilibré » pour le dessert gratuit et risquent d'arrêter quand l'offre s'arrête (effet de surjustification). **c) Transparence** : le placement est visible et peut être expliqué par une affiche. **Liberté** : les frites restent disponibles au même prix. La mesure sert l'intérêt des salariés et ne stigmatise personne.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 3.3.10 et 3.3.11 – Animer un groupe, motivation, biais

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez les cinq étapes de la vie d'un groupe selon Tuckman.
2. Quelles sont les trois familles de rôles de Benne et Sheats ?
3. Quel style d'animation l'expérience de Lewin, Lippitt et White (1939) recommande-t-elle ? Pourquoi ?

4. Rangez du moins au plus autodéterminé : régulation identifiée, régulation externe, motivation intrinsèque, régulation introjectée.
5. Qu'est-ce que l'effet de surjustification ? Citez l'expérience qui l'a montré.
6. Donnez la définition d'un nudge et un exemple.

Corrigé – Point d'étape 3.3.10 et 3.3.11

1. Formation, turbulence (tension), normalisation, production, dissolution.
2. Les rôles centrés sur la tâche, centrés sur l'entretien du groupe, individualistes.
3. Le style démocratique (participatif) : bonne production, motivation et cohésion fortes, travail qui continue sans l'adulte.
4. Régulation externe, régulation introjectée, régulation identifiée, motivation intrinsèque.
5. Une récompense attendue diminue la motivation intrinsèque pour une activité plaisante (Lepper, Greene et Nisbett, 1973 : enfants et feutres).
6. Une modification de l'architecture du choix qui oriente le comportement sans interdire d'option ni changer les incitations financières (Thaler et Sunstein, 2008) : fruits à hauteur des yeux.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la suite.
3 ou 4 sur 6	Je relis les encadrés « À retenir » et les définitions de la section, puis je refais les questions manquées.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la section et je refais les exercices d'application.

3.3.12 Mesurer attitudes et représentations

Module · Référentiel : C3.1, C3.2, C3.5 · CNED : pas de passage correspondant (voir 3.2.2)

Les représentations et les attitudes (3.3.3, 3.3.4) peuvent être **recueillies** et **mesurées** pour le diagnostic et l'évaluation. Trois méthodes sont simples à utiliser sur le terrain.

L'échelle de Likert

Méthode pas à pas – Construire et calculer un score d'attitude

Une échelle de **Likert** (1932) propose des affirmations avec lesquelles la personne indique son degré d'accord, généralement de 1 (« pas du tout d'accord ») à 5 (« tout à fait d'accord »). On mélange des affirmations **positives** et **négatives** pour limiter les réponses automatiques, et l'on **inverse** le score des affirmations négatives (score inversé = 6 − réponse) avant d'additionner.

Exemple – Calcul détaillé : score d'attitude envers les légumes secs

Affirmations : A1 « Les légumes secs sont bons pour la santé » (+) ; A2 « Les légumes secs sont difficiles à cuisiner » (−) ; A3 « Mes enfants aimeraient les légumes secs » (+) ; A4 « Les légumes secs, c'est un plat du pauvre » (−) ; A5 « J'aimerais en cuisiner plus souvent » (+). Réponses de Mme D. : A1 = 4 ; A2 = 5 ; A3 = 2 ; A4 = 3 ; A5 = 4.

- Inversion des items négatifs : A2 : 6 − 5 = **1** ; A4 : 6 − 3 = **3**.
- Score total : 4 + 1 + 2 + 3 + 4 = **14** sur un maximum de 5 × 5 = **25** (minimum 5).
- Score ramené sur 100 : (14 − 5) / (25 − 5) × 100 = 9 / 20 × 100 = **45 / 100**.
- **Lecture** : attitude plutôt neutre, avec un frein majeur sur la **difficulté perçue** (A2 = 1 après inversion) : un atelier pratique renforçant le sentiment d'efficacité personnelle (Bandura) est prioritaire ; l'image « plat

du pauvre » (A4) appelle des recettes valorisantes.
Après le cycle d'ateliers : A1 = 5 ; A2 = 2 ; A3 = 3 ; A4 = 2 ; A5 = 5. Inversions : A2 : 6 − 2 = 4 ; A4 : 6 − 2 = 4.
Total : 5 + 4 + 3 + 4 + 5 = **21** ; sur 100 : (21 − 5) / 20 × 100 = **80 / 100** (+ 35 points).

L'évocation hiérarchisée et l'analyse prototypique

Méthode pas à pas – Recueillir une représentation sociale par évocation (Vergès, 1992)

1. Poser une consigne d'**association libre** : « Quels sont les 3 à 5 mots qui vous viennent à l'esprit quand on dit "manger équilibré" ? »
2. Noter les mots dans l'**ordre** où ils sont cités (rang 1, 2, 3…).
3. Regrouper les mots de même sens (« cher », « coûte cher », « prix »).
4. Calculer pour chaque mot sa **fréquence** (nombre de personnes qui le citent) et son **rang moyen** d'apparition.
5. Fixer deux seuils : une fréquence (souvent la fréquence médiane ou un seuil choisi) et le rang moyen général.
6. Classer les mots dans un tableau à quatre cases : le **noyau central** probable (mots fréquents et cités tôt), les périphéries, les éléments contrastés.

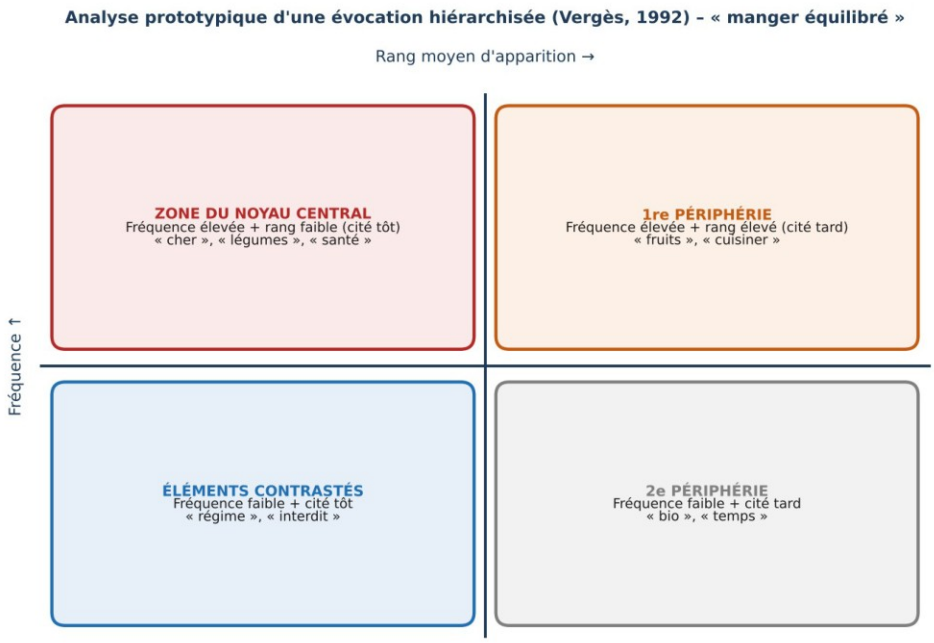


Figure 3.8 – L'analyse prototypique d'une évocation

Exemple – Calcul détaillé : la représentation de « manger équilibré » chez 30 parents

Mot (regroupé)	Fréquence	Rang moyen	Fréquence × rang
cher	21	1,6	33,6
légumes	18	1,9	34,2
fruits	16	2,9	46,4
santé	15	2,1	31,5
cuisiner	13	3,2	41,6
régime	6	1,8	10,8
interdit	5	2,0	10,0

Mot (regroupé)	Fréquence	Rang moyen	Fréquence × rang
temps	5	3,1	15,5
bio	4	3,4	13,6
Total	103		237,2

- Rang moyen général = somme (fréquence × rang) / somme des fréquences = 237,2 / 103 = **2,30**.
- Seuil de fréquence retenu : **10** (au moins un tiers des personnes).
- **Noyau central** probable (fréquence ≥ 10 et rang < 2,30) : **cher** (1,6), **légumes** (1,9), **santé** (2,1).
- **1re périphérie** (fréquence ≥ 10 et rang ≥ 2,30) : **fruits** (2,9), **cuisiner** (3,2).
- **Éléments contrastés** (fréquence < 10 et rang < 2,30) : **régime** (1,8), **interdit** (2,0) : une minorité associe l'équilibre à la privation.
- **2e périphérie** : **temps** (3,1), **bio** (3,4).

Interprétation : pour ces parents, « manger équilibré » est d'abord lié au **coût** et à la **santé** : le projet doit démontrer qu'on peut manger équilibré à petit prix (argument central), sans moraliser ; les éléments « régime » et « interdit » signalent un risque de restriction cognitive chez quelques personnes (chapitre 4). Le noyau central étant stable et résistant, on ne cherche pas à le « supprimer » mais à le **faire évoluer** par l'expérience (calcul du coût par portion en atelier).

Attention – Limites

L'analyse prototypique repère un noyau central **probable** ; sa confirmation demande d'autres méthodes (questionnaires de mise en cause). Sur de petits effectifs, les seuils sont fragiles : présentez les fréquences et restez prudent.

Le différenciateur sémantique

Définition – Différenciateur sémantique (Osgood, Suci et Tannenbaum, 1957)

Outil qui mesure la **signification** et l'**image** d'un objet (un aliment, un lieu, une action) à l'aide de paires d'adjectifs opposés placés aux deux extrémités d'une échelle, en général en 7 points. La personne coche la case qui correspond à son impression. On obtient un **profil** que l'on peut comparer entre groupes ou avant et après une action.

Calcul détaillé – L'image du « restaurant scolaire » chez 20 collégiens, avant et après un projet participatif (données fictives)

Échelle de 1 (adjectif de gauche) à 7 (adjectif de droite). Moyennes du groupe :

Paire d'adjectifs	Avant	Après	Évolution
Bruyant – calme	2,1	3,4	+1,3
Pas bon – bon	3,0	4,6	+1,6
Ennuyeux – convivial	3,5	4,9	+1,4
Imposé – choisi	2,4	4,2	+1,8
Pour les petits – pour les grands	2,8	3,1	+0,3

- Moyenne générale avant : (2,1 + 3,0 + 3,5 + 2,4 + 2,8) / 5 = 13,8 / 5 = **2,76**.
- Moyenne générale après : (3,4 + 4,6 + 4,9 + 4,2 + 3,1) / 5 = 20,2 / 5 = **4,04**, soit **+1,28** point.

Lecture : la plus forte évolution porte sur « imposé – choisi » (+1,8), cohérente avec un projet où les élèves

ont participé au choix des menus (besoin d'**autonomie**, section 3.3.11). L'image « pour les petits » a très peu changé : c'est une piste pour la suite (repas à thème choisis par les 3e, décoration). Sur 20 élèves, ces écarts restent des **tendances** à confirmer.

Exploiter des réponses libres : l'analyse de contenu

Les entretiens, les groupes de parole et les questions ouvertes produisent des **réponses libres**. Pour les exploiter, on réalise une **analyse de contenu** (Bardin, 1977).

Méthode pas à pas – Réaliser une analyse de contenu thématique simple

1. **Retranscrire** fidèlement les réponses ou les notes, en anonymisant.
2. **Lire** l'ensemble une première fois sans rien coder (lecture flottante).
3. **Découper** le texte en unités de sens (une idée par unité).
4. **Construire une grille de thèmes** à partir des objectifs et de ce qui ressort (coût, temps, goût des enfants, santé, culture…).
5. **Coder** chaque unité dans un thème ; compter le nombre de personnes qui évoquent chaque thème.
6. **Illustrer** chaque thème par une ou deux citations courtes et anonymes.
7. **Interpréter** en lien avec les modèles (COM-B, croyances relatives à la santé) et faire relire le codage par une autre personne si possible.

Les qualités d'un outil de mesure

Qualité	Question	Comment la vérifier simplement
Validité	L'outil mesure-t-il bien ce qu'il prétend mesurer ?	Utiliser un outil déjà validé ; faire relire par des experts ; vérifier que les items couvrent tout le concept
Fidélité	Donne-t-il des résultats stables ?	Faire répondre deux fois les mêmes personnes à quelques jours d'écart (test-retest) ; vérifier la cohérence des items entre eux (alpha de Cronbach, Cronbach 1951 : une valeur d'au moins 0,70 est souvent jugée acceptable)
Sensibilité	Détecte-t-il un changement ?	Éviter les échelles trop courtes ; vérifier qu'au départ les réponses ne sont pas toutes au maximum (effet plafond)
Acceptabilité	Le public peut-il y répondre facilement ?	Pré-test, durée de passation, vocabulaire

Méthode pas à pas – Pré-tester un questionnaire d'attitudes

1. Faire passer le questionnaire à 5 à 10 personnes semblables au public visé, mais qui ne feront pas partie de l'enquête.
2. Chronométrer la passation.
3. Demander après chaque question : « Comment avez-vous compris cette question ? » (entretien cognitif).
4. Repérer les mots incompris, les questions qui orientent la réponse, les doubles questions (« Aimez-vous les fruits et les légumes ? »), les réponses manquantes.
5. Corriger puis, si les changements sont importants, refaire un court pré-test.

À vous de jouer – Exercice d'application 3.26

Une étudiante prépare une échelle de Likert pour mesurer l'attitude de parents envers la cantine. Voici trois

items : 1) « Les repas de la cantine sont bons et équilibrés. » 2) « Ne pensez-vous pas que les enfants gaspillent trop ? » 3) « La cantine est bien. » a) Repérez le défaut de chaque item. b) Réécrivez-les. c) Comment vérifier que l'échelle est acceptable avant l'enquête ?

Corrigé

a) Item 1 : **double question** (on peut trouver les repas bons mais pas équilibrés). Item 2 : question **orientée** et posée sous forme interrogative alors qu'une échelle de Likert demande une affirmation. Item 3 : formulation **vague** (« bien » ne dit pas sur quoi porte le jugement). **b)** « Les repas de la cantine ont bon goût. » ; « Les repas de la cantine sont équilibrés. » ; « Les enfants laissent beaucoup de nourriture dans leur assiette. » ; « Mon enfant est content de manger à la cantine. » **c)** Par un **pré-test** auprès de 5 à 10 parents qui ne participeront pas à l'enquête : durée, compréhension de chaque item, vocabulaire, puis correction.

3.3.13 Un modèle intégrateur : COM-B et la roue du changement de comportement

Module · Référentiel : C3.1, C3.2, C3.5 · CNED : pas de passage correspondant (voir 3.2.2)

Les modèles présentés (croyances relatives à la santé, comportement planifié, étapes du changement, efficacité personnelle) éclairent chacun une partie du changement. Susan **Michie** et ses collègues (2011) ont proposé, à partir d'une revue de 19 modèles, un cadre **intégrateur** très utilisé en santé publique : le modèle **COM-B**, au cœur de la « roue du changement de comportement » (*Behaviour Change Wheel*).

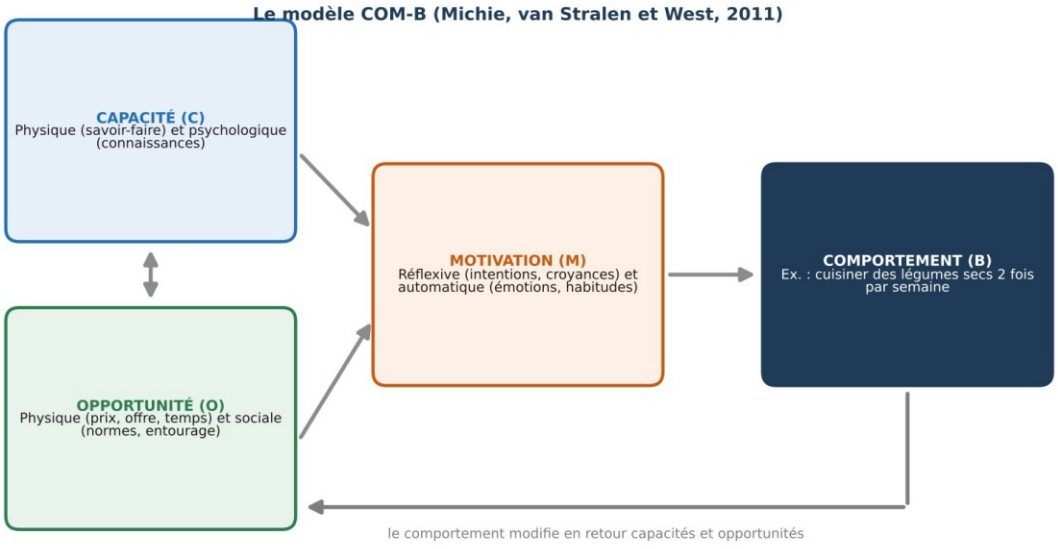


Figure 3.9 – Le modèle COM-B

Comprendre le schéma – Figure 3.9

1. Un **comportement** (B, *behaviour*) se produit quand trois conditions sont réunies : la **capacité** (C), l'**opportunité** (O) et la **motivation** (M).

2. Capacité : physique (savoir cuisiner, éplucher, utiliser un four) et psychologique (connaissances, compréhension, mémoire, organisation).

3. Opportunité : physique (prix, offre disponible, temps, équipement, accès) et sociale (normes, soutien de l'entourage, culture).

4. Motivation : réflexive (intentions, croyances, objectifs, identité) et automatique (émotions, désirs, habitudes, impulsions).

5. Capacité et opportunité influencent la motivation ; le comportement, une fois installé, renforce en retour

les capacités et les opportunités (on sait mieux faire, on achète autrement).

6. Intérêt : le diagnostic identifie **quelle composante manque** ; l'action est choisie en conséquence. Si le frein est l'opportunité (pas de commerce, pas de cuisine), une action purement informative (capacité psychologique) échouera.

Composante en défaut	Fonction d'intervention (roue du changement)	Exemple en nutrition
Capacité psychologique	Éducation (informer, faire comprendre)	Repères, lecture d'étiquettes
Capacité physique	Formation (apprendre des savoir-faire)	Atelier culinaire, gestes de découpe
Motivation réflexive	Persuasion, incitation	Témoignages, arguments d'économie, défis
Motivation automatique	Modélisation, aménagement de l'environnement, habitudes	Plats déjà prêts à goûter, routines (« légumes à chaque repas »)
Opportunité physique	Restructuration de l'environnement, facilitation	Fruits à la récréation, épicerie solidaire, micro-ondes en salle de pause
Opportunité sociale	Modélisation, soutien social, normes	Mamans relais, repas partagés, normes descriptives positives

Exemple – Analyse COM-B : pourquoi les familles ne cuisinent-elles pas de légumes secs ?

- **Capacité psychologique** : connaissances limitées sur la cuisson et l'intérêt nutritionnel (58 % « ne savent pas les cuisiner », chapitre 1).
- **Capacité physique** : peu de pratique (trempage, cuisson).
- **Opportunité physique** : produits disponibles à l'épicerie solidaire et peu chers (0,16 € la portion) : **pas de frein majeur** ; temps de cuisson perçu comme long (lentilles corail : 15 minutes).
- **Opportunité sociale** : représentation « plat du pauvre », enfants peu habitués.
- **Motivation** : réflexive favorable (envie d'économiser, 54 % demandent des ateliers) ; automatique défavorable (habitude des pâtes, des plats préparés).

Conclusion : les fonctions prioritaires sont la **formation** (atelier pratique), la **modélisation** (dégustation, mamans relais) et la **création d'habitudes** (recette « du mardi »), plutôt que l'information seule.

La roue du changement de comportement en entier

Le modèle COM-B est le **moyeu** d'une roue à trois anneaux (Michie, van Stralen et West, 2011). Autour de lui, **neuf fonctions d'intervention** ; à l'extérieur, **sept catégories de politiques** qui permettent de les mettre en œuvre.

Fonction d'intervention	Définition	Exemple en nutrition
Éducation	Augmenter les connaissances ou la compréhension	Atelier de lecture d'étiquettes
Persuasion	Utiliser la communication pour susciter des émotions positives ou négatives, ou stimuler l'action	Témoignage d'un pair qui a changé ses goûters
Incitation	Créer une attente de récompense	Chèques fruits et légumes dans une épicerie solidaire
Coercition	Créer une attente de sanction ou de coût	Taxe sur les boissons sucrées (créée en 2012, rendue progressive selon le sucre en 2018, relevée le 1er mars 2025)
Formation	Transmettre des savoir-faire	Atelier culinaire

Fonction d'intervention	Définition	Exemple en nutrition
Restriction	Utiliser des règles pour réduire les occasions d'un comportement	Interdiction des distributeurs automatiques payants dans les écoles (loi de 2004)
Restructuration de l'environnement	Changer le contexte physique ou social	Fontaines à eau, carafes sur les tables
Modélisation	Fournir un exemple à imiter	Animateur et parents qui goûtent devant les enfants
Facilitation	Réduire les obstacles ou augmenter les moyens	Garde d'enfants pendant l'atelier, transport

Catégorie de politique	Exemple
Communication et marketing	Campagnes « Manger Bouger »
Lignes directrices	Recommandations du PNNS, guide du GEM-RCN
Mesures fiscales	Taxe soda
Réglementation	Encadrement de la publicité alimentaire destinée aux enfants
Législation	Loi EGalim (2018) : 50 % de produits durables dont 20 % bio en restauration collective
Aménagement de l'environnement et de l'espace social	Jardins partagés, aménagement des selfs
Prestation de services	Consultations diététiques, ateliers de quartier

La taxonomie des techniques de changement de comportement

Pour décrire précisément ce que contient une intervention, Michie et ses collègues ont publié en 2013 une **taxonomie** de **93 techniques de changement de comportement** (en anglais *BCT Taxonomy v1*), regroupées en **16 groupes**. Elle permet de comparer les interventions et de savoir quels « ingrédients actifs » sont efficaces.

Exemple de technique (groupe)	Ce que fait l'intervenant
Fixation d'objectif comportemental (objectifs et planification)	Aide la personne à fixer un objectif précis
Planification de l'action (objectifs et planification)	Fait préciser quand, où et comment agir (« si..., alors... »)
Résolution de problèmes (objectifs et planification)	Fait identifier les obstacles et leurs solutions
Auto-surveillance du comportement (rétroaction et surveillance)	Propose un carnet pour noter les portions de légumes
Soutien social pratique (soutien social)	Organise un binôme de courses
Démonstration du comportement (modélisation)	Montre la découpe des légumes
Répétition et entraînement (répétition et substitution)	Fait refaire la recette plusieurs fois
Restructuration de l'environnement physique (antécédents)	Aide à ranger les fruits en vue dans la cuisine
Récompense non spécifique (récompense et menace)	Félicite le groupe

Méthode pas à pas – Concevoir une intervention avec la roue (huit étapes résumées)

1. Définir le problème en termes de comportement (qui doit faire quoi, où, quand).
2. Choisir le comportement cible le plus prometteur.
3. Le décrire précisément.
4. Identifier ce qui doit changer à l'aide de COM-B (diagnostic).
5. Choisir les fonctions d'intervention adaptées.
6. Choisir les catégories de politiques mobilisables.

7. Choisir les techniques de changement de comportement.
8. Choisir le mode de mise en œuvre (face-à-face, groupe, numérique, affichage).

À vous de jouer – Exercice d'application 3.27

Dans une résidence étudiante, le diagnostic montre que les étudiants mangent peu de légumes : ils disent ne pas savoir les cuisiner (1), la cuisine collective n'a qu'une plaque qui fonctionne (2), et « personne ne cuisine ici, on commande » (3). a) Classez chaque frein dans une composante de COM-B. b) Proposez une fonction d'intervention et une technique de changement de comportement pour chacun. c) Quelle catégorie de politique relève du gestionnaire de la résidence ?

Corrigé

a) (1) **Capacité physique** (savoir-faire) et psychologique ; (2) **opportunité physique** ; (3) **opportunité sociale** (norme du groupe), qui joue aussi sur la motivation automatique. **b)** (1) **Formation** : atelier « légumes en 15 minutes » ; techniques : démonstration du comportement, répétition et entraînement. (2) **Restructuration de l'environnement** et **facilitation** : réparer les plaques, fournir des ustensiles ; technique : restructuration de l'environnement physique. (3) **Modélisation** et soutien social : soirées « cuisine partagée » animées par des étudiants relais ; techniques : soutien social pratique, démonstration par des pairs. **c)** La **prestation de services** et l'**aménagement de l'environnement** (équipement de la cuisine, organisation de soirées) relèvent du gestionnaire.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 3.3.12 et 3.3.13 – Mesurer, et le modèle COM-B

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Pourquoi mélange-t-on des affirmations positives et négatives dans une échelle de Likert ?
2. Dans une analyse prototypique, comment repère-t-on le noyau central probable ?
3. Distinguez validité et fidélité d'un outil de mesure.
4. Citez les trois composantes du modèle COM-B et leurs deux sous-composantes.
5. Citez cinq des neuf fonctions d'intervention de la roue du changement.
6. Combien de techniques compte la taxonomie de Michie (2013) ? À quoi sert-elle ?

Corrigé – Point d'étape 3.3.12 et 3.3.13

1. Pour limiter les réponses automatiques (tout cocher « d'accord ») ; on inverse les items négatifs avant le calcul.
2. Les mots à la fois fréquents (au-dessus du seuil de fréquence) et cités tôt (rang moyen inférieur au rang moyen général).
3. Validité : l'outil mesure bien ce qu'il prétend mesurer. Fidélité : il donne des résultats stables et cohérents.
4. Capacité (physique, psychologique), opportunité (physique, sociale), motivation (réflexive, automatique).
5. Éducation, persuasion, incitation, coercition, formation, restriction, restructuration de l'environnement, modélisation, facilitation.
6. 93 techniques en 16 groupes ; elle sert à décrire précisément le contenu d'une intervention et à comparer les interventions.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la suite.
3 ou 4 sur 6	Je relis les encadrés « À retenir » et les définitions de la section, puis je refais les questions manquées.

Mon score	Ce que je fais
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la section et je refais les exercices d'application.

3.3.14 Adapter l'approche psychosociale aux publics

Module · Référentiel : C3.1, C3.2, C3.5 · Guide 2025 : p. 61 · CNED : Synthèse M5 S3 (p. 40 à 43) ; Synthèse M5 S4 (p. 44 à 46)

Public	Spécificités psychosociales	Leviers
Jeunes enfants (3-6 ans)	Néophobie, imitation, besoin de répétition et de jeu, dépendance aux adultes	Exposition répétée sans pression, éducation sensorielle, modèles adultes, implication des parents
Enfants (6-11 ans)	Curiosité, besoin de compétence, influence de l'école et des pairs	Activités pratiques, défis, jardinage, cuisine, valorisation
Adolescents	Autonomie, identité, appartenance au groupe, image corporelle, sensibilité au marketing	Pair-éducation, littératie critique, choix, pas de moralisation, vigilance TCA
Jeunes adultes, étudiants	Première autonomie alimentaire, budget, temps, isolement	Cuisine rapide et économique, convivialité, numérique accompagné
Parents	Préoccupation pour les enfants, culpabilité possible, contraintes de temps et de budget	Valoriser leurs compétences, solutions pratiques, déculpabiliser
Personnes âgées	Perte d'appétit, deuil, isolement, habitudes anciennes, peur de la dépendance	Lien social, plaisir, respect des habitudes, enrichissement, repérage de la dénutrition
Personnes en précarité	Priorités de survie, stress, honte, méfiance envers les institutions, faible pouvoir d'agir	Accueil inconditionnel, gratuité, concret, participation, pas de jugement, orientation vers les droits
Personnes migrantes	Acculturation, langue, attachement aux plats d'origine, nouveaux produits	Interculturalité, valorisation des cuisines d'origine, interprétariat, pictogrammes
Personnes en situation de handicap	Besoins spécifiques (cognitifs, moteurs, sensoriels), dépendance à l'entourage	FALC, adaptation du matériel, implication des aidants et des éducateurs

À vous de jouer – Exercice d'application 3.28

Un groupe de parole avec des parents d'adolescents révèle : « Mon fils mange tout le temps des chips devant ses jeux vidéo » ; « Ma fille ne mange plus le soir, elle veut maigrir » ; « Ils achètent des boissons énergisantes avec leur argent de poche ». Analysez chaque situation avec COM-B et proposez une fonction d'intervention.

Corrigé

a) Chips devant les jeux : **motivation automatique** (habitude, grignotage associé à l'écran) et **opportunité physique** (chips disponibles à la maison) → **restructuration de l'environnement** (collations disponibles : fruits, fromage, pain ; pas de stock de chips) et habitudes (pause collation hors écran). **b)** Restriction pour maigrir : **motivation réflexive** (désir de minceur, normes corporelles) avec risque de TCA → pas d'intervention éducative ciblée sur le poids ; **orientation** vers l'infirmière scolaire ou le médecin, travail des parents sur la non-stigmatisation et le plaisir du repas familial (chapitres 4 et 6). **c)** Boissons énergisantes : **opportunité sociale** (normes du groupe, marketing) et **motivation automatique** → **modélisation** et **persuasion** par des pairs, littératie critique du marketing, alternatives appréciées (eaux aromatisées maison).

Le développement de la personne, de l'enfance à la vieillesse

La **psychologie du développement** étudie l'évolution psychologique de la personne tout au long de la vie, de la période fœtale au vieillissement : développement moteur, cognitif, du langage, de l'identité, affectif et social.

Courant	Auteur repère	Idée principale
Maturationniste	Arnold Gesell	Le développement suit surtout un programme biologique
Béhavioriste	John B. Watson	L'environnement et les apprentissages façonnent le comportement
Psychanalytique	Sigmund Freud	Les relations et les expériences de l'enfance construisent le psychisme
Éthologique	Harry Harlow, John Bowlby	Le besoin de contact et d'attachement est inné, indépendant de la faim
Cognitivo-constructiviste	Jean Piaget	L'enfant construit son intelligence en agissant ; la maturation est nécessaire mais pas suffisante
Psychosocial	Henri Wallon	Aspects cognitifs, affectifs et sociaux sont liés

Aujourd'hui, la plupart des chercheurs ont une vision **modulaire** : chaque fonction (mémoire, langage, émotions, relations) a son propre rythme, et la prise en charge cherche les différents facteurs en cause.

- **Stades de Piaget** : sensori-moteur (0 à 2 ans), préopératoire (2 à 7 ans), opératoire concret (7 à 11 ans), opératoire formel (à partir de 11-12 ans).
- **Stade du miroir** (Jacques Lacan, 1936 et 1949), entre 6 et 18 mois environ : l'enfant prend son reflet pour un autre enfant (le **réel**), puis comprend que c'est une image (l'**imaginaire**), enfin la reconnaît comme la sienne (le **symbolique**). Il se distingue de sa mère et construit son **schéma corporel**.
- **Relation mère-enfant** (Winnicott) : dépendance absolue (premiers mois), dépendance relative, puis marche vers l'indépendance.
- **Adolescence** : remaniement biologique, psychique et social ; prise de distance avec les parents ; recours possible au passage à l'acte ou à l'idéalisation.
- **Adulte et personne âgée** : l'intelligence générale change peu jusqu'à 60 ou 70 ans ; la vitesse diminue, mais la **plasticité** permet d'apprendre à tout âge. Avec l'âge, la vulnérabilité augmente et l'adaptation devient plus difficile.

> **Lien diététique – Adapter l'éducation nutritionnelle à l'âge**
>
> Avant 7 ans, on passe par les sens, le jeu et la répétition ; entre 7 et 11 ans, par des manipulations concrètes (trier, peser, cuisiner) ; à partir de 12 ans, on peut discuter de notions abstraites et d'arguments ; chez l'adolescent, on respecte le besoin d'autonomie et le rôle des pairs ; chez la personne âgée, on s'appuie sur l'expérience et on laisse du temps.

La maladie, le stress et la fin de vie

- Le **diagnostic** change le statut de la personne (« je suis diabétique ») et peut bouleverser son équilibre psychique et social.
- L'approche **psychosomatique** (du grec *psyché*, l'esprit, et *soma*, le corps) étudie l'influence de l'esprit sur le corps.
- **Stress** : Hans Selye (1936) décrit le **syndrome général d'adaptation** en trois phases : **alarme** (adrénaline, cœur et respiration accélérés), **résistance** (cortisol, mobilisation du glucose), **épuisement** si le stress dure. Sur le plan digestif : « boule au ventre », nausées, troubles du transit, et souvent changement de l'appétit.
- **Faire face** (*coping*, Lazarus et Folkman, 1984) : agir sur la **cause** du stress (stratégie centrée sur le problème) ou réguler ses **émotions** (stratégie centrée sur l'émotion).

- **La mort** : autrefois à domicile et entourée de rites, elle se déroule aujourd'hui surtout à l'hôpital ; elle est plus « cachée ».

Lien diététique – Le rôle du diététicien auprès des malades et en fin de vie

Prendre conscience de ses propres représentations de la maladie et de la mort ; écouter les peurs et les souffrances de la personne ; en soins palliatifs, l'objectif n'est plus de corriger un état nutritionnel mais de préserver le **confort** et le **plaisir** de manger, en respectant les choix du patient et de ses proches.

3.3.15 Concevoir une séance qui développe les compétences psychosociales en nutrition

Module · Référentiel : C3.1, C3.2, C3.5 · Guide 2025 : p. 61 · CNED : pas de passage correspondant (voir 3.2.2)

Les compétences psychosociales (3.3.5) se développent par des **activités expérientielles** structurées, répétées sur plusieurs séances, et non par un discours. Santé publique France (2022) recommande des programmes d'au moins une dizaine de séances, conduits par des intervenants formés, avec des méthodes interactives. Une séance « nutrition » peut cibler explicitement une ou deux CPS.

Exemple – Conducteur d'une séance CPS « Je choisis mon goûter » (élèves de CM1, 1 h 15)

Durée	Étape et CPS visée	Déroulement	Matériel
10 min	Accueil – conscience de soi	Météo des émotions : chaque élève place son prénom sur un visage (content, fatigué, inquiet…) ; on explique que la faim et les émotions peuvent se confondre	Affiche des émotions
15 min	Ressentir – conscience de soi	Échelle de la faim (chapitre 4) : chaque élève situe sa faim avant le goûter ; échange sur « faim » et « envie »	Échelle illustrée
20 min	Analyser – pensée critique	Par groupes, comparaison de 4 emballages de goûters : ce que dit la publicité, ce que dit l'étiquette (sucres en morceaux de sucre)	Emballages, morceaux de sucre
15 min	Décider – prise de décision	Chaque groupe compose un goûter « qui donne de l'énergie, qui fait plaisir, qui coûte peu » parmi des cartes-aliments, et justifie son choix	Cartes-aliments, prix
10 min	Communiquer – affirmation de soi	Jeu de rôle : refuser poliment une boisson sucrée proposée par un camarade, proposer une alternative	Scénarios
5 min	Bilan – conscience de soi	« Ce que j'ai appris, ce que je ferai » ; feuille d'engagement facultative	Fiches

Pourquoi cette séance travaille des CPS : les élèves identifient leurs émotions et sensations (compétences **cognitives et émotionnelles** : conscience de soi), exercent leur **pensée critique** face au marketing, prennent une **décision** argumentée en groupe et s'**affirment** face à la pression des pairs (compétences **sociales**). La séance s'inscrit dans un **programme** (plusieurs séances) mené avec l'enseignant, et non dans une intervention isolée.

Attention – Ce qui n'est pas une séance CPS

Une conférence sur l'équilibre alimentaire, un quiz de connaissances ou une distribution de dépliants ne développent pas de compétences psychosociales : ils transmettent des informations. Une séance CPS fait **vivre** et **pratiquer** une compétence (identifier, analyser, décider, dire non, coopérer), dans un climat bienveillant, avec un temps de retour sur l'expérience.

3.3.16 Fil rouge : les représentations et les dynamiques du groupe des Tilleuls

Module · Référentiel : C3.1, C3.2, C3.5 · CNED : pas de passage correspondant (voir 3.2.2)

Fil rouge – centre social des tilleuls – Ce qu'Inès a observé et comment elle l'a utilisé

- **Représentations recueillies** (photolangage « bien manger pour moi », 8 parents) : « bien manger = de la viande tous les jours » (noyau central fortement partagé) ; « les légumes coûtent cher » ; « les lentilles, c'est pour les gens pauvres » (représentation dévalorisante) ; « cuisiner prend du temps ».
- **Usage** : Inès n'a pas contredit ces représentations ; elle a agi sur les éléments **périphériques** : montrer un plat complet sans viande apprécié de tous (parmentier de lentilles, 4,3/5 en dégustation), calculer ensemble le coût par portion (1,38 € le repas complet), proposer des recettes de 20 minutes.
- **Dynamique de groupe** : une participante, Mme D., très appréciée, a goûté la première le dahl de lentilles (influence d'un « leader » positif) ; les autres ont suivi (conformisme favorable).
- **Engagement** : à la fin de chaque atelier, chacun choisissait librement une recette à refaire et l'annonçait au groupe ; à l'atelier suivant, les essais étaient valorisés.
- **CPS travaillées** : prise de décision (menu à 10 €), communication (cuisiner en binôme), estime de soi (photos des plats exposées au centre social, avec accord).
- **Interculturalité** : l'atelier 6 « recettes du monde » a permis à trois mères de transmettre un plat de leur pays (tiep, chorba, dal) : valorisation identitaire et stratégie d'**intégration**.

Fil rouge – centre social des tilleuls – Compléments : mesures et animation du groupe des Tilleuls

- **Évocation hiérarchisée** : en complément du photolangage, Inès a recueilli les mots associés à « manger équilibré » auprès de **30 parents** lors de la passation du questionnaire (analyse détaillée en 3.3.12 : noyau central probable « cher », « légumes », « santé »). Les deux méthodes convergent : la question du **coût** est centrale, et la **viande** reste, pour beaucoup, la marque d'un « vrai repas ».
- **Score d'attitude** envers les légumes secs (échelle de Likert à 5 items, sur 100) : moyenne des 12 participants **48/100** au 1er atelier, **74/100** au 6e (+ 26 points) ; l'item « difficiles à cuisiner » est celui qui a le plus progressé, ce qui confirme l'effet des ateliers pratiques sur le **sentiment d'efficacité personnelle**.
- **Étapes du groupe** : l'atelier 2 a connu une phase de **turbulence** (désaccord sur le partage des tâches et sur l'usage du téléphone) ; Inès a proposé au groupe d'établir lui-même ses règles (« téléphone en silencieux, chacun goûte s'il le souhaite, on range ensemble ») : **normalisation** dès l'atelier 3 ; à l'atelier 5, deux mamans ont animé seules la préparation du crumble (**production**) ; l'atelier 6 et le temps fort ont préparé la **dissolution** (bilan, suite avec les mamans relais).
- **Style d'animation** : participatif pour les contenus (choix des recettes du monde), directif pour le cadre (hygiène, sécurité au four).
- **Écoute active** : face à une mère répétant « mes enfants ne mangent que des pâtes », Inès a d'abord reformulé (« c'est décourageant ») avant de proposer, avec le groupe, des « pâtes cachées aux légumes » : la mère a refait la recette deux fois.

3.3.17 Trois cas guidés pour s'entraîner à l'analyse psychosociale

Module · Référentiel et guide : voir 3.2.1 · CNED : pas de passage correspondant (voir 3.2.2)

Ces trois cas reprennent les notions du chapitre dans l'ordre où le jury les attend : décrire la situation, la relier à un modèle, calculer et lire des indicateurs, puis proposer une action argumentée. Essayez de répondre avant de lire chaque corrigé.

Cas guidé 1 – L'épicerie solidaire de Montclair (données fictives)

Une épicerie solidaire accueille 120 foyers. La conseillère en économie sociale et familiale constate que les

légumes frais proposés à petit prix partent mal. Elle sollicite un diététicien. Un questionnaire est rempli par **40 bénéficiaires** volontaires.

- Étapes du changement pour « cuisiner des légumes frais au moins 4 fois par semaine » : précontemplation 10 ; contemplation 14 ; préparation 8 ; action 5 ; maintien 3.
- Scores moyens (échelle de 1 à 5) : attitude envers les légumes 4,1 ; norme subjective 3,6 ; intention 3,0. Contrôle perçu, trois items : « J'ai le temps de les cuisiner » 2,6 ; « J'ai le matériel nécessaire » 2,4 ; « Je sais comment les cuisiner » 1,6.
- Verbatims : « Les légumes, je ne sais pas quoi en faire à part la soupe » ; « Mes enfants veulent des frites » ; « Chez moi, il n'y a qu'une plaque électrique ».

Questions – Cas guidé 1

1. Calculez la répartition des 40 bénéficiaires selon les étapes du changement et le score moyen de contrôle perçu.
2. Interprétez les résultats avec la théorie du comportement planifié.
3. Analysez la situation avec le modèle COM-B.
4. Proposez deux actions, en précisant les fonctions d'intervention et l'étape du changement visée.

Corrigé – Cas guidé 1

1. Précontemplation 10 / 40 = **25,0 %** ; contemplation 14 / 40 = **35,0 %** ; préparation 8 / 40 = **20,0 %** ; action 5 / 40 = **12,5 %** ; maintien 3 / 40 = **7,5 %**. Contemplation et préparation réunissent 22 personnes, soit **55,0 %** : plus de la moitié du groupe envisage de changer sans être passée à l'action. Contrôle perçu moyen : (2,6 + 2,4 + 1,6) / 3 = 6,6 / 3 = **2,2 sur 5**.

2. L'**attitude** est favorable (4,1) et la **norme subjective** plutôt favorable (3,6), mais le **contrôle perçu** est faible (2,2), surtout pour le savoir-faire (1,6). Selon Ajzen, le contrôle perçu limite l'intention (3,0, moyenne) et agit aussi directement sur le comportement : informer sur les bienfaits des légumes (attitude) serait inutile, puisque les bénéficiaires en sont déjà convaincus.

3. Capacité physique et psychologique insuffisante (« je ne sais pas quoi en faire ») ; **opportunité physique** limitée (une seule plaque, peu de matériel) ; **opportunité sociale** en partie défavorable (préférences des enfants) ; **motivation réflexive** plutôt favorable ; **motivation automatique** orientée par les habitudes (frites, soupe).

4. Action 1 : **atelier culinaire** « légumes avec une seule plaque » (poêlées, légumes râpés, gratins au four de l'épicerie si possible) : fonctions **formation** et **facilitation** ; techniques : démonstration, répétition, plan « si…, alors… » ; public visé : étapes de **contemplation** et de **préparation**. Action 2 : **dégustations** à l'épicerie avec fiches-recettes illustrées et prêt d'ustensiles, enfants invités à participer : fonctions **modélisation**, **restructuration de l'environnement** et facilitation ; elle touche aussi les personnes en **précontemplation**, sans exiger d'engagement.

Cas guidé 2 – Une séance qui dérape (extrait)

Lors de la deuxième séance d'un cycle avec 10 parents d'un quartier prioritaire, une animatrice stagiaire aborde les boissons sucrées. Voici un extrait de l'échange.

1. **Animatrice** : « Qui boit du soda à la maison ? »
2. **M. B.** : « Nous, tous les jours. Les enfants adorent. »
3. **Animatrice** : « Ce n'est vraiment pas bien, un litre de soda contient environ 100 grammes de sucre. »
4. **Mme L.** : « Oui mais l'eau du robinet, chez nous, elle a un goût. »
5. **Animatrice** : « Vous pouvez la mettre au frigo dans une carafe, c'est simple. Et vous savez que c'est mauvais pour les dents ? »

6. M. B. : « De toute façon, on a toujours fait comme ça et personne n'est malade. »
7. Mme T. (qui ne parlait pas) : « Moi j'ai arrêté les sodas, je fais de l'eau avec du citron. »
8. Animatrice : « Très bien ! Voilà, vous voyez, c'est possible. »
9. M. B. se tait et regarde son téléphone jusqu'à la fin.

Questions – Cas guidé 2

1. Identifiez l'attitude de Porter utilisée en 3 et en 5.
2. Quel phénomène décrit par l'entretien motivationnel se produit entre 3 et 6 ? Comment se manifeste-t-il ?
3. À quelle étape de la vie du groupe sommes-nous ? Le désaccord est-il un problème ?
4. Comptez les questions et les reflets de l'animatrice et calculez le rapport reflets / questions. Commentez.
5. Réécrivez les répliques 3, 5 et 8 dans l'esprit de l'entretien motivationnel.

Corrigé – Cas guidé 2

1. En 3 : **évaluation** (jugement : « ce n'est vraiment pas bien ») suivie d'une information non demandée. En 5 : **solution** (conseil immédiat), puis question fermée orientée qui sonne comme un nouveau jugement.

2. Le **réflexe correcteur** de l'animatrice provoque la **résistance** et le **discours-maintien** (« de toute façon, on a toujours fait comme ça ») ; M. B. finit par se retirer de l'échange (réplique 9), ce qui est aussi une forme de résistance. Plus l'animatrice argumente pour le changement, plus le parent défend le statu quo.

3. Deuxième séance : fin de la **formation** et début de la **turbulence** (Tuckman). Le désaccord est **normal** et signe l'implication ; le problème vient de la façon dont il est traité (jugement), qui risque de faire perdre un participant.

4. Questions : répliques 1 et 5, soit **2** questions. Reflets : **aucun** (la réplique 8 est une valorisation, pas un reflet). Rapport reflets / questions = 0 / 2 = **0** : très loin du repère d'au moins 1 (MITI 4). L'animatrice informe et juge au lieu d'écouter.

5. Réplique 3 : « Les sodas font partie des habitudes de la famille, les enfants y sont attachés. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? » Réplique 5 : « Le goût de l'eau vous gêne. Voulez-vous que je vous donne quelques idées que d'autres familles utilisent ? » (demander la permission, puis informer). Réplique 8 : valoriser sans opposer : « Merci, Mme T. Vous avez trouvé votre façon de faire. Chaque famille a ses habitudes ; qu'est-ce qui pourrait être faisable chez vous, même un petit peu ? », en s'adressant au groupe et non à M. B. seul.

Cas guidé 3 – Évaluer un cycle d'ateliers en résidence autonomie (données fictives)

Une diététicienne anime un cycle de 6 ateliers sur 3 mois avec 10 résidents d'une résidence autonomie. L'objectif est de favoriser un **dîner complet** (avec une source de protéines), car beaucoup de résidents se contentent d'une soupe ou d'un café au lait le soir. Avant le premier et après le dernier atelier, chaque résident répond à une échelle de Likert de 5 items (score de 5 à 25) sur son attitude envers le dîner complet, et indique son étape du changement.

- Scores avant : 12, 15, 9, 18, 11, 14, 16, 10, 13, 17.
- Scores après : 17, 18, 15, 19, 12, 20, 21, 11, 18, 22.
- Étapes avant : précontemplation 3, contemplation 4, préparation 2, action 1, maintien 0.
- Étapes après : précontemplation 1, contemplation 2, préparation 3, action 4, maintien 0.

Questions – Cas guidé 3

1. Calculez le score moyen avant et après, son évolution, et les scores moyens ramenés sur 100.
2. Calculez la médiane avant et après. Combien de résidents ont progressé de plus de 1 point ?

3. Décrivez l'évolution des étapes du changement. Pourquoi aucun résident n'est-il au stade du maintien ?

4. Citez quatre limites de cette évaluation.

Corrigé – Cas guidé 3

1. Somme avant : 135, moyenne **13,5** ; somme après : 173, moyenne **17,3** ; évolution **+3,8 points**. Sur 100 : avant (13,5 − 5) / 20 × 100 = **42,5** ; après (17,3 − 5) / 20 × 100 = **61,5** ; soit **+19 points** sur 100.

2. Scores avant rangés : 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ; médiane = (13 + 14) / 2 = **13,5**. Scores après rangés : 11, 12, 15, 17, 18, 18, 19, 20, 21, 22 ; médiane = (18 + 18) / 2 = **18,0**. Les écarts individuels sont 5, 3, 6, 1, 1, 6, 5, 1, 5, 5 : les 10 résidents ont progressé, mais **3** seulement de 1 point ; **7 sur 10** ont progressé de plus de 1 point.

3. Les personnes en précontemplation passent de 3 à 1 et celles en action de 1 à 4 : le groupe a globalement **avancé** dans le cycle. Aucun résident n'est en **maintien**, car ce stade suppose un changement installé depuis **plus de 6 mois** et le cycle n'a duré que 3 mois ; il faudra une nouvelle mesure à 6 mois au moins.

4. Effectif très faible (10 personnes) : on parle de **tendances** ; **pas de groupe témoin** (l'évolution pourrait être due à autre chose, par exemple un changement de menu à la résidence) ; **désirabilité sociale** (les résidents peuvent répondre ce qu'ils pensent que la diététicienne attend) ; mesure de l'**attitude** et de l'étape déclarée, pas du comportement réel (il faudrait un relevé des dîners) ; pas de recul sur la durée.

3.4 Approfondissements

3.4.1 Néophobie alimentaire et exposition répétée

La **néophobie alimentaire** (réticence à goûter des aliments nouveaux) est maximale entre 2 et 6 ans ; elle est normale et adaptative (protection contre les aliments dangereux). Elle diminue avec l'**exposition répétée** : proposer un aliment 8 à 15 fois, sans pression, en petites quantités, dans un contexte agréable, augmente son acceptation. La **pression** (« finis ton assiette ») et la **récompense** par un dessert (« si tu manges tes légumes, tu auras un gâteau ») sont contre-productives : elles dévalorisent l'aliment cible et valorisent l'aliment récompense. Le modèle parental (manger soi-même les légumes) et l'**éducation sensorielle** (toucher, sentir, décrire) sont efficaces.

Exemple – Exposition ou récompense ? (Wardle et collaborateurs, 2003)

Des enfants de 5 à 7 ans ont goûté chaque jour, pendant 8 jours, un légume qu'ils aimaient peu (du poivron rouge cru). Un groupe le goûtait simplement (exposition) ; un autre recevait un autocollant à chaque fois (exposition et récompense) ; un groupe témoin ne le goûtait pas. L'appréciation et la quantité consommée ont augmenté dans le groupe **exposition seule** ; l'ajout de la récompense n'a pas apporté de bénéfice supplémentaire clair. **Leçon** : la répétition, sans pression et sans récompense, suffit ; la récompense n'est pas nécessaire et peut même nuire à long terme (effet de surjustification, section 3.3.11).

Définition – Néophobie et sélectivité alimentaire

- La **néophobie** est le refus des aliments **nouveaux** ou inconnus.
- La **sélectivité** (en anglais *picky eating*) est le refus d'une partie des aliments **familiers**, avec un répertoire alimentaire restreint.

Les deux sont fréquentes chez le jeune enfant et diminuent en général avec l'âge. Une sélectivité très marquée, avec perte de poids, retard de croissance ou détresse importante, doit faire penser à un trouble (par exemple le trouble d'évitement et de restriction de l'apport alimentaire, ARFID) et justifie une **orientation** médicale.

Calcul détaillé – L'échelle de néophobie alimentaire de Pliner et Hobden (1992)

L'échelle comporte **10 affirmations** notées de 1 (« pas du tout d'accord ») à 7 (« tout à fait d'accord »). Cinq affirmations expriment la néophobie (« Je n'aime pas les aliments que je ne connais pas ») ; cinq expriment l'ouverture (« J'aime goûter des aliments d'autres pays »). Les affirmations d'ouverture sont inversées (score inversé = 8 − réponse). Le score total va de **10 à 70** : plus il est élevé, plus la personne est néophobe.

Réponses de M. R., 45 ans, à un questionnaire d'atelier : items néophobes 6, 5, 6, 4, 5 (total **26**) ; items d'ouverture 2, 3, 1, 3, 2, inversés en 6, 5, 7, 5, 6 (total **29**).

- Score total : 26 + 29 = **55 sur 70**.
- Position sur l'étendue : (55 − 10) / (70 − 10) × 100 = 45 / 60 × 100 = **75 / 100**.

Lecture : M. R. est plutôt néophobe. Dans l'atelier, on lui propose de goûter en petite quantité, avec un aliment familier à côté, et on présente les nouveautés à partir de saveurs connues (épices douces, plats de son enfance revisités).

Méthode pas à pas – Organiser une exposition répétée en crèche ou à l'école

1. Choisir un aliment cible (un légume peu consommé) et prévoir **8 à 15** présentations.
2. Le proposer en **petite quantité**, à côté d'aliments connus, sous la même forme au début.
3. Laisser l'enfant le **toucher**, le sentir, le décrire, le recracher dans une serviette s'il le souhaite.
4. Montrer l'exemple : l'adulte en mange avec plaisir à la même table.
5. Ne jamais forcer, ne pas récompenser, ne pas punir ; féliciter simplement la curiosité.
6. Noter à chaque fois l'acceptation (refus, touche, goûte, mange) pour voir la progression et rassurer l'équipe et les parents.

3.4.2 Les normes sociales comme levier

Les campagnes fondées sur les **normes descriptives** (« 8 élèves sur 10 de ce collège boivent de l'eau à la récréation ») peuvent être plus efficaces que les injonctions, à condition que la norme présentée soit favorable et **vraie** : diffuser « 60 % des jeunes boivent des sodas tous les jours » risque au contraire de **normaliser** le comportement à éviter (effet boomerang).

Exemple – L'effet boomerang des normes descriptives (Schultz et collaborateurs, 2007)

Près de 300 foyers californiens ont reçu une information sur leur consommation d'électricité comparée à la moyenne de leur quartier (norme **descriptive**). Les foyers qui consommaient **plus** que la moyenne ont réduit leur consommation. Mais ceux qui consommaient **moins** l'ont augmentée : ils se sont rapprochés de la norme (effet **boomerang**). Lorsqu'on ajoutait un petit visage souriant pour les foyers économes (norme **injonctive** : approbation), l'effet boomerang disparaissait.

En nutrition : dire à des familles qui servent déjà des légumes chaque jour que « la moyenne des familles en sert 3 fois par semaine » peut les inciter à en servir moins. On associe toujours la norme descriptive à une **approbation** (« Bravo, vous faites partie des familles qui… »).

Exemple – Le parc de la forêt pétrifiée (Cialdini, 2003)

Dans un parc national américain, des visiteurs emportaient des morceaux de bois fossilisé. Un panneau indiquant que « de nombreux visiteurs ont emporté du bois pétrifié » (norme descriptive négative) a été associé à **7,92 %** de vols dans la zone test, contre **1,67 %** avec un panneau demandant simplement de ne pas emporter de bois (norme injonctive). **Leçon** : un message qui insiste sur le fait que « beaucoup de gens font le mauvais choix » rend ce choix normal. Les campagnes qui répètent que « la majorité des jeunes ne mangent

pas assez de fruits » risquent le même effet.

Méthode pas à pas – Construire un message fondé sur les normes sociales

1. Mesurer la pratique réelle du public (enquête, chapitre 18) et la **norme perçue** (« Selon vous, combien d'élèves de votre classe boivent de l'eau à la récréation ? »).
2. Repérer l'écart : le public surestime souvent les comportements défavorables de ses pairs.
3. Diffuser la pratique **réelle et favorable** (« 7 élèves sur 10 de ce collège boivent de l'eau à la récréation »), avec une source.
4. Ajouter une **approbation** et un moyen d'agir (« Des fontaines sont à votre disposition dans la cour »).
5. Évaluer : la norme perçue et la pratique ont-elles changé ?

À vous de jouer – Exercice d'application 3.29

Dans un lycée, une enquête montre que 62 % des élèves prennent un petit-déjeuner tous les jours, mais que les élèves pensent en moyenne que seulement 30 % de leurs camarades le font. Une affiche est en préparation : « Près de 4 lycéens sur 10 ne prennent pas de petit-déjeuner ! ». a) Quel est le risque de cette affiche ? b) Proposez un autre message. c) Quel indicateur suivre pour évaluer la campagne ?

Corrigé

a) Elle met en avant une norme descriptive **défavorable** (38 % sans petit-déjeuner) et renforce la fausse croyance que sauter le petit-déjeuner est courant : risque d'effet boomerang. **b)** « 6 lycéens sur 10 commencent la journée par un petit-déjeuner. Et vous ? Des idées rapides au foyer du lycée » (norme réelle, favorable, avec un moyen d'agir). **c)** La **norme perçue** (pourcentage estimé de camarades qui prennent un petit-déjeuner, qui devrait se rapprocher de 62 %) et la **pratique déclarée** avant et après la campagne.

3.4.3 L'influence des réseaux sociaux

Les réseaux sociaux participent désormais à la socialisation alimentaire des jeunes : influenceurs promouvant des produits ou des régimes, images corporelles retouchées, défis alimentaires. Développer la **pensée critique** (CPS) et l'**éducation aux médias** fait partie de l'éducation pour la santé. Le diététicien, lorsqu'il communique lui-même sur les réseaux, veille à son **identité numérique** et à l'indépendance de ses messages (chapitre 15).

À retenir – Ce que dit la loi française

- Depuis le **1er octobre 2017** (décret n° 2017-738 du 4 mai 2017), les photographies publicitaires dont la silhouette d'un mannequin a été modifiée par logiciel doivent porter la mention « **photographie retouchée** ».
- La **loi n° 2023-451 du 9 juin 2023** encadre l'influence commerciale sur les réseaux sociaux : l'influenceur doit signaler clairement le partenariat (« publicité » ou « collaboration commerciale ») et indiquer « **image retouchée** » ou « **image virtuelle** » quand un visage ou une silhouette ont été modifiés ou créés par un logiciel. Elle interdit notamment la promotion de la chirurgie esthétique et de pratiques qui détournent des soins.

Mécanisme psychosocial	Sur les réseaux sociaux	Ce que l'on peut travailler en atelier
Comparaison sociale (Festinger, 1954)	On se compare à des images sélectionnées, retouchées et filtrées	Comparer une photo « avant » et « après » retouche ; parler de mise en scène
Identification au modèle (Bandura)	L'influenceur paraît proche et sincère, comme un ami	Repérer les partenariats commerciaux et les codes promotionnels

Mécanisme psychosocial	Sur les réseaux sociaux	Ce que l'on peut travailler en atelier
Preuve sociale	Nombre de « j'aime » et de vues	Rappeler que la popularité ne prouve pas la véracité
Algorithme et bulle	Plus on regarde des contenus « minceur », plus on en reçoit	Montrer comment varier son fil, se désabonner, signaler
Biais de confirmation	On croit ce qui conforte nos idées	Vérifier une information sur deux sources fiables (chapitre 19)

Méthode pas à pas – Analyser une publication d'influenceur avec des adolescents

1. **Qui parle ?** Un professionnel de santé, une marque, un particulier ? A-t-il un intérêt commercial ?
2. **Que vend-on ?** Un produit, un régime, un mode de vie, une image du corps ?
3. **Quelles preuves ?** Une étude citée, un avant-après, un témoignage unique ?
4. **Quelles émotions ?** Envie, peur de manquer, culpabilité, admiration ?
5. **Qu'est-ce qui est absent ?** Le prix, les effets indésirables, la retouche, le sponsoring ?
6. **Qu'est-ce que j'en fais ?** Partager, ignorer, vérifier, en parler ?

À vous de jouer – Exercice d'application 3.30

Une influenceuse suivie par 400 000 abonnés publie une vidéo « Ma détox 3 jours aux jus pour un ventre plat », avec un code promo pour une marque de jus et une photo d'elle avant et après. a) Repérez trois mécanismes psychosociaux mis en jeu. b) Quelles obligations légales doit-elle respecter ? c) Proposez une activité de 20 minutes avec des élèves de seconde.

Corrigé

a) Identification au modèle (proximité, mise en scène de sa vie), **comparaison sociale** (photo avant-après, idéal du « ventre plat »), **preuve sociale** (400 000 abonnés). **b)** Indiquer clairement le partenariat (« publicité » ou « collaboration commerciale ») et la mention « image retouchée » si la photo a été modifiée (loi du 9 juin 2023). **c)** En petits groupes, les élèves appliquent la grille en six questions à la vidéo, puis comparent le prix de la cure à celui de fruits frais et d'eau ; la mise en commun porte sur le message « pour un ventre plat » (aucune base scientifique, corps idéal unique) et sur ce que l'on peut faire (ne pas partager, signaler, en parler).

3.4.4 La pair-éducation et les personnes relais

La **pair-éducation** consiste à confier une partie de l'action éducative à des personnes **du même groupe** que le public (âge, situation, culture) : lycéens ambassadeurs, mamans relais, étudiants relais santé, médiateurs pairs. Elle s'appuie sur la crédibilité et la proximité des pairs (normes sociales, identification) et favorise la participation. Ses conditions de réussite : recrutement volontaire, **formation** des pairs (contenus et posture), accompagnement régulier par un professionnel, reconnaissance (attestation, valorisation), limites claires (le pair n'est pas un professionnel de santé et oriente).

Méthode pas à pas – Monter un projet de pair-éducation en nutrition

1. **Définir le rôle des pairs** : informer ? animer un stand ? accompagner un groupe ? Le rôle reste limité et clair.
2. **Recruter** des volontaires, reconnus par le groupe (et pas seulement les « bons élèves »), avec l'accord des parents s'ils sont mineurs.
3. **Former** sur quelques messages simples, sur la posture (écoute, non-jugement, confidentialité) et sur les limites : savoir orienter vers un adulte ou un professionnel.

4. **Coconstruire** les outils avec les pairs : ils connaissent les codes et le langage du groupe.
5. **Accompagner** : temps de retour réguliers, soutien en cas de difficulté.
6. **Reconnaître** : attestation, valorisation dans le parcours scolaire ou professionnel, rétribution si c'est prévu.
7. **Évaluer** : nombre de pairs formés, actions réalisées, perception du public, effets sur les pairs eux-mêmes (estime de soi, compétences).

Atout de la pair-éducation	Limite ou risque	Réponse
Crédibilité et proximité culturelle	Diffusion de messages inexacts	Formation, supports validés, relecture
Langage adapté	Pression sur le pair, qui devient « le spécialiste »	Rôle limité, soutien d'un professionnel
Effet sur les normes du groupe	Recrutement biaisé (toujours les mêmes)	Recrutement ouvert, diversité des profils
Bénéfices pour les pairs eux-mêmes	Épuisement, départs	Reconnaissance, rotation, binômes

À vous de jouer – Exercice d'application 3.31

Une mission locale veut former 6 jeunes « ambassadeurs de l'alimentation » parmi les jeunes accompagnés. a) Expliquez pourquoi des pairs peuvent être plus efficaces qu'un professionnel, en citant deux notions du chapitre. b) Donnez trois contenus de leur formation. c) Citez deux limites et la façon de les prévenir.

Corrigé

a) Les pairs appartiennent au **groupe de référence** des jeunes : l'**identification** et l'apprentissage par **observation** (Bandura) sont plus forts ; ils font évoluer les **normes** du groupe de l'intérieur ; leur message ne déclenche pas la **menace identitaire** que peut provoquer un discours d'« expert ». **b)** Quelques messages simples sur les repas à petit budget ; l'écoute active (questions ouvertes, reformulation) ; les limites de leur rôle et les adresses vers lesquelles orienter (infirmière, médecin, aide alimentaire). **c)** Messages inexacts : formation et supports validés par le diététicien ; surcharge ou isolement des ambassadeurs : binômes, réunion mensuelle avec un professionnel, reconnaissance (attestation de compétences).

3.4.5 La motivation des enfants et des adolescents

Chez l'**enfant**, l'imitation des adultes et des pairs, l'exposition répétée, le jeu et le plaisir sensoriel priment sur l'information ; les récompenses alimentaires et la pression (« finis ton assiette ») sont contre-productives. Chez l'**adolescent**, la recherche d'**autonomie**, l'appartenance au groupe et l'image de soi dominent : les messages de santé à long terme le touchent peu ; on mise sur l'autonomie (choisir, cuisiner seul), la critique du marketing (« ne pas se faire manipuler »), la performance sportive ou l'énergie, et la participation des jeunes à la conception de l'action.

Le modèle du **partage des responsabilités** d'Ellyn Satter (le parent décide quoi, quand et où ; l'enfant décide s'il mange et combien) est présenté au chapitre 4 (section 4.3.9). La psychologie sociale explique pourquoi certaines stratégies parentales très répandues produisent l'effet inverse de celui recherché : elles agissent sur la **motivation** de l'enfant et sur le **sens** qu'il donne aux aliments.

Stratégie parentale fréquente	Effet probable	Alternative
« Finis ton assiette. »	Apprend à ignorer la sensation de rassasiement	« Tu as encore faim ? » ; servir de petites portions, se resservir si besoin
« Si tu manges tes légumes, tu auras un dessert. »	Le légume devient une corvée, le dessert une récompense	Servir le dessert prévu sans condition ; proposer le légume régulièrement

Stratégie parentale fréquente	Effet probable	Alternative
« Tu ne sortiras pas de table tant que… »	Associe le repas à la contrainte et à la colère	Repas d'une durée raisonnable, sans conflit
Interdire totalement les sucreries	Augmente l'envie et la consommation quand l'aliment est disponible	Les intégrer de façon prévisible (au goûter du mercredi)
Laisser l'enfant choisir tout son repas	Répertoire restreint, conflits	Proposer un choix limité (« carottes ou haricots ? »)

Lien diététique – L'adolescent, entre autonomie et appartenance

Avec les adolescents, on transforme le besoin d'autonomie en levier : leur confier un vrai **rôle** (choisir et cuisiner le repas de la classe, gérer un budget), leur donner des arguments pour **ne pas se faire manipuler** par le marketing, parler des bénéfices **immédiats** (énergie, sport, concentration) plutôt que de la santé dans trente ans, et les associer à la **conception** des actions qui leur sont destinées. On évite toute référence au poids et toute moralisation.

À vous de jouer – Exercice d'application 3.32

Au cours d'un atelier parents-enfants, une mère dit : « Mon fils de 5 ans ne mange rien à table, alors je lui promets des bonbons s'il finit ses haricots. » a) Analysez cette stratégie avec deux notions du chapitre. b) Proposez trois conseils fondés sur le partage des responsabilités. c) Quelle posture adoptez-vous pour formuler ces conseils ?

Corrigé

a) La récompense crée une **motivation extrinsèque** et un effet de **surjustification** : l'enfant apprend que les haricots sont une corvée et les bonbons un trésor ; « finir » l'assiette l'éloigne de ses sensations de **rassasiement**. **b)** Servir de petites portions et laisser l'enfant décider combien il mange ; proposer les haricots régulièrement, sans pression, en en mangeant soi-même (**exposition répétée**, modélisation) ; servir le dessert prévu sans condition et ne pas utiliser les bonbons comme récompense. **c)** Une posture d'**écoute** et de non-jugement : reformuler d'abord la difficulté (« ces repas sont fatigants pour vous »), demander la permission avant d'informer, et s'appuyer sur ce que la mère réussit déjà.

3.4.6 Les émotions dans l'apprentissage

Les émotions **positives** (plaisir, fierté, convivialité) favorisent la mémorisation et l'envie de refaire ; la **peur** et la **honte** peuvent provoquer l'évitement (ne plus venir, ne plus parler). Les messages fondés sur la peur ne sont efficaces que si la personne se sent capable d'agir (sentiment d'efficacité) ; en nutrition, ils sont à éviter auprès des publics vulnérables (stigmatisation, chapitre 6).

Définition – Le modèle des processus parallèles étendu (Witte, 1992)

Face à un message qui fait peur, la personne évalue d'abord la **menace** (est-ce grave ? suis-je concerné ?), puis son **efficacité** (la solution proposée marche-t-elle ? suis-je capable de l'appliquer ?).

- Menace **forte** et efficacité **forte** : la personne cherche à **contrôler le danger** (elle change).
- Menace **forte** et efficacité **faible** : elle cherche à **contrôler sa peur** (déni, évitement, rejet du message, « de toute façon, on mourra tous de quelque chose »).
- Menace **faible** : le message est ignoré.

Conséquence : un message qui fait peur doit toujours être accompagné d'une solution concrète, à la portée de la personne. En nutrition, auprès des publics vulnérables, on préfère les messages positifs.

3.4.7 Précarité alimentaire : honte, dignité et pouvoir d'agir

La précarité ne se réduit pas au manque d'argent : elle a des effets **psychosociaux** qui conditionnent la participation aux actions de prévention.

Effet psychosocial	Manifestation	Conséquence pour l'action
Honte et peur du jugement	Ne pas oser dire qu'on manque, cacher le recours à l'aide alimentaire	Accueil discret, non-jugement, pas de questions intrusives devant le groupe
Stigmatisation	Être vu comme « assisté », « mauvais gestionnaire »	Valoriser les compétences (gérer avec peu est une compétence)
Charge mentale et stress	Préoccupations multiples (logement, dettes), moins de disponibilité pour planifier	Actions courtes, concrètes, peu de prérequis
Préférence pour le présent	Priorité à ce qui est sûr et rassasiant aujourd'hui	Recettes nourrissantes et appréciées, résultats immédiats
Non-recours aux droits	Ne pas demander une aide à laquelle on a droit (complexité, honte, méconnaissance)	Informer sur les droits, orienter, accompagner les démarches avec les travailleurs sociaux
Faible pouvoir d'agir	Sentiment de ne rien pouvoir changer	Participation aux décisions, choix, valorisation des réussites

Lien diététique – Les dispositifs qui préservent la dignité

Les **épiceries solidaires**, où l'on choisit ses produits et où l'on paie une petite participation, sont souvent préférées aux colis imposés, car elles respectent l'**autonomie** et la dignité. Les ateliers culinaires y trouvent toute leur place : ils partent des produits réellement disponibles et valorisent les savoir-faire des personnes.

3.4.8 Le numérique dans l'accompagnement du changement

Applications de suivi alimentaire, objets connectés, groupes de discussion en ligne, vidéos de recettes : le numérique offre de nouveaux outils pour accompagner le changement, avec des atouts et des risques.

Outil	Mécanisme psychosocial	Atout	Risque ou limite
Application de suivi des repas	Auto-surveillance, rétroaction	Prise de conscience, suivi des objectifs	Comptage obsessionnel, culpabilité, données personnelles de santé
Défis et badges (« ludification »)	Récompense, compétition	Motivation à court terme	Motivation externe, abandon rapide
Groupe de messagerie d'un atelier	Soutien social, normes du groupe	Lien entre les séances, partage de photos de plats	Confidentialité, horaires, exclusion des personnes peu équipées
Vidéos de recettes courtes	Modélisation, apprentissage par observation	Accessibles, visuelles, multilingues possibles	Recettes parfois peu réalistes, marketing caché
Téléconsultation de groupe	Accès facilité	Moins de déplacements	Fracture numérique, moindre convivialité

Attention – Numérique et inégalités

Une partie de la population n'a pas d'équipement adapté, de connexion suffisante ou de compétences numériques (illectronisme, chapitre 15). Un dispositif uniquement numérique creuse les inégalités sociales de santé. On propose toujours une alternative non numérique, et l'on respecte les règles de protection des données de santé (RGPD, chapitre 20).

À vous de jouer – Exercice d'application 3.33

Pour prolonger un cycle d'ateliers avec des familles d'un quartier prioritaire, une animatrice veut créer un groupe de messagerie et proposer une application qui attribue des points à chaque repas « équilibré ». a) Quels mécanismes psychosociaux sont mobilisés par chaque outil ? b) Citez deux risques pour chacun. c) Que proposez-vous pour les familles qui n'ont pas de smartphone ?

Corrigé

a) Le groupe de messagerie mobilise le **soutien social** et les **normes** du groupe ; l'application mobilise l'**auto-surveillance** et la **récompense**. **b)** Groupe : diffusion d'informations personnelles (confidentialité) et sollicitations à toute heure ou exclusion de ceux qui sont moins actifs ; application : motivation **externe** qui s'arrête avec les points, culpabilité ou comptage excessif, collecte de données de santé par un éditeur privé. **c)** Une rencontre mensuelle au centre social, des fiches-recettes papier et un affichage dans le hall, pour que personne ne soit exclu.

3.4.9 Les personnes âgées : vieillissement, isolement et plaisir de manger

Avec l'âge, les dimensions psychosociales de l'alimentation prennent une place majeure. Le repas structure la journée, maintient le lien social et l'identité ; sa perte de sens est un facteur de **dénutrition**, qui touche une part importante des personnes âgées vivant à domicile et davantage encore en établissement (HAS et FFAMCO, recommandations sur la dénutrition de la personne âgée, 2021).

Facteur psychosocial	Effet sur l'alimentation	Levier
Veuvage, deuil	Perte de l'envie de cuisiner « pour soi seul », perte du rôle de cuisinier ou absence de savoir-faire chez celui qui ne cuisinait pas	Repas partagés, ateliers « cuisiner pour une personne », soutien et écoute
Isolement social	Repas sautés ou réduits, monotonie	Restaurants seniors, portage de repas avec visite, activités collectives
Dépression	Perte d'appétit et de plaisir	Repérage et orientation vers le médecin
Perte d'autonomie	Difficulté à faire les courses, à porter, à cuisiner	Aide à domicile, livraison, ustensiles adaptés
Représentations	« À mon âge, on n'a plus besoin de manger beaucoup » ; peur du cholestérol ou du sucre héritée de régimes anciens	Information sur les besoins, levée des régimes restrictifs inutiles (avis médical)
Identité et habitudes	Attachement aux plats de toujours, refus de la nouveauté	Partir des plats familiers, valoriser l'expérience culinaire (réminiscence)

Lien diététique – L'atelier de réminiscence culinaire

Un atelier de **réminiscence** invite les personnes âgées à évoquer les plats de leur enfance, les fêtes, les marchés d'autrefois, à partir d'objets, de photos ou d'odeurs, puis à réaliser ensemble une recette d'antan, éventuellement enrichie (fromage, œuf, lait en poudre). Il mobilise l'**identité**, la **mémoire** et le **sentiment de compétence** (« je sais faire »), favorise le lien entre les participants et redonne du sens au repas. Il convient aussi aux personnes ayant des troubles cognitifs légers, avec un rythme adapté.

Attention – Âgisme

Les stéréotypes liés à l'âge (« les vieux ne changent pas », « ils ne comprennent rien au numérique ») sont une forme de **stigmatisation**. Ils conduisent à infantiliser (tutoiement, voix forte, « ma petite dame ») et à moins proposer d'activités. Les personnes âgées peuvent apprendre et changer : on s'adresse à elles comme à

des adultes, on respecte leurs choix et leur rythme.

3.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3

Pour aller plus loin – niveau L3 – La théorie de l'identité sociale (Tajfel et Turner, 1979)

Les individus cherchent une identité sociale positive en se comparant favorablement à d'autres groupes (favoritisme intra-groupe). Les expériences du « paradigme des groupes minimaux » ont montré qu'une catégorisation arbitraire suffit à créer une préférence pour son groupe. En alimentation, les pratiques (végétarisme, « manger local », cuisine d'origine) peuvent devenir des marqueurs de frontière entre groupes ; un message perçu comme venant d'un autre groupe (« les experts », « les bobos ») peut être rejeté pour des raisons identitaires plus que rationnelles.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Habitus et goûts de classe (Bourdieu, 1979)

Pour Pierre Bourdieu, l'**habitus** est un système de dispositions durables, acquis par la socialisation, qui oriente les goûts et les pratiques. Le « goût de nécessité » des classes populaires (aliments nourrissants, abondants, conviviaux) s'oppose au « goût de liberté » des classes favorisées (légèreté, forme, distinction). Ces analyses invitent à ne pas imposer aux classes populaires des normes nutritionnelles qui reflètent les goûts des classes favorisées, mais à partir de leurs propres valeurs (convivialité, générosité du repas).

Pour aller plus loin – niveau L3 – Le paradoxe de l'omnivore et la gastro-anomie (Fischler, 1990)

Le mangeur humain est pris entre **néophilie** (besoin de variété) et **néophobie** (méfiance) ; les cuisines et les règles culturelles résolvent ce paradoxe en encadrant ce qui est mangeable. Dans les sociétés modernes, l'affaiblissement des règles collectives (repas destructurés, offre surabondante, discours contradictoires des experts, des médias et de l'industrie) produit une **gastro-anomie** : le mangeur, laissé seul juge, devient anxieux. Le diététicien peut contribuer à **re-socialiser** l'alimentation (repas partagés, transmission culinaire) plutôt qu'à multiplier les injonctions.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Les limites des modèles individuels du changement

Les modèles HBM, transthéorique ou du comportement planifié expliquent une part limitée des comportements (souvent moins de 30 à 40 % de la variance de l'intention et moins encore du comportement réel). Ils sous-estiment les **habitudes** (comportements automatiques déclenchés par le contexte), les **émotions** et les **déterminants sociaux**. Les approches récentes (modèle COM-B de Michie et coll., 2011 : capacité, opportunité, motivation) intègrent explicitement l'environnement (opportunité) et orientent vers des interventions combinant éducation, modification de l'environnement et incitations.

Pour aller plus loin – niveau L3 – L'identité sociale (Tajfel et Turner, 1979)

La théorie de l'**identité sociale** explique que chacun tire une partie de son estime de soi de son appartenance à des **groupes** et tend à favoriser son groupe (favoritisme endogroupe). En alimentation, les pratiques signalent l'appartenance (« chez nous, on mange comme ça ») : un message perçu comme venant d'un groupe extérieur (« les diététiciens des beaux quartiers ») peut être rejeté pour préserver l'identité. D'où l'intérêt des pairs, de la valorisation des cultures d'origine et des recettes construites **avec** les participants.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Goût de nécessité et goût de liberté (Bourdieu, 1979)

Dans *La Distinction* (1979), Pierre Bourdieu montre que les goûts alimentaires sont socialement construits par l'**habitus** : les classes populaires valorisent un **goût de nécessité** (nourriture abondante, consistante, qui « tient au corps », convivialité), les classes favorisées un **goût de liberté** (légèreté, forme, raffinement, santé). Les messages nutritionnels, souvent produits par des professionnels issus des classes moyennes et supérieures, risquent d'imposer implicitement une norme de classe. Le diététicien gagne à reconnaître la légitimité de ces goûts (repas copieux et conviviaux) et à construire l'équilibre **à partir** d'eux.

3.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles

Situation bc1 – Consultation et étape du changement

Un patient diabétique dit : « De toute façon, je n'y arriverai jamais. » Le diététicien repère un faible **sentiment d'efficacité personnelle** et une étape de **contemplation** ; il fixe avec lui un objectif très accessible (expérience de réussite) et utilise les techniques de l'entretien motivationnel.

Situation bc2 – Introduire un nouveau plat en restauration scolaire

Un plat de légumineuses est refusé par les élèves. En s'appuyant sur la néophobie et l'exposition répétée, le diététicien propose de le servir régulièrement en petite quantité, de l'accompagner d'une animation (dégustation, nom attractif, implication d'élèves ambassadeurs) et d'observer le gaspillage sur plusieurs semaines.

Situation bc3 – Atelier avec des adolescents

Lors d'un atelier, des adolescents se moquent d'un camarade en surpoids. L'animateur intervient immédiatement pour rappeler les règles du groupe (respect, non-jugement), puis recentre l'activité sur le plaisir et les compétences, sans parler de poids : il prévient la **stigmatisation** et protège l'estime de soi de chacun.

Situation bc3 – Projet interculturel

Dans un centre d'hébergement, le diététicien conçoit un livret de recettes avec les résidents, à partir des plats de leurs pays adaptés aux produits disponibles : il favorise l'**intégration** (Berry) et l'**action communautaire** (Ottawa).

Situation bc1 – Écoute active en consultation

Un patient répond « oui, mais » à chaque conseil. Le diététicien repère son réflexe correcteur, passe à l'écoute réflective et à la balance décisionnelle ; le patient formule lui-même un premier objectif.

Situation bc3 – Un groupe en turbulence

Lors du 2e atelier d'un cycle pour des salariés, deux participants contestent les repères et se moquent des « recettes de régime ». Le diététicien accueille l'objection, la renvoie au groupe, rappelle le cadre et propose une dégustation comparée : la séance suivante, le groupe fixe ses propres règles.

Méthode 1 – Justifier un choix d'animation par un modèle, à l'oral

À l'oral de l'épreuve E5, le jury demande souvent : « Pourquoi avez-vous choisi cette technique ? » ou « Sur quel modèle vous êtes-vous appuyé ? ». Une réponse qui cite un modèle **sans le relier** au public et à l'action ne convainc pas.

Méthode pas à pas – La réponse en 4 temps

1. Le constat : ce que le diagnostic a montré sur le public (un chiffre, une citation).

2. Le modèle : son nom, son auteur, son année, et la composante qui éclaire le constat.

3. Le choix : la technique ou l'action retenue, et pourquoi elle agit sur cette composante.

4. La preuve : ce qui a été observé ou mesuré pendant ou après l'action.

À l'oral – Exemple de réponse

« Au questionnaire, les 18 parents interrogés trouvaient les légumes secs bons pour la santé, avec un score moyen de 4,2 sur 5, mais seulement 2,1 sur 5 pour l'affirmation "je sais les cuisiner". Selon la théorie du comportement planifié d'Ajzen (1991), c'est le contrôle perçu qui bloquait, pas l'attitude. J'ai donc choisi un atelier où chaque parent cuisinait lui-même un plat, plutôt qu'une présentation des bienfaits des légumineuses : c'est l'expérience de réussite, la source la plus forte du sentiment d'efficacité personnelle selon Bandura. À la fin du cycle, le score "je sais les cuisiner" est passé à 3,8 sur 5, et 11 parents sur 18 ont dit avoir refait une recette chez eux. » (Données de l'exemple fictives.)

Ce que le jury attend – Les erreurs fréquentes

- Réciter un modèle (les six étapes de Prochaska) sans dire à quoi il a servi dans le projet.
- Confondre **attitude** (ce que je pense) et **comportement** (ce que je fais), ou **norme descriptive** et **norme injonctive**.
- Annoncer une action « participative » alors que la séance était un exposé suivi de questions.
- Parler d'« éduquer » ou de « faire prendre conscience » sans dire quelle **compétence** a été travaillée.
- Oublier la **posture** : non-jugement, respect de l'autonomie, absence de stigmatisation.

Méthode 2 – Analyser une situation de groupe en quatre questions

Les sujets proposent souvent un extrait d'échange ou la description d'une séance difficile. Cette grille permet de ne rien oublier.

Question	Notions à mobiliser
1. Où en est le groupe ?	Étapes de Tuckman, rôles de Benne et Sheats, normes du groupe
2. Quelles influences jouent ?	Conformisme, leader, influence minoritaire, normes sociales, identité de groupe
3. Comment l'animateur communique-t-il ?	Attitudes de Porter, écoute active, réflexe correcteur, rapport reflets / questions, style d'animation
4. Que proposer ?	Technique d'animation adaptée, reformulation de la réplique, règle du groupe, suite de la séance

Méthode 3 – Quinze affirmations à corriger avant l'épreuve

À vous de jouer – Vrai ou faux commentés

Pour chaque affirmation, dites si elle est vraie ou fausse et justifiez en une phrase.

1. « Une représentation sociale est une opinion personnelle. »
2. « Le noyau central d'une représentation change facilement. »
3. « Dans l'expérience de Lewin (1943), les conférences ont été plus efficaces que les discussions de groupe. »
4. « Une norme descriptive dit ce que l'on doit faire. »
5. « La dissonance cognitive conduit toujours à changer de comportement. »
6. « Un acte libre et public engage davantage qu'un acte contraint et privé. »
7. « La stigmatisation du poids motive les personnes à maigrir. »
8. « Les compétences psychosociales se développent par une information claire sur la santé. »
9. « La rechute fait partie du modèle de Prochaska et DiClemente. »
10. « Une forte intention garantit le comportement. »
11. « Il faut 21 jours pour créer une habitude. »
12. « 93 % de la communication est non verbale. »
13. « Récompenser un enfant qui goûte un légume augmente durablement son goût pour ce légume. »
14. « Un nudge peut supprimer une option pour orienter le choix. »
15. « Une échelle de Likert mélange des affirmations positives et négatives. »

Corrigé – Vrai ou faux commentés

1. Faux : c'est une connaissance **partagée** par un groupe, construite socialement (Moscovici, 1961).
2. Faux : il est stable et résistant ; ce sont les éléments périphériques qui changent d'abord (Abric).
3. Faux : environ 3 % contre 32 % ; la discussion et la décision de groupe ont été bien plus efficaces.
4. Faux : elle dit ce que **font** les autres ; c'est la norme injonctive qui dit ce qu'il faut faire.
5. Faux : la personne peut aussi changer sa croyance ou ajouter une justification, ce qui est souvent plus facile.
6. Vrai : liberté, caractère public, répétition et coût augmentent l'engagement (Kiesler ; Joule et Beauvois).
7. Faux : elle augmente le stress, l'évitement des soins et l'hyperphagie (Puhl et Heuer, 2009).
8. Faux : elles se développent par des activités **pratiques**, structurées et répétées (critères SAFE).
9. Vrai : elle est considérée comme une étape normale du processus.
10. Faux : il existe un écart intention-comportement ; les plans « si…, alors… » aident à le réduire (Gollwitzer, 1999).
11. Faux : 66 jours en valeur médiane, de 18 à 254 jours selon les personnes (Lally, 2010).
12. Faux : les chiffres de Mehrabian (1967) portent sur l'expression des sentiments dans des conditions très particulières.
13. Faux : la récompense attendue diminue la motivation intrinsèque (Lepper, Greene et Nisbett, 1973 ; Wardle, 2003).
14. Faux : un nudge laisse toutes les options accessibles ; supprimer une option est une restriction.
15. Vrai : cela limite les réponses automatiques ; les affirmations négatives sont inversées avant le calcul.

Mon score	Ce que je fais
14 ou 15 sur 15	Je suis prêt pour les sujets d'entraînement.
10 à 13 sur 15	Je relis les sections des affirmations manquées.
Moins de 10 sur 15	Je reprends les encadrés « À retenir » du chapitre et je refais les points d'étape.

3.7 L'essentiel à retenir

À retenir – Concepts

- **Psychologie** (individu), **sociologie** (groupes, faits sociaux), **anthropologie** (cultures) ; la **psychologie sociale** étudie l'influence des autres sur l'individu.
- Repères : Lévi-Strauss (1964), Bourdieu (1979), **Fischler** (1990 : paradoxe de l'omnivore, incorporation, gastro-anomie), **Poulain** (2002 : espace social alimentaire).
- **Identité** individuelle et sociale (Tajfel et Turner, 1979) ; **socialisation** primaire (famille) et secondaire (école, pairs, travail, médias).
- **Représentations sociales** (Moscovici, 1961 ; noyau central et périphérie, Abric) ; **normes** descriptives et injonctives ; **valeurs** ; **attitudes**.
- **Culture**, **interculturalité** (décentration), **acculturation** spontanée / planifiée (Bastide) ; stratégies de **Berry** (1997) : intégration, assimilation, séparation, marginalisation.

À retenir – Groupe, CPS, changement

- **Lewin (1943)** : la discussion de groupe et la décision collective changent davantage les pratiques (≈ 32 %) que la conférence (≈ 3 %).
- **Conformisme** (Asch), **dissonance cognitive** (Festinger, 1957), **engagement** (Kiesler ; Joule et Beauvois), **stigmatisation** (Goffman, 1963).
- **CPS** (Santé publique France, 2022) : 3 catégories (cognitives, émotionnelles, sociales) × 3 CPS générales.
- **Image corporelle**, insatisfaction corporelle, **émotions** (Ekman), **estime de soi** (Rosenberg), **efficacité personnelle** (Bandura, 1977).
- **Modèles du changement** : HBM ; Prochaska et DiClemente (1983) : précontemplation, contemplation, préparation, action, maintien, rechute ; Ajzen (1991) : attitude, normes subjectives, contrôle perçu → intention → comportement.
- **Néophobie** : maximale de 2 à 6 ans ; 8 à 15 expositions sans pression ; éviter la récompense alimentaire.

À retenir – Compléments : communication, motivation, animation, mesure

- **Palo Alto** : on ne peut pas ne pas communiquer ; contenu et relation. **Mehrabian** : pas de « 93 % de non-verbal » en général.
- **Écoute active** (Rogers) : empathie, acceptation, congruence ; questions ouvertes, reformulation, reflets, silences, synthèse ; **Porter** : 6 attitudes, privilégier la compréhension.
- **Entretien motivationnel** (Miller et Rollnick) : partenariat, acceptation, compassion, évocation ; ambivalence ; réflexe correcteur ; OuVER ; **balance décisionnelle**.
- **Groupe** : Tuckman (formation, turbulence, normalisation, production, dissolution) ; rôles (Benne et Sheats) ; styles (Lewin, Lippitt et White : démocratique > autoritaire > laisser-faire).
- **Motivation** : autodétermination (autonomie, compétence, affiliation) ; éviter les récompenses alimentaires ; **biais** (présent, cadrage, halo, défaut, ancrage, optimisme, preuve sociale).
- **Mesure** : Likert (inverser les items négatifs : 6 − réponse) ; évocation hiérarchisée et analyse prototypique (fréquence × rang moyen ; noyau central probable).

3.8 Entraînement

3.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses)

QCM 1 – La psychologie sociale étudie :

a) l'influence des autres sur les pensées et les comportements de l'individu **b)** uniquement les maladies mentales **c)** les interactions entre l'individu et le groupe **d)** la composition des aliments

QCM 2 – La socialisation primaire se fait principalement :

a) au travail **b)** dans la famille **c)** par les réseaux sociaux à l'âge adulte **d)** pendant l'enfance

QCM 3 – Le « paradoxe de l'omnivore » a été décrit par :

a) Claude Fischler **b)** Kurt Lewin **c)** Albert Bandura **d)** John Berry

QCM 4 – Une représentation sociale :

a) est une connaissance socialement élaborée et partagée **b)** comporte un noyau central stable **c)** est toujours fausse **d)** oriente les comportements

QCM 5 – Dans le modèle de Berry, conserver ses pratiques d'origine tout en adoptant celles du pays d'accueil correspond à :

a) l'assimilation **b)** l'intégration **c)** la séparation **d)** la marginalisation

QCM 6 – Dans l'expérience de Lewin (1943), le changement le plus important a été obtenu par :

a) une conférence d'expert **b)** une discussion de groupe suivie d'une décision collective **c)** une affiche **d)** une sanction

QCM 7 – La dissonance cognitive :

a) est un inconfort lié à des cognitions contradictoires **b)** peut conduire à rationaliser plutôt qu'à changer **c)** est renforcée par des messages culpabilisants **d)** a été décrite par Festinger

QCM 8 – Les compétences psychosociales selon Santé publique France (2022) sont classées en :

a) cognitives, émotionnelles, sociales **b)** physiques, mentales, sociales **c)** primaires, secondaires, tertiaires **d)** individuelles et collectives uniquement

QCM 9 – Réguler ses émotions est une CPS :

a) cognitive **b)** émotionnelle **c)** sociale **d)** physique

QCM 10 – Dans le modèle de Prochaska et DiClemente, une personne qui a changé de comportement depuis 3 mois est au stade :

a) de contemplation **b)** de préparation **c)** d'action **d)** de maintien

QCM 11 – Selon Ajzen, l'intention dépend :

a) de l'attitude **b)** des normes subjectives **c)** du contrôle comportemental perçu **d)** de l'IMC

QCM 12 – La source la plus puissante du sentiment d'efficacité personnelle est :

a) la persuasion verbale **b)** l'expérience de réussite personnelle **c)** la peur **d)** la sanction

QCM 13 – Face à la néophobie d'un enfant de 4 ans, il est recommandé :

a) de forcer à finir l'assiette **b)** de proposer l'aliment à plusieurs reprises sans pression **c)** de promettre un dessert en récompense **d)** de manger soi-même l'aliment devant l'enfant

QCM 14 – La stigmatisation du poids :

a) motive les personnes à perdre du poids **b)** augmente le stress et l'évitement des soins **c)** est un facteur de risque de comportements alimentaires désordonnés **d)** a été théorisée sous le nom de stigmate par Goffman

QCM 15 – Une norme descriptive :

a) décrit ce que font la plupart des gens **b)** dit ce qu'il faut faire **c)** peut normaliser un comportement à éviter si elle est mal utilisée **d)** est toujours inefficace

Corrigé – Corrigé expliqué des QCM

1. a, c. 2. **b, d**. 3. **a** (*L'Homnivore*, 1990). 4. **a, b, d** : une représentation n'est pas « fausse », elle a une cohérence pour le groupe. 5. **b**. 6. **b** (≈ 32 % contre ≈ 3 %). 7. **a, b, c, d**. 8. **a**. 9. **b**. 10. **c** (moins de 6 mois). 11. **a, b, c**. 12. **b** (Bandura). 13. **b, d** : la pression et la récompense sont contre-productives. 14. **b, c, d** : la stigmatisation ne motive pas, elle nuit. 15. **a, c**.

QCM 16 – Parmi les attitudes de Porter, celle qui favorise le plus l'expression est :

a) l'évaluation **b)** la solution **c)** la compréhension **d)** l'enquête

QCM 17 – L'esprit de l'entretien motivationnel comprend :

a) le partenariat **b)** l'évocation **c)** la confrontation **d)** l'acceptation

QCM 18 – Selon Tuckman, la phase où apparaissent les désaccords est :

a) la formation **b)** la turbulence **c)** la normalisation **d)** la production

QCM 19 – Dans la théorie de l'autodétermination, les trois besoins fondamentaux sont :

a) autonomie **b)** compétence **c)** affiliation **d)** récompense

QCM 20 – Dans une échelle de Likert de 1 à 5, la réponse 4 à un item négatif devient après inversion :

a) 1 **b)** 2 **c)** 4 **d)** 5

Corrigé – Corrigé expliqué des QCM complémentaires

16. c. 17. **a, b, d**. 18. **b**. 19. **a, b, c**. 20. **b** (6 − 4 = 2).

3.8.2 Exercices

À vous de jouer – Exercice 1 – Schéma à légender : les stratégies d'acculturation

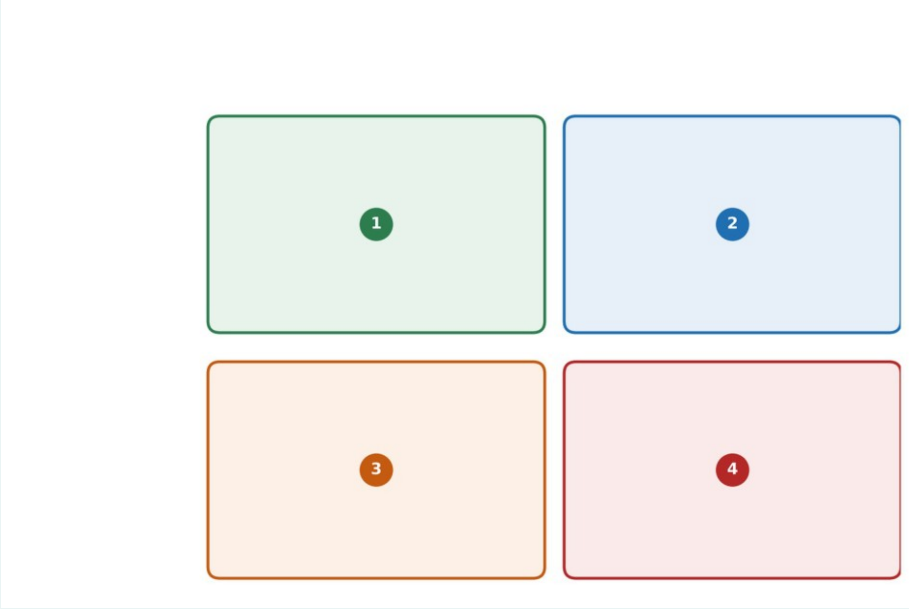


Figure 3.10 – Schéma à légender

Nommez le modèle, l'auteur et la date ; légendez les cases 1 à 4 et donnez un exemple alimentaire pour

chacune.

Corrigé

Stratégies d'acculturation de **John Berry (1997)**. 1. **Intégration** : une famille marocaine cuisine le tajine et adopte la ratatouille. 2. **Assimilation** : abandon des plats d'origine au profit de plats industriels du pays d'accueil. 3. **Séparation** : maintien exclusif des plats d'origine, achats uniquement dans des épiceries communautaires. 4. **Marginalisation** : perte des repères culinaires d'origine sans adoption de nouveaux, alimentation désorganisée (repas sautés, produits transformés).

À vous de jouer – Exercice 2 – Schéma à légender : les étapes du changement

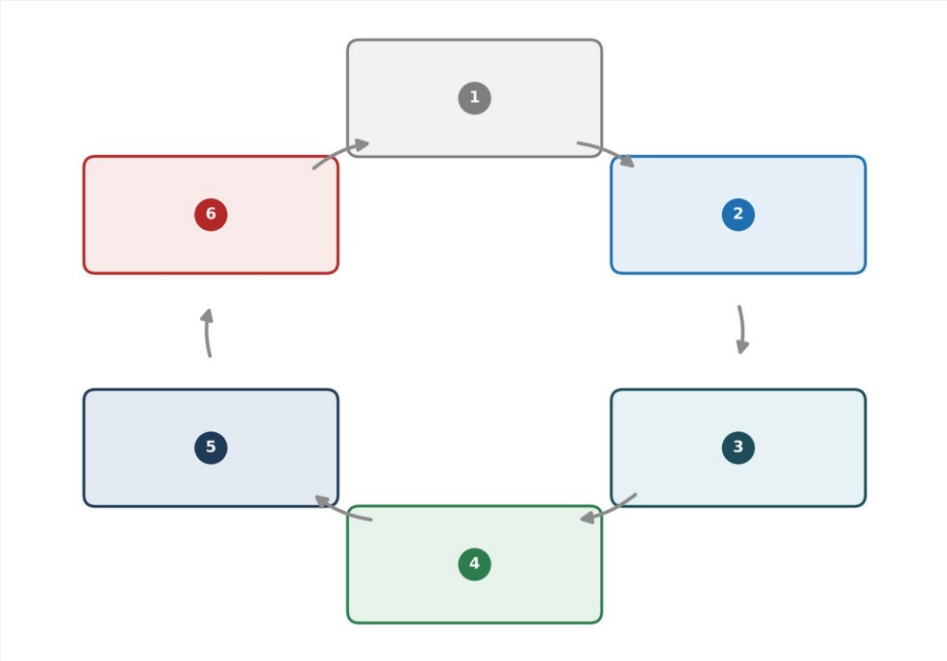


Figure 3.11 – Schéma à légender

Légendez les étapes 1 à 6 et proposez pour chacune une attitude de l'éducateur.

Corrigé

1. Précontemplation : informer sans braquer, susciter la curiosité. 2. **Contemplation** : explorer l'ambivalence (avantages / inconvénients). 3. **Préparation** : aider à fixer un objectif concret. 4. **Action** : soutenir, valoriser, résoudre les obstacles. 5. **Maintien** : prévenir la rechute, varier. 6. **Rechute** : dédramatiser, analyser, relancer le cycle.

À vous de jouer – Exercice 3 – Classer des CPS

Classez dans les trois catégories : a) dire non à un soda proposé par un ami ; b) repérer qu'on mange par ennui ; c) analyser une publicité ; d) gérer le stress d'un examen sans grignoter ; e) cuisiner en équipe ; f) choisir un menu équilibré dans un budget.

Corrigé

Cognitives : c) pensée critique ; f) prise de décision. **Émotionnelles** : b) conscience de ses émotions ; d) gestion du stress. **Sociales** : a) communication constructive (affirmation de soi) ; e) relations constructives

(coopération).

À vous de jouer – Exercice 4 – Identifier des représentations

Voici des propos recueillis lors d'un photolangage : « Le bio, c'est pour les riches » ; « Un bon repas, c'est avec de la viande » ; « Les surgelés, c'est mauvais » ; « Le pain, ça fait grossir ». Pour chacune, proposez une façon de la faire évoluer sans la disqualifier.

Corrigé

- « Le bio, c'est pour les riches » : reconnaître que certains produits bio sont plus chers ; montrer que des produits bio de saison ou en vrac (pommes, lentilles) sont abordables ; calculer le coût par portion.
- « Un bon repas, c'est avec de la viande » : valoriser la convivialité et la générosité du repas (noyau), proposer un plat sans viande copieux et apprécié (périphérie), puis parler de complémentarité des protéines.
- « Les surgelés, c'est mauvais » : distinguer légumes surgelés nature (intéressants nutritionnellement et économiquement) et plats préparés ; faire goûter.
- « Le pain fait grossir » : rappeler que le pain, surtout complet, est un féculent recommandé ; ce sont surtout les quantités et ce qu'on met dessus qui comptent.

À vous de jouer – Exercice 5 – Appliquer la théorie d'Ajzen

Mme K. pense que les légumes secs sont bons pour la santé (attitude positive), mais son mari dit qu'« un repas sans viande n'est pas un repas » et elle ne sait pas les cuisiner. Analysez avec le modèle d'Ajzen et proposez une action pour chaque composante.

Corrigé

Attitude : favorable → la renforcer (goût, économie). **Normes subjectives** : défavorables (le mari) → inviter le conjoint à la dégustation, proposer des plats mixtes (légumineuses + un peu de viande). **Contrôle perçu** : faible (ne sait pas cuisiner) → atelier pratique, recette simple, conserves de légumineuses pour gagner du temps. L'intention, aujourd'hui faible malgré l'attitude positive, augmentera si les normes et le contrôle perçu deviennent favorables.

À vous de jouer – Exercice 6 – Repérer les erreurs d'animation

Dans un atelier pour enfants, l'animatrice dit : « Celui qui ne goûte pas les épinards n'aura pas de gâteau », puis « Regardez Lucas, il est trop gros, il doit faire attention ». Identifiez les erreurs et proposez une autre formulation.

Corrigé

Erreur 1 : **récompense alimentaire** et pression, qui dévalorisent les épinards et survalorisent le gâteau. Reformulation : « Qui veut découvrir la couleur, l'odeur et le goût des épinards ? On a le droit de ne pas aimer, on peut juste toucher ou sentir. » Erreur 2 : **stigmatisation** publique d'un enfant, atteinte à l'estime de soi et au respect de la vie privée. Il ne faut jamais commenter le corps d'un participant ; la règle de respect s'applique à tous.

À vous de jouer – Exercice 7 – Adapter une action au public

Une même action « découvrir les légumineuses » doit être proposée à : a) des enfants de 5 ans ; b) des adolescents de 15 ans ; c) des résidents d'EHPAD. Proposez une adaptation pour chacun.

Corrigé

a) Jeu sensoriel (toucher, trier des lentilles de couleurs), fabrication d'un houmous coloré, exposition répétée, parents invités. b) Défi « burger végétal » en équipes, vidéo réalisée par les élèves, arguments planète et sport, respect de leurs choix. c) Atelier réminiscence (« les lentilles de mon enfance »), velouté de lentilles à texture adaptée, repas partagé, rythme lent.

À vous de jouer – Exercice 8 – Normes descriptives

Un collège veut afficher : « 65 % des élèves ne prennent pas de petit-déjeuner ! ». Est-ce une bonne idée ? Proposez une alternative.

Corrigé

Non : ce message présente le comportement à éviter comme **majoritaire** et risque de le normaliser (effet boomerang). Si 35 % des élèves prennent un petit-déjeuner, on peut valoriser une norme favorable vraie sur un autre aspect, par exemple « 8 élèves sur 10 boivent de l'eau à la récréation », ou une norme dynamique : « de plus en plus d'élèves prennent un petit-déjeuner » (si c'est vrai), accompagnée d'actions concrètes (petit-déjeuner au collège).

À vous de jouer – Exercice 9 – Analyser une situation de dissonance

Un salarié dit : « Je sais que je mange trop de sucre, mais avec mon travail, je n'ai pas le choix, et puis il faut bien se faire plaisir. » Identifiez la dissonance et la stratégie de réduction utilisée. Comment réagir ?

Corrigé

Dissonance entre « je mange trop de sucre » et « le sucre en excès est mauvais pour la santé ». Stratégie : **rationalisation** (justification par le travail et le plaisir) plutôt que changement. Réaction : ne pas culpabiliser ; reconnaître la contrainte et le besoin de plaisir ; explorer avec lui des solutions compatibles (collation plaisir moins sucrée, aménagement de la pause) ; renforcer son sentiment d'efficacité par un petit objectif.

À vous de jouer – Exercice 10 – Recueillir des représentations

Rédigez la consigne et le déroulé d'un photolangage de 30 minutes pour un groupe de 8 parents sur le thème « bien manger pour ma famille ».

Corrigé

Préparation : 40 photos variées (repas, aliments, scènes de repas, marché, cuisine, fast-food, fête). **Consigne** : « Choisissez une photo qui représente pour vous "bien manger pour ma famille", et une photo qui représente ce qui est difficile. » **Déroulé** : 5 min de choix en silence ; 20 min de tour de table (chacun explique, l'animateur reformule sans juger, note les mots-clés) ; 5 min de synthèse (regroupement des idées : plaisir, santé, prix, temps, enfants). **Règles** : bienveillance, droit de ne pas parler, confidentialité. **Exploitation** : les thèmes deviennent des objectifs d'atelier.

3.8.3 Questions de réflexion

À vous de jouer – Question 1

En quoi votre propre culture alimentaire peut-elle influencer votre pratique professionnelle ?

Corrigé

Chacun juge l'alimentation des autres à travers ses propres normes (horaires, plats, valeurs) : risque d'**ethnocentrisme** (considérer sa culture comme la référence). La **décentration** consiste à prendre conscience de ses propres valeurs et préjugés (par exemple, penser qu'un repas « normal » comporte entrée, plat, dessert) pour accueillir d'autres pratiques sans les juger, en ne retenant que les critères nutritionnels réellement importants. Le guide du BTS invite explicitement l'apprenant à « s'interroger sur son système de valeurs et à le confronter à celui des autres ».

À vous de jouer – Question 2

Pourquoi une conférence sur l'équilibre alimentaire change-t-elle rarement les comportements ?

Corrigé

Parce que l'information agit surtout sur les **connaissances** et l'**attitude**, peu sur les **normes** du groupe, le **contrôle perçu** (compétences, moyens) et les **habitudes** ; elle ne crée pas d'**engagement**. Lewin a montré que la discussion de groupe et la décision collective étaient bien plus efficaces ; Bandura, que l'expérience de réussite développe l'efficacité personnelle. Une action participative et pratique (atelier culinaire) est donc préférable.

À vous de jouer – Question 3

Les techniques d'engagement sont-elles une forme de manipulation ?

Corrigé

Elles peuvent l'être si elles sont utilisées à l'insu de la personne et contre son intérêt (marketing). En éducation pour la santé, leur usage est **éthique** si l'objectif est l'intérêt de la personne, si elle reste **libre** (sentiment de liberté explicite), si le professionnel est **transparent** sur ses intentions et si l'objectif est choisi par la personne elle-même. C'est la différence entre manipulation et accompagnement du pouvoir d'agir.

3.8.4 Étude de cas

Mise en situation – Étude de cas – Un club de football de jeunes

L'éducateur d'un club de football (garçons et filles de 13 à 16 ans) observe : boissons énergisantes avant les matchs, une joueuse qui « saute des repas pour être plus légère », moqueries sur le poids d'un gardien, défis alimentaires repris des réseaux sociaux. Il vous sollicite.

1. Identifiez les phénomènes psychosociaux en jeu.
2. Quelles CPS faudrait-il développer chez ces jeunes ?
3. Proposez une action en 3 séances.
4. Que faites-vous concernant la joueuse qui saute des repas ?
5. Comment impliquer les parents et l'éducateur ?

Corrigé

1. Influence des pairs et **conformisme** (boissons énergisantes, défis), **socialisation secondaire** par les réseaux sociaux, **insatisfaction corporelle** et risque de restriction (joueuse), **stigmatisation** du poids (gardien), construction de l'**identité** adolescente.

2. Pensée critique (analyser publicités et défis), **affirmation de soi** et communication constructive (refuser), **conscience et régulation des émotions**, **estime de soi**, **relations constructives** (respect dans l'équipe).

3. Séance 1 « Mon carburant » : besoins du sportif, collation avant l'effort (atelier pratique), hydratation. Séance 2 « Décrypter » : analyse d'une publicité et d'un défi viral, débat, élaboration de règles de l'équipe. Séance 3 « Respect » : jeu de rôle sur les moqueries, charte d'équipe signée par tous (engagement), valorisation des forces de chacun.

4. Ne pas en parler devant le groupe ; signaler la situation à l'éducateur et aux parents avec tact, en conseillant une consultation (médecin, diététicien, médecin du sport), car il peut s'agir d'un signe de **trouble du comportement alimentaire** ou de déficit énergétique ; je ne pose pas de diagnostic.

5. Réunion d'information des parents (collations, boissons, repérage des signes d'alerte), outils pour l'éducateur (charte, consignes sur les commentaires corporels), éventuellement un temps convivial avec dégustation de collations.

3.8.5 Mises en situation express

Mise en situation – MSE 1

Un participant refuse de goûter : « Chez nous, on ne mange pas ça. »

Corrigé

Je respecte son refus sans insister, je lui demande ce qu'on mange chez lui et s'il veut partager une recette ; je lui propose un rôle (préparer, sentir, décrire) ; la porte reste ouverte pour une prochaine fois.

Mise en situation – MSE 2

Le jury : « Qu'est-ce que la socialisation secondaire ? Exemple dans votre projet. »

Corrigé

La socialisation qui se poursuit après l'enfance par l'école, les pairs, le travail, les médias. Dans mon projet, les enfants réclamaient des produits vus à la cantine et chez les copains : c'est la socialisation secondaire qui influence la famille.

Mise en situation – MSE 3

Une mère dit avoir honte de « mal nourrir » ses enfants.

Corrigé

J'écoute, je reformule son émotion (« vous vous inquiétez pour vos enfants »), je valorise ce qu'elle fait déjà de favorable, je propose des solutions concrètes et accessibles ; je ne renforce pas la culpabilité.

Mise en situation – MSE 4

Comment développer le sentiment d'efficacité personnelle en atelier ?

Corrigé

Faire réaliser la recette par les participants (expérience de réussite), montrer des pairs qui réussissent (témoignages), encourager, créer un climat détendu, choisir des recettes simples au début.

Mise en situation – MSE 5

Un adolescent se moque du poids d'un camarade pendant l'atelier.

Corrigé

J'interviens immédiatement et calmement pour rappeler la règle de respect, je recentre l'activité, je reparle à l'adolescent en aparté, et je veille à ce que le camarade ne soit pas exposé.

Mise en situation – MSE 6

Quelle est la différence entre acculturation spontanée et planifiée ?

Corrigé

Spontanée : changement non dirigé, par le contact quotidien (adopter les produits du supermarché). Planifiée : changement organisé volontairement par une institution (programme d'éducation alimentaire, cantine).

Mise en situation – MSE 7

Votre tutrice veut afficher « 70 % des enfants du quartier sont en mauvaise santé à cause de leur alimentation ».

Corrigé

Ce message est stigmatisant et probablement inexact ; je propose un message positif fondé sur une norme favorable ou un conseil concret (« les goûters maison, c'est bon et pas cher »), et je vérifie la donnée.

Mise en situation – MSE 8

Pourquoi ne pas utiliser le dessert comme récompense ?

Corrigé

Parce que cela valorise le dessert et dévalorise l'aliment à manger « pour avoir droit » au dessert ; à long terme, l'enfant préfère encore plus l'aliment récompense.

Mise en situation – MSE 9

Qu'est-ce que l'écoute active ?

Corrigé

Écouter avec attention, sans juger ni interrompre, en montrant qu'on a compris (reformulation, questions ouvertes, attention au non verbal) ; elle fait partie des CPS sociales et des indicateurs de C3.5.

Mise en situation – MSE 10

Le jury vous demande quel modèle du changement vous avez utilisé.

Corrigé

Par exemple Ajzen : j'ai agi sur l'attitude (dégustation), les normes (décision en groupe, conjoints invités) et surtout le contrôle perçu (cuisiner soi-même, recettes rapides et peu coûteuses).

Mise en situation – MSE 11

Une résidente d'EHPAD ne mange plus depuis l'entrée en établissement.

Corrigé

Je pense aux dimensions psychosociales (perte de repères, tristesse, isolement, perte de l'identité de « cuisinière ») ; je propose avec l'équipe de recueillir ses goûts, de l'associer à une activité culinaire, de favoriser la convivialité, et je signale la perte d'appétit (risque de dénutrition, dépistage).

Mise en situation – MSE 12

Un collègue dit : « Les gens savent ce qu'il faut manger, ils ne font pas d'efforts. »

Corrigé

Savoir ne suffit pas : le comportement dépend aussi des normes, des émotions, des habitudes, du contrôle perçu et des déterminants sociaux. Je propose de s'appuyer sur des approches participatives et sur l'environnement plutôt que sur la volonté individuelle.

3.8.6 Exercices complémentaires

À vous de jouer – Exercice 11 – Calculer des scores de Likert

Échelle de 4 items (1 à 5) sur l'attitude envers l'eau du robinet : I1 « L'eau du robinet est bonne pour la santé » (+) ; I2 « L'eau du robinet a mauvais goût » (−) ; I3 « Je fais confiance à l'eau de ma commune » (+) ; I4 « L'eau en bouteille est plus sûre » (−). Réponses de 3 personnes : P1 : 4, 2, 4, 2 ; P2 : 2, 5, 1, 5 ; P3 : 3, 3, 4, 3. Calculez les scores sur 100 et la moyenne.

Corrigé

Inversion des items négatifs (6 − réponse). P1 : 4 + (6 − 2) + 4 + (6 − 2) = 4 + 4 + 4 + 4 = **16** ; sur 100 : (16 − 4) / (20 − 4) × 100 = 12 / 16 × 100 = **75**. P2 : 2 + 1 + 1 + 1 = **5** ; (5 − 4) / 16 × 100 = **6,25**. P3 : 3 + 3 + 4 + 3 = **13** ; (13 − 4) / 16 × 100 = **56,25**. Moyenne : (75 + 6,25 + 56,25) / 3 = 137,5 / 3 = **45,8 / 100**. P2 est très défavorable : l'écouter sur ses raisons (goût de chlore, méfiance) avant d'informer (qualité contrôlée, carafe au réfrigérateur pour atténuer le goût).

À vous de jouer – Exercice 12 – Reformuler

Proposez une reformulation simple et une reformulation reflet pour : a) « Je n'ai pas le temps de cuisiner le soir, je rentre à 19 h » ; b) « Mon médecin m'a dit de perdre du poids, mais j'en ai marre des régimes » ; c) « Les enfants préfèrent la cantine à ce que je fais. »

Corrigé

a) Simple : « Vous rentrez tard et le temps manque pour cuisiner. » Reflet : « Ça a l'air épuisant, ces soirées. » b) Simple : « On vous a conseillé de perdre du poids, et les régimes ne vous conviennent plus. » Reflet : « Vous semblez découragé(e) par les régimes. » c) Simple : « Vos enfants apprécient les repas de la cantine. » Reflet : « Ça vous peine un peu qu'ils préfèrent la cantine. »

À vous de jouer – Exercice 13 – Balance décisionnelle

Une étudiante hésite à remplacer son soda quotidien par de l'eau aromatisée maison. Pour : économie (4), moins de sucre (3), meilleure peau (1). Contre : perte du plaisir (4), habitude avec les amis (3), préparer la bouteille (2). Calculez la balance, interprétez et proposez deux actions sur les « contre ».

Corrigé

Pour : 4 + 3 + 1 = **8** ; contre : 4 + 3 + 2 = **9** ; écart : 8 − 9 = **− 1** : légère dominante du statu quo, ambivalence. Actions : réduire la perte de plaisir (eau pétillante citron-menthe, soda gardé le week-end) : 4 → 2 ; préparer 3 bouteilles le dimanche : 2 → 1. Nouveau total « contre » : 2 + 3 + 1 = **6** ; écart : 8 − 6 = **+ 2**. C'est elle qui choisit ; on valorise son choix, même partiel.

À vous de jouer – Exercice 14 – Gérer des participants

Pour chaque situation, proposez une réponse d'animateur : a) M. P. coupe la parole à chaque intervention ; b) Mme S. ne dit rien depuis trois séances mais cuisine avec soin ; c) un participant affirme : « Les diététiciens disent n'importe quoi, ça change tout le temps. »

Corrigé

a) « Merci, M. P., votre expérience est précieuse ; j'aimerais maintenant entendre d'autres personnes » ; tour de parole ; lui confier un rôle (chronométrer, servir). b) Respecter son rythme ; valoriser son plat devant le groupe avec son accord ; lui proposer une question en binôme ; support non verbal (gommette). c) Accueillir : « Vous avez l'impression que les conseils changent souvent. » Puis expliquer que les repères évoluent avec les connaissances (exemple des repères de 2019) et que l'essentiel reste stable (fruits, légumes, légumes secs) ; renvoyer au groupe.

À vous de jouer – Exercice 15 – Repérer des biais dans une publicité

Une publicité pour des biscuits affiche « Source de céréales complètes – 30 % de sucres en moins » avec un sportif souriant. Identifiez les biais exploités et rédigez deux questions pour un atelier de littératie critique.

Corrigé

Effet de halo (céréales complètes, sportif → produit perçu comme sain) ; **cadrage** (« 30 % de sucres en moins » par rapport à un produit très sucré, sans valeur absolue) ; **preuve sociale** et identification. Questions : « 30

% de moins que quoi ? Combien de sucres pour 100 g ? » ; « Comparez le Nutri-Score avec celui d'une tartine de pain et de fromage. »

À vous de jouer – Exercice 16 – Motivation et récompenses

Un animateur de centre de loisirs promet un bonbon aux enfants qui goûtent la soupe. Analysez avec la théorie de l'autodétermination et proposez une alternative.

Corrigé

La récompense est une **motivation extrinsèque** : elle peut faire goûter une fois, mais elle associe la soupe à une corvée et le bonbon au plaisir, et affaiblit l'envie de goûter pour elle-même. Alternative : satisfaire l'**autonomie** (choisir entre deux soupes, se servir), la **compétence** (préparer la soupe, reconnaître les légumes) et l'**affiliation** (l'animateur goûte avec les enfants, on décrit ensemble les saveurs), avec exposition répétée et sans pression.

3.9 Glossaire

Terme	Définition
Acculturation	Changements résultant du contact continu entre groupes de cultures différentes (spontanée ou planifiée)
Attitude	Disposition favorable ou défavorable envers un objet (cognitive, affective, conative)
Compétences psychosociales	Capacités cognitives, émotionnelles et sociales qui augmentent le pouvoir d'agir et le bien-être
Conformisme	Alignement de son jugement ou comportement sur celui du groupe
Culture	Manières de penser, sentir et agir apprises et partagées, transmises entre générations
Dissonance cognitive	Inconfort lié à des cognitions contradictoires
Engagement	Lien entre une personne et ses actes, renforcé par la liberté, la publicité, la répétition
Estime de soi	Valeur qu'une personne s'attribue
Gastro-anomie	Perte des règles collectives de l'alimentation laissant le mangeur seul face à des injonctions contradictoires (Fischler)
Identité sociale	Partie de l'image de soi issue de l'appartenance à des groupes
Image corporelle	Représentation mentale de son corps (perception, pensées, émotions, comportements)
Interculturalité	Relations et échanges entre personnes de cultures différentes, fondés sur la reconnaissance mutuelle
Néophobie alimentaire	Réticence à goûter des aliments nouveaux, maximale entre 2 et 6 ans
Norme sociale	Règle de conduite attendue dans un groupe (descriptive ou injonctive)
Représentation sociale	Connaissance socialement élaborée et partagée, organisée autour d'un noyau central
Sentiment d'efficacité personnelle	Croyance en sa capacité à réaliser une action (Bandura)

Terme	Définition
Socialisation	Intériorisation des normes, valeurs et pratiques d'une société (primaire, secondaire)
Stigmatisation	Processus qui disqualifie une personne en la réduisant à un attribut (Goffman)
Syncrétisme culinaire	Combinaison d'éléments de cultures culinaires différentes
Valeur	Idéal collectif qui oriente les jugements
Ambivalence	Fait de vouloir et de ne pas vouloir changer en même temps
Balance décisionnelle	Outil listant et pondérant avantages et inconvénients d'un changement
Biais cognitif	Déviation systématique du jugement, liée aux raccourcis de pensée
Écoute active	Écoute centrée sur la personne : empathie, acceptation, congruence, reformulation
Entretien motivationnel	Style de conversation collaboratif renforçant la motivation propre au changement
Évocation hiérarchisée	Recueil de mots associés à un objet, dans leur ordre d'apparition
Habitus	Dispositions durables acquises par la socialisation, qui orientent les goûts (Bourdieu)
Motivation intrinsèque	Agir pour l'intérêt ou le plaisir de l'activité elle-même
Pair-éducation	Action éducative menée par des membres du groupe cible formés
Reformulation	Redire avec d'autres mots ce que la personne a exprimé
Style d'animation	Manière de conduire un groupe : autoritaire, démocratique, laisser-faire

3.10 Renvois bibliographiques par notion

Notion	Références
Sociologie et anthropologie de l'alimentation	[1] Fischler ; [2] Poulain ; [3] Lévi-Strauss ; [4] Bourdieu
Identité, représentations, influence	[5] Tajfel et Turner ; [6] Moscovici ; [7] Abric ; [8] Lewin ; [9] Festinger ; [10] Joule et Beauvois
Culture et acculturation	[11] Berry ; [12] Cohen-Emerique
CPS	[13] Santé publique France 2022 ; [14] OMS 1993
Image corporelle, émotions, stigmatisation	[15] Goffman ; [16] Rubino et coll.
Changement de comportement	[17] Prochaska et DiClemente ; [18] Ajzen ; [19] Bandura ; [20] Miller et Rollnick ; [21] Michie et coll.

3.12 Bibliographie numérotée

1. Fischler C. *L'Homnivore*. Paris, Odile Jacob, 1990.

2. Poulain J.-P. *Sociologies de l'alimentation*. Paris, PUF, 2002 (rééd. 2017).

3. Lévi-Strauss C. *Mythologiques I. Le cru et le cuit*. Paris, Plon, 1964.

4. Bourdieu P. *La Distinction. Critique sociale du jugement*. Paris, Minuit, 1979.

5. Tajfel H., Turner J. « An integrative theory of intergroup conflict », in Austin W., Worchel S. (dir.), *The Social Psychology of Intergroup Relations*, 1979.

6. Moscovici S. *La psychanalyse, son image et son public*. Paris, PUF, 1961.

7. Abric J.-C. (dir.). *Pratiques sociales et représentations*. Paris, PUF, 1994.

8. Lewin K. « Forces behind food habits and methods of change ». *Bulletin of the National Research Council*, 1943, n° 108, p. 35-65.

9. Festinger L. *A Theory of Cognitive Dissonance*. Stanford University Press, 1957.

10. Joule R.-V., Beauvois J.-L. *Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens*. Grenoble, PUG, 1987 (rééd.).

11. Berry J. W. « Immigration, acculturation, and adaptation ». *Applied Psychology*, 1997, 46 (1), p. 5-34.

12. Cohen-Emerique M. *Pour une approche interculturelle en travail social*. Rennes, Presses de l'EHESP, 2011.

13. Santé publique France. *Les compétences psychosociales : un référentiel pour un déploiement auprès des enfants et des jeunes*. 2022.

14. OMS. *Life skills education for children and adolescents in schools*. Genève, 1993.

15. Goffman E. *Stigmate*. Paris, Minuit, 1975 (éd. originale 1963).

16. Rubino F. et coll. « Joint international consensus statement for ending stigma of obesity ». *Nature Medicine*, 2020, 26, p. 485-497.

17. Prochaska J. O., DiClemente C. C. « Stages and processes of self-change of smoking ». *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 1983, 51 (3), p. 390-395.

18. Ajzen I. « The theory of planned behavior ». *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 1991, 50 (2), p. 179-211.

19. Bandura A. « Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change ». *Psychological Review*, 1977, 84 (2), p. 191-215.

20. Miller W. R., Rollnick S. *L'entretien motivationnel*. 2e éd. française, Paris, InterÉditions, 2013.

21. Michie S., van Stralen M. M., West R. « The behaviour change wheel ». *Implementation Science*, 2011, 6:42.

22. Watzlawick P., Beavin J. H., Jackson D. D. *Une logique de la communication*. Paris, Seuil, 1972 (éd. originale 1967).

23. Rogers C. R. *Le développement de la personne*. Paris, Dunod, 1968 (éd. originale 1961).

24. Porter E. H. *An Introduction to Therapeutic Counseling*. Boston, Houghton Mifflin, 1950.

25. Miller W. R., Rollnick S. *L'entretien motivationnel : aider la personne à engager le changement*. Paris, InterÉditions, 2e éd. française 2013.

26. Tuckman B. W. « Developmental sequence in small groups ». *Psychological Bulletin*, 1965, 63 (6), p. 384-399.

27. Lewin K., Lippitt R., White R. K. « Patterns of aggressive behavior in experimentally created social climates ». *Journal of Social Psychology*, 1939, 10, p. 271-299.

28. Deci E. L., Ryan R. M. *Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior*. New York, Plenum, 1985.

29. Kahneman D. *Système 1 / Système 2 : les deux vitesses de la pensée*. Paris, Flammarion, 2012.

30. Vergès P. « L'évocation de l'argent : une méthode pour la définition du noyau central d'une représentation ». *Bulletin de psychologie*, 1992, 45 (405), p. 203-209.

31. Tajfel H., Turner J. C. « An integrative theory of intergroup conflict ». In Austin W. G., Worchel S. (dir.), *The Social Psychology of Intergroup Relations*, 1979.

32. Bourdieu P. *La Distinction. Critique sociale du jugement*. Paris, Minuit, 1979.

Cours du CNED (contrôle de conformité, section 3.2.2)

33. CNED. *BTS Diététique – Environnement professionnel : synthèse du cours en bref*, 1re année. Réf. 3-6123-AN-WT-00-21. Futuroscope : CNED, 2021.